









مستشفيات قادرة على الصمود

إرشادات أقاليمية بشأن
تعزيز القدرة على الصمود
في مواجهة الطوارئ الصحية والكوارث
في المرافق الصحية

منظمة الصحة العالمية
إقليم شرق المتوسط

PAHO
Pan American Health Organization
World Health Organization
Americas Region

مستشفيات قادرة على الصمود
إرشادات أقاليمية بشأن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الطوارئ الصحية والكوارث في المرافق الصحية

واشنطن العاصمة، 2024

منظمة الصحة العالمية
إقليم شرق المتوسط

PAHO
Pan American Health Organization
World Health Organization
Americas Region

مستشفيات قادرة على الصمود: إرشادات أقاليمية بشأن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الطوارئ الصحية والكوارث في المرافق الصحية

Resilient Hospitals: An inter-regional guidance on strengthening resilience to health emergencies and disasters in health facilities

(النسخة الإلكترونية) ISBN 978-92-9274-773-2
(النسخة المطبوعة) ISBN 978-92-9274-772-5

© منظمة الصحة العالمية 2026

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي «نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز أن تنسخوا المصنف وتعيدوا توزيعه وتحوروه للأغراض غير التجارية، وذلك شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتعديل المصنف فيجب عندئذٍ أن تحصلوا على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي Creative Commons licence أو ترخيص يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف فينبغي أن تدرجوا بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: «هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة (WHO) غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والإصدار الأصلي بالإنكليزية هو الإصدار الملزم وذو الحجية».

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقًا لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

الاقتباس المقترح. مستشفيات قادرة على الصمود: إرشادات أقاليمية بشأن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الطوارئ الصحية والكوارث في المرافق الصحية. Resilient Hospitals: An inter-regional guidance on strengthening resilience to health emergencies and disasters in health facilities. القاهرة: المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ 2026. الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط https://iris.who.int/?locale-attribute=ar&.

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط http://apps.who.int/bookorders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات الخاصة بالحقوق والترخيص انظر الرابط http://www.who.int/about/licensing.

مواد الطرف الثالث. إذا رغبتم في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فعليكم مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام، والحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشأ نتيجة انتهاك أي عنصر في المصنف تعود ملكيته لطرف ثالث.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلًا لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك، فإن المواد المنشورة تُوزَّع دون تقديم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحةً كانت أم ضمنية. ويتحمَّل القارئ وحده المسؤولية عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل المنظمة (WHO) بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

المحتويات

شكر وتقدير ..... ح
مقدمة 1
الغرض والمستخدم المُستهدَف 2
ما المقصود بقدرة المستشفيات على الصمود؟ 2
الحصائل والآثار 4
القدرات والمكوِّنات والسياق 4
قدرات المستشفيات القادرة على الصمود 4
المكوِّنات 6
السياق 8
السمات 10
تفعيل قدرة المستشفيات على الصمود 11
المصفوفة التشغيلية لقدرة المستشفيات على الصمود 15
1 قبل: العمليات الروتينية بالمستشفيات 19
1-1 التقييم والتخطيط الاستراتيجيان للمخاطر 20
1-1-1 ما أهمية إجراء تقييم المخاطر؟ 21
2-1-1 إجراء تقييم المخاطر على مستوى المستشفى لأغراض التخطيط الاستراتيجي 21
3-1-1 أدوات تقييم المخاطر والحد منها 22
2-1 الحد من المخاطر (الوقاية والتخفيف) 23
1-2-1 التخفيف الهيكلي 23
2-2-1 التخفيف غير الهيكلي 24
3-2-1 سهولة الوصول إلى البنية الأساسية ومرونتها 25
4-2-1 نظام اعتماد المستشفيات 28
5-2-1 لجنة متعددة التخصصات لإدارة الكوارث 28
6-2-1 خطط تطوير الأعمال للمستشفى 29
7-2-1 العمليات الروتينية بالمستشفيات 29
8-2-1 عمليات المستشفيات الخضراء 30
9-2-1 خطط تنمية القدرات 30
10-2-1 التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية 31
11-2-1 نظام إدارة المعلومات بالمستشفى 32
12-2-1 برنامج الصيانة الوقائية 33
13-2-1 سلسلة الإمداد، والمخزون، واللوجستيات المتعلقة بالمشتريات 34
14-2-1 إدارة الشؤون المالية للرعاية الصحية 35
15-2-1 إدماج إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في التنمية الروتينية للموارد البشرية 35
16-2-1 أدوات وموارد الحد من المخاطر 36

3-1 التأهب 37
1-3-1 تنظيم الحيز المكاني لتفعيل الاستجابة 38
2-3-1 برنامج التأهُّب لحالات الطوارئ 38
3-3-1 تخطيط استمرارية الخدمات 39
4-3-1 خطة المستشفى للاستجابة للطوارئ بما يشمل كلَّ الأخطار 40
5-3-1 فريق إدارة الأحداث بالمستشفى 41
6-3-1 مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى 44
7-3-1 التدبير العلاجي للإصابات الجماعية وإدارة الوفيات الجماعية: 45
8-3-1 خطة التعامل مع فاشيات الأمراض السارية 47
9-3-1 المشاركة المجتمعية 49
10-3-1 التواصل بشأن المخاطر 49
11-3-1 تفعيل نُظُم الطوارئ 50
12-3-1 إدارة الأرصدة والمخزون 51
13-3-1 شراء الأدوية والإمدادات اللازمة في حالات الطوارئ وإدارتها 52
14-3-1 اتفاقات البائعين والخدمات 53
15-3-1 الآليات المالية في حالات الطوارئ 53
16-3-1 تنمية كفاءات الموظفين 54
17-3-1 تعبئة الموارد البشرية لأغراض الاستجابة 55
18-3-1 أدوات وموارد التأهب لحالات الطوارئ 56
4-1 دور المتطوعين 60
5-1 مبادرة الفرق الطبية في حالات الطوارئ 61
2 أثناء: مرحلة الاستجابة 62
1-2 تقييم الأضرار وإعادة تخصيص الحيز المكاني في المستشفى 63
2-2 رصد معلومات الإنذار المبكر 64
3-2 تفعيل خطة الاستجابة الشاملة لكل الأخطار 64
4-2 الوقاية من العدوى ومكافحتها 67
5-2 التقييم السريع للاحتياجات 67
6-2 نظام إدارة الأحداث بالمستشفى 68
7-2 عملية تخطيط إجراءات الأحداث 69
8-2 مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى 71
9-2 التواصل والتنسيق 72
10-2 تعبئة الموارد بمرونة وفي الوقت المناسب 76
11-2 معايير قائمة على الاحتياجات ومعدَّلة حسب المخاطر 77
12-2 سلامة الموظفين وأمنهم وصحتهم ورفاههم 79
13-2 أدوات الاستجابة ومواردها 80

3 بعد: مرحلة التعافي 82
3-1 التعافي 82
3-1-1 إجراءات المستشفى للتعافي 82
3-1-2 استراتيجيات التعافي القصير الأمد 85
3-1-3 تقييم الأضرار والخسائر 86
3-1-4 مرافق الخَفْض التدريجي للرعاية 87
3-1-5 خدمات إعادة التأهيل 88
3-1-6 إنهاء عمليات الاستجابة 88
3-1-7 تكنولوجيا المعلومات ونُظُم معلومات المستشفيات 89
3-1-8 التخطيط للتعافي بعد الكوارث 90
3-1-9 تحديث المخزون، وإعادة التزويد بالإمدادات، وإصلاح المُعَدَّات 92
3-1-10 تخفيف التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعافي 92
3-1-11 الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي 93
3-1-12 الحوافز المالية وغير المالية 94
3-1-13 تسريح الموظفين والمتطوعين 94
3-2 الاستعراض اللاحق للإجراءات وعملية استخلاص الدروس المستفادة 95
3-2-1 جمع المعلومات الأساسية ذات الصلة ومراجعتها 96
3-2-2 وضع أسئلة مُحفزة 97
3-2-3 تحديد مواطن القوة والتحديات والقدرات 97
3-2-4 التوصل إلى توافق في الآراء بين المشاركين 98
3-2-5 استخلاص المعلومات من فريق الاستعراض اللاحق للإجراءات 98
3-2-6 استخلاص المعلومات من إدارة المستشفيات 98
3-2-7 كتابة تقرير الاستعراض اللاحق للإجراءات 98
3-2-8 عملية استخلاص الدروس 99
3-3 أدوات التعافي وموارده 100
المراجع 101
الملحق 1 103
مسرد مصطلحات إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث 103
مراجع الملحق 1 114

قائمة الأشكال

الشكل 1. الإطار المفاهيمي لقدرة المستشفيات على الصمود.....3
الشكل 2. سمات المستشفيات القادرة على الصمود 10
الشكل 3. عملية التعلُّم المستمر..... 14
الشكل 4. مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر في المرافق الصحية 22

قائمة الجداول

الجدول 1. المراحل الثلاث لإدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث 12
الجدول 2. تصنيف منظمة الصحة العالمية للفرق الطبية في حالات الطوارئ..... 61
الجدول 3. مصفوفة تفعيل استجابة المستشفى 65
الجدول 4. الحوافز المالية مقابل الحوافز غير المالية..... 94

قائمة الإطارات

الإطار 1. المستشفيات العالمية الخضراء والصحية: عمليات إزالة الكربون في المستشفيات 30

الإطار 2. مبادئ التواصل الفعال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية 31

الإطار 3. مزايا برامج الصيانة الوقائية 33

الإطار 4. وظائف فريق إدارة الأحداث بالمستشفى 42

الإطار 5. عناصر فريق إدارة الأحداث بالمستشفى 43

الإطار 6. وظائف مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى 44

الإطار 7. عناصر مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى 45

الإطار 8. تعزيز استعداد المستشفى لحالات الطوارئ الناجمة عن الفاشيات 48

الإطار 9. إعداد رسائل التواصل بشأن المخاطر 50

الإطار 10. دليل سريع لبدء استجابة المستشفى للطوارئ 62

الإطار 11. السمات الرئيسية لخطة عمل الأحداث 70

الإطار 12. نصائح وإرشادات حول التواصل بشأن الأزمات 75

الإطار 13. المشاركة المجتمعية والتواصل أثناء التعافي 91

شكر وتقدير

هذه الوثيقة الإرشادية هي ثمرة تعاون أقاليمي بين مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط ومكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي للبلدان الأمريكية (منظمة الصحة للبلدان الأمريكية).

وهي أحد مُخرَجات التعاون المشترك بين إدارات التغطية الصحية الشاملة/ النُّظُم الصحية، والطوارئ الصحية، وتعزيز صحة السكان وهذين المكتبين الإقليميين.

وأعَدَّ هذه الوثيقة كلٌّ من جون أبو، وميريت خليل، وأليكس كاماتشو، وحميد رفاغي، بتنسيق وتوجيه تقنيين من سيرو أوغارتي، وداليا سمهوري، وسيلسو بامبارين.

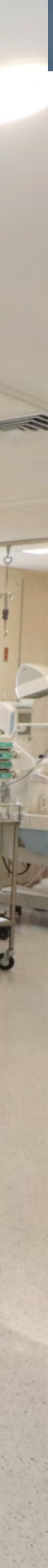
وقد خضعت لمراجعة الأقران، وأُثرِيَت بالخبرة التقنية لزملاء منظمة الصحة العالمية من مكتب المنظمة الإقليمي لشرق المتوسط: رنا الحجة، وعوض مطرية، وريتشارد بريتان، ومها العدوي، وهالة صقر، وعلي أردلان، وعثمان المحال، وجيهان البدري، وغادة الكيالي (منظمة الصحة العالمية، الأردن)، ومونيا أبو الهوى (منظمة الصحة العالمية، الأراضي الفلسطينية المحتلة)، فضلًا عن زملاء من إقليم منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/ منظمة الصحة العالمية: خوان كارلوس سانشيز، وإنريكي بيريز غوتيريز، وأماليا ديل ريغو، وفيليب كروز فيغا، وديانا ألبان، ودانيال دي خيسوس، وماوريسيو سيربا، إلى جانب هيرميس كورتيس، ومارتن أكوستا، ولورينزو بارازا، وريبالدو هولدر، وسولانجي مورا، وأليخاندرو سانتاندر، وكارولينا بينيدا، ودانا فان ألفين (مطوِّر مبادرة المستشفيات الذكية لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية)، الذين قدموا مدخلات تقنية قيِّمة في تطوير مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر في المرافق الصحية. والشكر موصول إلى الزملاء من المقر الرئيسي للمنظمة: جوناثان أبراهامز، ولي واليس، وآن ليز غيست، ومازن الملكاوي، ورشا نصر، ورضا سيف الدين، وإيلينا فيلالوبوس براتس.

وأُدرجت في الوثيقة تعليقات المهنيين المتعددي التخصصات الذين شاركوا في مختلف الاجتماعات التقنية، مثل مشاورة الخبراء بشأن قدرة المستشفيات على الصمود في عام 2022: جوناثان أبراهامز؛ وهبة علي، جامعة غريفيث (أستراليا)؛ وحميد رضا خانكه، جامعة الرفاه الاجتماعي وعلوم التأهيل (جمهورية إيران الإسلامية)؛ وأيوكو هوندا، جامعة هيتوتسوباشي (اليابان)؛ وجمال ملحم، مستشفى الجامعة الأردنية (الأردن)؛ وعلي السعد، مستشفى المقاصد (الأردن)؛ وروغر حموش، مستشفى رومية الحكومي (لبنان)؛ وقاسم السالمي، مستشفى رويال (عُمان)؛ وشاغوفتا حسن، مستشفى آغا خان الجامعي (باكستان)؛ والدكتور سعيد سراحنة، المستشفى الاستشاري في رام الله (فلسطين)؛ وتيودورو هربوزا، جامعة الفلبين (الفلبين)؛ ونبيل عاشور، جامعة أنغليا روسكين (المملكة المتحدة)؛ وريتشارد غرينهيل، جامعة تكساس التقنية (الولايات المتحدة الأمريكية).

والشكر الخاص للمركز الآسيوي للتأهب للكوارث على مساهمته التقنية في هذه الوثيقة، وعلى الدعم الذي قدَّمه في بناء قدرات المرشدين الوطنيين المعْنيين بقدرة المستشفيات على الصمود في تجريب مصفوفة قدرة المستشفيات على الصمود في بلدانهم. كما يُوجَّه شكرٌ خاص إلى المركز المتعاون مع المنظمة بشأن الخدمات الصحية القادرة على الصمود في المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي على دعمه.

في الأمريكتين، جرى توسيع نطاق التعاون من خلال ثلاث حلقات عمل تشاورية لوضع المبادرة والمفاهيم، **بواسطة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية:** ألفونسو تينوريو، باولو بايادي، ليوناردو ايرناندیز، نيكولاس لاجومارسينو، ليز بارا، ليالو ريبايوس، ماريون بويوك دوكاس، إيساني تشانج، فابيولا ميتشيل، أليخاندرا بونياديه، ماجدالينا ألكوسير، ألكسندر بايي، تشانتال كالبيل، بابلو جالييندو، خوسيه لويس بيريث، سيرخيو ألباريث، مانويل لوايثا، ويلمر ماركينيو، لاورا أوسوريو، لينين فلوريس، دونيسكي ثينترا، لويس ماثياس، فاليريا ثيبايوس، فرانكلين ايرناندیز، إدواردو أورتيث.

وبواسطة بلدان المكتب الإقليمي للأمريكتين: أنغويلا: فاليري بيتش هورن. **أنتيغوا وبربودا:** لوريان هنري جونسون. **الأرجنتين:** كارلا موريتي، كلوديا كونجيت، جابرييلا سوسا، جيسلا جامبيتا، جوستابو باريلا، باتريثيا سبينيي، سيلبيا لا روفا. **جزر البهاما:** أنوش آرمبريستر، أنطوانيت بامبرباتش، كارلين سميث-ماكنزي، شيرلين براون، تيزيل لايتبورن. **بليز:** جون بودن. **برمودا:** بريت ليفكوفيتز. **بوليفيا:** أنخيل سينوري، ليزيث جانسي. **بونير:** جين أوفلين. **البرازيل:** فلافيا كاسيلي باتشيكو. **كندا:** أندريه لا برايري، بينوا هيرمانت، كافان فان أولفت، ليام توتن، روبن ماكنيل، تيفاني سميث. **شيلي:** خيرمان كاسترو بيسنييه، باولا بونتوني ثونييجا. **كولومبيا:** نيستور لابيردي، روبرت توریاجو. **كوستاريكا:** كارلوس سالجويرو، ديزي بينيتيث، كيلور كاسترو، بريسيبا ايريرا، روثيو ساينث. **كوبا:** خوسيه بيتانكورت، خوسيه إرنستو لاباستيدا. **دومينيكا:** آنيك ويلسون، لاورا إسبريت. **جمهورية الدومينيكيان:** إدواردو رافاييل مونتانيو، خينا إستريبيا، خوسيه لويس كروث، لويس أوسوريا لارا، أوكتابيو أندريس كوماس. **إكوادور:** كريستينا خاكوميه، دييجو باييخو، إليثابيث باييخو دي سوليثيو. **السلفادور:** كارمن جوادالوبيه ميلارا، جلوريا دي كاييس، جانيت سواريث، خورخي ألبرتو راميريث، ميجيل فرانثيا. **غرينادا:** تيرينثي والترز. **غواتيمالا:** جابرييلا أوتشوا، بييداد سانشيث، خوسيه دانييل كابايو، بيرخينيا هيرثيج. **غيانا:** دينيثيا ويليامز، هورسون هاريس، لاكان سينج، ليون بيرسود، نارين سينج، فاشا باتشان، أبيجيل ليفربول، تاميكا نويل. **هايتي:** جيليان ماجلوار، جان باتريك ألفريد، ماركوس كاديت. **هندوراس:** أنخيلا لورديس سالجادو، أنطونيو لايث. **جامايكا:** كلودين جودين، ديبي كارينجتون، جايل رانجلين إدواردز، هارولد دانيلز، لورنا بوريل، نيكول دوكينز رايت، شيرلي هيبرت. **المكسيك:** أليخاندرو لوبيث سامانو، فيديريكو بيلوريا، جابرييل رودريجيث، خورخي لوريا، خورخي لويس بونثي، ساندرا إليثوندو أرجيتا. **مونتسيرات:** أرلين بونتين. **نيكاراغوا:** إدواردو بادو، خوسيه لويس نارباييث، لويس إيبان جوتيريث. **باراغواي:** كارلوس توريس ألوخاس. **بيرو:** أليثيا جارنيك ريوس، كارمينا كريستين، لوكاس كورو، ميريام سالاثار، بيدرو كريسوستومو بوما، سيلبيا بيروسبي رينا. **سانت كيتس ونيفس:** إيرين هانلي، كاترينا سميث، لاتويا ماثيو-دنكان، سيلبستر بي. **سانت فنسنت وجزر غرينادين:** سيميون دابيد يرينا. **سانت لوسيا:** جلينسفورد جوزيف. **سورينام:** أوسكار ميسونيس لابوبل. **جزر الكايمان:** داني كوملان. **جزر توركس وكايكوس:** شارلين هيجز. **جزر فرجن (البريطانية):** رودني براثويت. **ترينيداد وتوباغو:** جيريمي هاريلال، باتي آن ويليامز، بول فرانسيس. **الولايات المتحدة:** بريتني هايز، كريستوفر جونز، كريستوفر بيردو، دايرا كارفاخال. **أوروغواي:** أدريانا ألفونسو، بوني أندريس أوتازو، جاستون كاسو، ماريبلا أنشين. **فنزويلا:** راؤول كاربونيل.





وحدة الرعاية المركزة لحديثي الولادة. المستشفى العام للمنطقة (1)، المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، تاباتشولا، تشياباس، المكسيك. مركز (MEX-35) المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية القادرة على الصمود، 2023.

"

عندما تندلع الأزمات،
تنقذ المستشفيات الأرواح.

ويجب على المستشفى القادر على الصمود أن يحافظ على أدائه الوظيفي، وأن يحمي الاستثمار الذي يمثله، مع مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمجتمع المحلي دون أن يتخلف أحدٌ عن الرَّكْب.

مقدمة

تُعَدُّ المستشفيات والمرافق الصحية، في كلٍّ من حالات الطوارئ والأوضاع الروتينية، مؤسسات مجتمعية أساسية ومنارة أمل للأشخاص الذين يلتمسون الحصول على خدمات صحية (1). وتمثل نُظُم المستشفيات قدرًا كبيرًا من الاستثمار من جانب البلدان، ويشمل ذلك القطاع الخاص. وفي العديد من البلدان، تمثل المستشفيات ونُظُم المستشفيات، التي تُعد رمزًا للرفاه والضمان الاجتماعيين، ما يصل إلى 70% من ميزانية الحكومة المُخصَّصة للصحة (2).

وقد أسهمت جائحة كوفيد-19، مقترنةً بتزايد تواتر الكوارث وحالات الطوارئ وآثارها الصحية، في اعتراف غير مسبوق بأهمية القدرة على الصمود. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن البيّنات والمؤلَّفات العالمية بشأن قدرة المستشفيات على الصمود لا تزال ناشئة ومتباينة، فقد وضع الباحثون إطارًا مفاهيميًا كنقطة انطلاق لتفعيل هذه المفاهيم الديناميكية والدائمة التطور (3).

ويمكن بشكل عام وصف القدرة على الصمود بأنها القدرة على استيعاب صدمات مختلفة غير متوقعة، والتكيف معها، وتحويلها، والتعافي منها (1). وعند تطبيق ذلك على إدارة مخاطر الكوارث في المستشفيات، فإنه يُترجَم إلى قدرة المستشفى أو المرفق الصحي على تحمُّل أثر الخطر (سواء كان طبيعيًّا أو بفعل الإنسان، ويشمل ذلك الأخطار البيولوجية) الذي يهدد بتعطيل الخدمات الروتينية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأداء الوظيفي للخدمات الصحية الحيوية والتعافي وصولًا إلى حالتها الأصلية. وقد أظهرت التجارب السابقة أن المستشفيات تستطيع - بل ويمكنها - أن تتعلم الحد من مخاطر الكوارث، وتحسين جهود الاستجابة في المستقبل.

ولا يُعد تحسين قدرة المستشفيات على الصمود أمرًا أساسيًّا لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية أثناء حالات الطوارئ فحسب، بل يقلل أيضًا من أوجه الضعف والتحديات وأوجه عدم المساواة، ويُسهم في التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي العالمي والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والاستدامة والإنصاف في مجال الصحة (3).

وليس غريبًا أن تجد المستشفيات نفسها في وقت واحد في مراحل مختلفة من دورة إدارة مخاطر الكوارث، مثل التأهب لأحداث متعددة و/ أو أخطار مختلفة والاستجابة لها. وإدراكًا منها للطبيعة الديناميكية لقدرتها على الصمود وتنوع أحداث الكوارث وشدتها، تواصل المستشفيات جهود التحوُّل والتكيف والتعلُّم بهدف الحفاظ على أدائها الوظيفي، وتقديم الخدمات الحيوية المُنقِذة للحياة بجودة عالية ودون توقف إلى الفئات الأكثر تضررًا.

ويُعدُّ تعزيز قدرات المستشفيات على التأهب والاستجابة والتعافي أمرًا ضروريًّا للتخفيف من عواقب الأخطار. ومع ذلك، فإن القول أسهل من الفعل، نظرًا إلى التحديات الحالية والتنفيذات السياقية لعمليات الرعاية الصحية. ولمواجهة هذه التحديات، يجب على المستشفيات تطوير القدرات والموارد اللازمة، وتدريب الموظفين قبل وقوع أي حالة طارئة. وفي كثير من الأحيان، يجب أن تتنافس إدارة مخاطر الطوارئ والكوارث في المستشفيات مع عملها الروتيني وأولوياتها، وهو ما يزيد من استنزاف موارد المستشفيات. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يحظى الحد من المخاطر والتأهب لها بقدرٍ أقل من الاهتمام.

وتؤكد الإرشادات الواردة في هذا المنشور على كيفية دمج الإجراءات الرئيسية في النظم التشغيلية الروتينية للمستشفى ووظائفه وخدماته على نحو يعزز كيفية تأهب المرفق لطائفة من الأخطار والاستجابة لها والتعافي منها، ومنها الأوبئة والجوائح، مع إعادة البناء على نحو أفضل.

الغرض والمستخدم المُستهدَف

تهدف هذه المبادئ التوجيهية التشغيلية إلى تقديم توصيات بسيطة وعملية من شأنها أن تعزز قدرة المستشفيات على الصمود عبر جميع مراحل إدارة مخاطر الكوارث: قبل حدوث أي طارئة صحية أو كارثة وأثناءها وبعدها.

وقد وُضِعت هذه الإرشادات ليستخدمها مديرو المستشفيات، ورؤساء أقسام المستشفيات، وأعضاء لجان إدارة الطوارئ بالمستشفيات، ويشمل ذلك خدمات الدعم والإدارة، والسلطات المالية والصحية المسؤولة عن تخطيط وتنسيق إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في المرافق الصحية.

ما المقصود بقدرة المستشفيات على الصمود؟

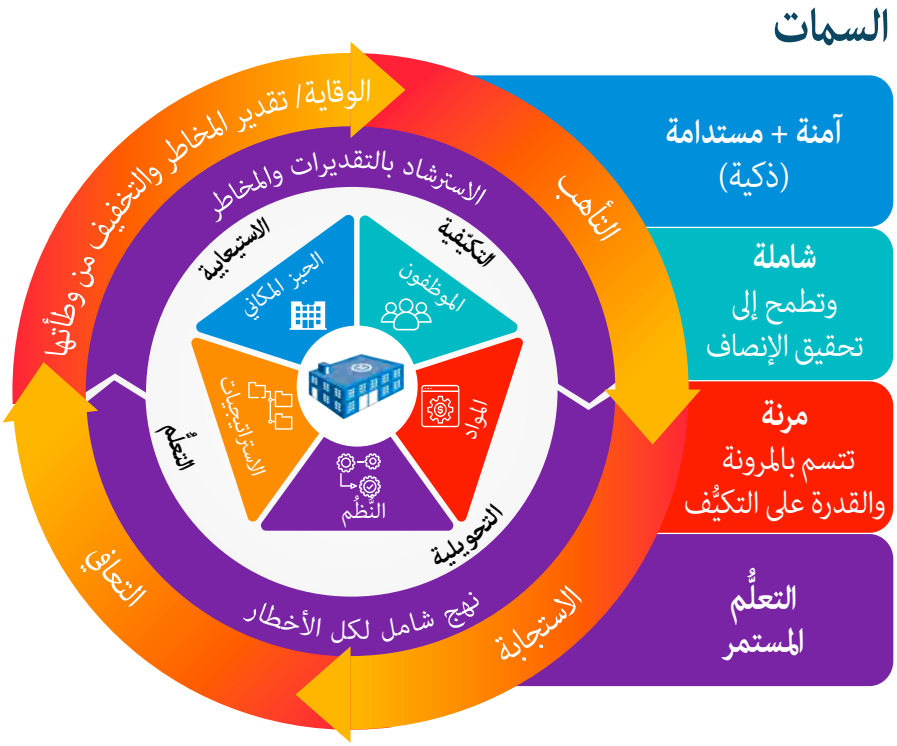
استنادًا إلى البحوث المستفيضة والمساهمات الواردة من مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، تساعد المعلومات التالية على وضع تصور لقدرة المستشفيات على الصمود من خلال عرض السياق، واستخدام لغة مشتركة. وسيمكّن هذا بدوره المستخدمين من تفعيل الإرشادات الواردة في هذه الوثيقة.

وفي أيار/ مايو 2022، استضاف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مشاورة خبراء جمعت بين واضعي السياسات العالمية والإقليمية المتعددي التخصصات، ومديري المستشفيات، والأكاديميين، وممثلي المنظمة للتحقق من مسودة إطار عمل قدرة المستشفيات على الصمود، ومناقشة التدخلات اللازمة لتفعيله وتقييمه (4). وكان هذا الإطار المفاهيمي (الشكل 1) بمثابة نقطة انطلاق لمناقشات مستقبلية بشأن تعزيز قدرة المستشفيات على الصمود، مع تحديد مكوِّنات قدرة المستشفيات على الصمود وقدراتها وسماتها، علاوةً على حصائلها الأوَّلية وآثارها اللاحقة.

وباتت المستشفيات القادرة على الصمود جزءًا من النُّظُم الصحية وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود، ويعتمد بعضها على بعض. ويوضح الشكل 1 أن المستشفى القادر على الصمود له دورٌ محوري. وتستخدم المستشفيات القادرة على الصمود عدة مكوِّنات تشمل الحيز المكاني والموظفين والمواد والنُّظُم والاستراتيجيات من أجل الاستيعاب والتكيف والتحوُّل والتعلُّم، باستخدام كل هذه القدرات في وقت متزامن في بعض الأحيان.

وتتجلى قدرة المستشفيات على الصمود في جميع المراحل الأربع لدورة إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث، وتشمل: الوقاية، والتأهب، والاستجابة، والتعافي (الدائرة البرتقالية)، في إطار نهج يسترشد بالمخاطر، ويشمل كل الأخطار (الدائرة الأرجوانية). وجديرٌ بالذكر أن القدرات الأربع الأساسية للصمود تتواجد عبر جميع مراحل دورة إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث التي غالبًا ما تكون متداخلة. وتكفل هذه العملية قدرتها على تحقيق حصيلتها الأوَّلية المتمثلة في تقديم خدمات حيوية وأساسية بجودة عالية ودون توقف في خضم الأزمات، دون أن يتخلف أحد عن الركب؛ مع تباين الآثار. ونتيجة لذلك، تُظهِر المستشفيات القادرة على الصمود أربع سمات، على النحو الموضَّح على يسار الدائرة.

الشكل 1. الإطار المفاهيمي لقدرة المستشفيات على الصمود



الحصائل

يجب أن تحافظ المستشفيات القادرة على الصمود على استمرار وظائفها لأنها تقدم خدمات حيوية ومُنقِذة للحياة وأساسية بجودة عالية ودون توقف، في خضم الأزمات، دون أن يتخلف أحدٌ عن الرَّكْب

- ✔ تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية
- ✔ الحد من مواطن الضعف
- ✔ التصدي لأوجه عدم المساواة

مما يُسهم بشكل أكبر في النهوض بما يأتي:

- ✔ التغطية الصحية الشاملة
- ✔ الأمن الصحي العالمي
- ✔ الحد من مخاطر الكوارث
- ✔ التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره
- ✔ الاستدامة
- ✔ الإنصاف في مجال الصحة

المصدر: المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. مُقتبَس بتصرف من مقال بعنوان «ما المقصود بقدرة المستشفيات على الصمود؟»

الحصائل والآثار

تتمثل الحصيلة الأوَّلية للمستشفيات القادرة على الصمود في استمرارية الخدمات والحفاظ على الوظائف الحيوية للمستشفيات، إذ يجب أن تظل المستشفيات القادرة على الصمود تؤدي وظائفها، لأنها تقدم خدمات حيوية ومنقذة للحياة وأساسية بجودة عالية ودون توقف، في خضم الأزمات، دون أن يتخلف أحد عن الركب (1).

وفي هذا الإطار، تتكيف المستشفيات الأفضل أداءً مع التحديات التي تواجهها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التحديات المرتبطة بالكوارث، والسياق المتغير، وأوجه قصور النظام الصحي، وأوجه القصور الداخلية في المستشفيات. ويجب أيضًا أن تكفل المستشفيات القادرة على الصمود تقديم خدمات صحية متكاملة تركِّز على الناس. ومن خلال الخدمات الصحية المتكاملة التي تركِّز على الناس، تُسهم المستشفيات القادرة على الصمود في بناء نُظُم صحية أقوى، ومجتمعات صحية، وتنمية مستدامة.

ويصبح أثر تعزيز قدرة المستشفيات على الصمود واضحًا من خلال تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، والحد من أوجه الضعف والتحديات وعدم المساواة. وهذا من شأنه أن يُسهم أيضًا في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة، والأمن الصحي العالمي، والحد من مخاطر الكوارث، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والاستدامة، والإنصاف في مجال الصحة (3).

القدرات والمكوِّنات والسياق

قدرات المستشفيات القادرة على الصمود

من خلال الجمع بين التعاريف الأكثر شيوعًا من المؤلَّفات التجريبية، فإن المستشفيات القادرة على الصمود تتوافر فيها القدرات الأربع الآتية:

- الاستيعاب: مقاومة أو تحمل الصدمة غير المتوقعة الناجمة عن حالة طوارئ صحية أو أثر الكارثة، دون فقدان الوظيفة.
- التكيف: الاستجابة باحتياطيات أو عمليات بديلة أو استخدامها للحفاظ على الوظائف الأساسية، وتلبية الاحتياجات المجتمعية العاجلة والمُلحّة (ضمان استمرارية تقديم خدمات صحية فعالة ومأمونة وعالية الجودة، وتركز على الأشخاص).
- التحوُّل: التعافي من تعطُّل الخدمات بسرعة وبتكلفة معقولة، والحد من قابلية التأثر بالمخاطر، وتحسين الاستعداد لحالات الطوارئ المستقبلية.
- التعلُّم: مراجعة الإجراءات السابقة، والنظر في فعاليتها للاسترشاد بها في الإجراءات المستقبلية، والتحقق من الافتراضات، وإعادة النظر في هياكل التعلّم القائمة وتغييرها. ويسلط الإطار الضوء على الطبيعة الشاملة لقدرة التعلّم في جميع مراحل دورة الوقاية، والتأهب، والاستجابة، والتعافي، وكذلك من خلال القدرات الاستيعابية والتكيفية والتحويلية (3).

"

توفر الخدمات الصحية المتكاملة التي تركِّز على الناس الإتاحة الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والحماية المالية في إطار نهج قائم على الرعاية الصحية الأوَّلية، ولذلك فهي تُعتبر ذات أهمية بالغة لتحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة.

المكوِّنات

يؤثر الترابط بين المكوِّنات الستة على قدرة المستشفيات على الصمود، وتشمل: الحيز المكاني، والموظفين، والمواد، والنُّظُم، والاستراتيجيات، والخدمات. ومع اعتبار الخدمات الصحية الفعالة الحصيلة الأوَّلية، فإن التدخلات المُدرَجة في هذه الوثيقة الإرشادية تغطي المكوِّنات الخمسة المتبقية عبر دورة إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث.

الحيز المكاني

في هذا النموذج، يشمل «الحيز المكاني» المكوِّنات الهيكلية وغير الهيكلية المذكورة في مؤشر سلامة المستشفيات (5). ويشمل ذلك سلامة المبنى الفعلي وسلامته الهيكلية والمعمارية؛ وبنيته الأساسية الحيوية ونظمه الاحتياطية البديلة (أي الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والوقود والغاز وإدارة النفايات الخطرة والوقاية من الحرائق)؛ وجودة معداته الطبية وفعاليتها.

الموظفون

يصف مديرو المستشفيات العاملين الصحيين بأنهم أغلى أصولهم، وتعتمد قدرة المستشفى على الصمود إلى حد كبير على قدرتهم على الصمود. وبقدر أهمية قدراتهم المعرفية (مثل الإبداع والقيادة وصُنع القرار)، وقدراتهم الإدراكية (مثل المعرفة والكفاءات التقنية)، يجب على مديري المستشفيات أن يأخذوا بعين الاعتبار توافر العاملين الصحيين وتوزيعهم وسلامتهم، إلى جانب قدرتهم النفسية على الصمود وشعورهم بالرضا الوظيفي ودوافعهم والتزامهم بتأهب المستشفيات واستجابتها.

المواد

يشمل هذا المكوِّن: التمويل واللوجستيات وإدارة سلسلة الإمداد. ويُعد التمويل وآثاره على التوظيف واللوجستيات والإمدادات من أهم المسائل المرتبطة بقدرة المستشفيات على الصمود، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتتطلب قدرة المستشفيات على الصمود توافر التمويل أثناء حالات الطوارئ أو التمويل المرن لضمان سرعة تعبئة الموارد واللوجستيات وإدارة الإمدادات. وتتمتع المستشفيات القادرة على الصمود بالسلامة المالية، ويمكنها شراء الموارد اللازمة وتعبئتها لضمان استمرارية تصريف الأعمال والخدمات.

النُّظُم

يُشبه مكوِّن النُّظم سقف المستشفى. ويعمل هذا المكوِّن على تمكين المجالات الشاملة البالغة الأهمية من العمل، مثل: القيادة والتنسيق، ونُظُم الاتصالات والمعلومات، والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. وهذا بدوره يدعم جميع المكوِّنات الأخرى.

ويمثل مكوِّن النُّظم الجسر بين الاستراتيجيات (من الناحية النظرية) والخدمات (من الناحية العملية). ويُعد مكوِّن النظم من بين أكثر المكوِّنات أهمية، لأنه يمكّن وينسق التخطيط لمكوِّنات أخرى وإدارتها وتفعيلها مثل الموظفين والحيز المكاني والمواد والاستراتيجيات، من أجل تقديم خدمات مأمونة ومستمرة في مختلف مراحل الوقاية، والتأهب، والاستجابة، والتعافي.

ولتعزيز القدرة الناعمة للمستشفيات على الصمود، يجب على مديري المستشفيات بناء قدرات تكيفية: القيادة والتخطيط وإدارة الطوارئ. وهذا من شأنه أن يُسهم في تحديث استراتيجيات وبروتوكولات وإجراءات تسترشد بالمخاطر؛ وتوسيع نطاق التواصل والمشاركة المجتمعية أثناء حالات الطوارئ؛ والاستخدام الأمثل للبيانات والبيّنات والمعلومات؛ وإدارة اللوجستيات والإمدادات والتمويل؛ وتحفيز القوى العاملة في المستشفيات لضمان الأداء الوظيفي، واستمرارية الخدمات الأساسية المُنقِذة للحياة بجودة عالية أثناء حالات الطوارئ.

"

المستشفى الآمن هو مرفق تظل خدماته متاحة، ويعمل بأقصى طاقته، وضمن البنية الأساسية نفسها مباشرة بعد وقوع كارثة طبيعية. ويشمل مصطلح «المستشفى الآمن» جميع المرافق الصحية، بغض النظر عن مستوى التعقيد.

الاستراتيجيات

تحتاج المستشفيات القادرة على الصمود إلى استراتيجيات للتخفيف من أوجه الضعف والمخاطر وتقييمها، وخطط شاملة واستباقية للتأهب لجميع الأخطار والاستجابة لها والتعافي منها، ويشمل ذلك خططًا بشأن القدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة، واستمرارية الخدمات أثناء حالات الطوارئ. ويلزم وضع إجراءات تشغيل مُوحَّدة مُحدَّدة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، وضمان استمرارية تصريف الأعمال والأداء الوظيفي والعمليات الحيوية.

السياق

تتأثر قدرة المستشفيات على الصمود في أوقات الأزمات بعدة عوامل أوسع نطاقًا تتعلق بالنظام الصحي، منها: القدرات والحَوْكَمَة والتمويل والمعلومات والقوى العاملة والبنية الأساسية. وهذه العوامل مترابطة، ويجب أن تعمل جنبًا إلى جنب لضمان استجابة المستشفيات بفعالية لحالات الطوارئ، ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية. وتسترشد الإجراءات الرئيسية المقترحة في المصفوفة التشغيلية بالسياسات والمبادئ التوجيهية والمعايير الوطنية التي تضعها الجهات الفاعلة الوطنية، مثل وزارات الصحة والمالية والتخطيط والبيئة والتنمية الاقتصادية والحكومة المحلية ووكالات إدارة الكوارث (التي تشمل، ضمن مسؤوليات أخرى، وضع أكواد البناء ومعايير السلامة من الحرائق).

يندرج تعزيز قدرة المستشفيات على الصمود بشكل متشابك في السياق والاعتبارات المُطبَّقة لتحسين النظم الصحية الوطنية لمواجهة الكوارث، وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود.



منظر جوي لمستشفى مزود بألواح الطاقة الشمسية ونُظم تهوية (نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء). المستشفى العام للمنطقة (1)، المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، تاباتشولا، تشياباس، المكسيك. مركز (MEX-35) المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية القادرة على الصمود، 2023.

السمات

وَفقًا للخبراء في هذا المجال، فعلى الرغم من تباين سمات النظم الصحية القادرة على الصمود، إلا أن عدد السمات المرتبطة بقدرة المستشفيات على الصمود أقل (3). ويستند السياق المذكور أعلاه ومكوِّنات قدرة المستشفيات على الصمود إلى مفاهيم ومجموعات أدوات مبادرة المستشفيات الذكية، التي قامت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/ منظمة الصحة العالمية بتجريبها وتنفيذها في منطقة البحر الكاريبي على مدى العقد الماضي. وطبقًا لمجموعة أدوات المستشفيات الذكية لعام 2017، فإن المستشفيات تكون ذكية عندما تكون آمنة وخضراء. وانطلاقًا من هذا المفهوم، وَفقًا لأحدث مبادرة أطلقتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/ منظمة الصحة العالمية بشأن المستشفيات القادرة على الصمود، فإن المستشفى القادر على الصمود هو مرفق آمن وذكي/ مستدام وشامل، يتميز بالمرونة، والقدرة على التكيف، ويستطيع التعلّم من التجارب السابقة، والتعافي في الوقت المناسب وبكفاءة (6).

واستنادًا إلى الإطار المفاهيمي (الشكل 1) وأهداف مبادرة المستشفيات القادرة على الصمود، تدعم هذه الإرشادات التشغيلية السماتُ الأربعُ الآتية (الشكل 2). ويجب أن تكون المستشفيات القادرة على الصمود:

1. آمنة ومستدامة
2. شاملة (تطمح إلى تحقيق الإنصاف)
3. مرنة (تتسم بالمرونة، والقدرة على التكيُّف)
4. تتعلم باستمرار

الشكل 2. سمات المستشفيات القادرة على الصمود



المصدر: مُقتبس بتصرف من مبادرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/ منظمة الصحة العالمية بشأن «المستشفيات القادرة على الصمود في مواجهة الطوارئ الصحية والكوارث».

وتكون المستشفيات القادرة على الصمود، سواء من الناحية الهيكلية أو غير الهيكلية، قادرة على مقاومة أثر الأخطار، وإعادة تنظيم حيزها ليصبح أكثر شمولًا. ويجب أن تتسم المستشفيات القادرة على الصمود أيضًا بالمرونة، والقدرة على التكيّف والتعلّم عندما يتعلق الأمر بالمجالات الآتية: الموظفين؛ والشؤون المالية؛ واللوجستيات وسلاسل الإمداد (المواد)؛ والاستراتيجيات والقيادة؛ والتنسيق؛ والمشاركة المجتمعية؛ ونُظُم الرصد والتقييم. ويجب أن تكون قادرة على تحويل التجارب السابقة بسرعة إلى جهود للتعافي في المستقبل.

الروابط بين السمات والقدرات والمكوِّنات

تنبع قدرة المستشفيات على الصمود من العلاقات والروابط القائمة بين القدرات والمكوِّنات والسمات الموضَّحة في المصفوفة التشغيلية. على سبيل المثال، في هذه الوثيقة الإرشادية، يؤثر **مكون الحيز المكاني** (العناصر الهيكلية وغير الهيكلية للمرفق الصحي) على **سلامة** المستشفيات، وهو أحد أهداف المستشفيات القادرة على الصمود. وعادةً ما يُشار إلى سلامة المستشفيات بأنها **القدرة الصلبة للمستشفيات على الصمود**.

وترتبط أيضًا **سمات** معينة للمستشفيات القادرة على الصمود وسلامة المستشفيات بمكون الحيز المكاني. وتشمل المرفق الذي **يمكن الوصول إليه والشامل** لاحتياجات المجتمعات المحلية التي يخدمها، باستخدام نهوج تحويلية مراعية للمساواة بين الجنسين لتعزيز المستشفى والنظام الصحي، تطلعًا إلى تحقيق الإنصاف الصحي في تقديم الخدمات وفي عملياته الداخلية. ويجب أن يتكامل تقديم الخدمات الصحية الشاملة والمنصفة مع الوعي والتطبيق للمحددات الاجتماعية وأوجه عدم المساواة في السلطة التي تَحول دون حصول مستخدمي المستشفيات على الخدمات الصحية بإنصاف، لا سيما أثناء حالات الطوارئ (7).

كما يرتبط تعزيز قدرة المستشفيات على الصمود **بسمات** أخرى. فحتى يكون المستشفى آمنًا، يجب أن يكون **مستدامًا** بيئيًّا. ولا يقتصر الأمر على مجرد ضمان أن تكون المستشفيات خضراء ومراعية لتغير المناخ، بل يجب على المستشفيات المستدامة والقادرة على الصمود أن تعمل بفاعلية على التخفيف من مساهمتها في الكوارث المناخية وغيرها من الأخطار. **وتُعدّ الاستدامة المالية**، أو الحاجة إلى حماية الاستثمار وحشد الموارد على نحو مستدام للحفاظ على الأداء الوظيفي سمة جوهرية أخرى لقدرة المستشفيات على الصمود. وغالبًا ما ترتبط سلامة المستشفى **بالقدرة** الاستيعابية.

وتشمل وظائف المستشفى، التي يُشار إليها باسم **القدرة الناعمة أو التشغيلية، المكوِّنات** اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في حالات الطوارئ والكوارث. وترتبط الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الناعمة على الصمود بهذه المكوِّنات: **النُّظم** (القيادة، والمشاركة المجتمعية، والتواصل والتعلم)، **والاستراتيجيات** (السياسات والخطط)، **والمواد** (الموارد المالية والمادية)، **والموظفين** (الموارد البشرية). وتتطلب القدرة الناعمة على الصمود **سمة المرونة**، أي يجب أن تكون قيادة المستشفى مرنة، وقادرة على التكيُّف في تنسيق مختلف المكوِّنات ونقلها، ولديها القدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة لها.

وتغطي **سمة التعلم** جميع مكوِّنات المستشفى القادر على الصمود، وتستمر عبر المراحل المتداخلة في إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث. وغالبًا ما ترتبط هذه السمات بالقدرات **التكيفية والتحويلية وقدرات التعلم**.

تفعيل قدرة المستشفيات على الصمود

مع مراعاة الاعتبارات المذكورة أعلاه، تساعد الأسئلة الأربعة الآتية على تشجيع النقاش، وتُسهم في تفعيل قدرة المستشفيات على الصمود (1).

- قدرة المستشفيات على الصمود، **لأي غرض؟** تحديد **الحصيلة الأوَّلية** لقدرة المستشفيات على الصمود وآثارها. ويجب مراعاة سمات قدرة المستشفيات على الصمود عند تقييمها.

- قدرة المستشفيات على الصمود، **من أجل ماذا؟** تسليط الضوء على **النهج المنهجي المُسترشِد بالمخاطر والشامل لكل الأخطار** لتعزيز القدرة على الصمود، استرشادًا بالنهج المتكامل لمنظمة الصحة العالمية بشأن إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث.

- قدرة المستشفيات على الصمود، **من خلال ماذا؟** يساعد تعميم إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في العمليات الروتينية للمستشفيات، وإدماج الدروس المستفادة من الأحداث الحادة، وبناء القدرات الاستيعابية والتكيفية والتحويلية وقدرات التعلّم، على ضمان القدرة على الصمود **قبل** حدوث حالة الطوارئ أو الكارثة **وأثناءها وبعدها**.

- قدرة المستشفيات على الصمود، **من ماذا؟** إن تعزيز قدرة العناصر الهيكلية وغير الهيكلية في المستشفى (أو النظام الصحي)، أو أجزائه، على الصمود يسهم في قدرة النظام ككل على الصمود.

ولأغراض تفعيل قدرة المستشفيات على الصمود، توضح هذه الوثيقة الإرشادية والمصفوفة التشغيلية (انظر القسم التالي) «**من خلال ماذا**»، و«**من ماذا**» عن طريق وصف تدخلات محددة لكل مكوِّن (الحيز المكاني والموظفين والمواد والنظم والاستراتيجيات والخدمات) عبر مراحل دورة إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث.

ونظرًا لأن القدرات على الصمود ديناميكية بطبيعتها، فإن مراحل الوقاية، والتأهب، والاستجابة، والتعافي تتداخل في إطار إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث، ولا سيما في نُهج الأخطار المتعددة لإدارة مخاطر الكوارث. ومن أجل تبسيط هيكل هذه الوثيقة الإرشادية، واسترشادًا بالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن قدرة النظم الصحية على الصمود والطوارئ الصحية، تُقسم إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث إلى ثلاث مراحل: (1) **قبل**، و(2) **أثناء**، و(3) **بعد** حالة الطوارئ أو الكارثة (انظر الجدول 1).

الجدول 1. المراحل الثلاث لإدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث

	قبل حالة الطوارئ و/أو الكارثة (العمليات الروتينية بالمستشفيات)			أثناء حالة الطوارئ و/ أو الكارثة	بعد حالة الطوارئ و/ أو الكارثة
	تقدير المخاطر والتخطيط	**الحد من المخاطر** (الوقاية والتخفيف)	**التأهب**	**الاستجابة للطوارئ**	**التعافي**
الأهداف	**تحديد** الأخطار المحتملة، ومواطن الضعف، **وتحديد أولويات** المخاطر التي يمكن أن تعطل العمليات العادية بالمستشفيات	الوقاية من المخاطر الجديدة أو المتزايدة، **والقضاء على المخاطر القائمة أو التخفيف من وطأتها**، وتعميم إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في العمليات العادية بالمستشفيات	تطوير **القدرات للاستجابة** لأثر الأخطار والتعافي منه	إدارة **المخاطر الفعلية** للمستشفى التي لا يمكن الحد منها بفعالية	**العودة** إلى العمليات العادية في المستشفى، وإعادة البناء **على نحو أفضل**، ويشمل ذلك استخلاص الدروس المستفادة من أجل التطوير المستمر للقدرات
الروابط مع المستوى الوطني	آليات التنسيق الوطني **والمبادئ التوجيهية والاستراتيجيات والمعايير** لتعزيز النُظُم الصحية والأمن الصحي (مثل وزارة الصحة، ووكالة إدارة الكوارث، ووكالة حماية البيئة، وكود البناء الوطني/ السلامة من الحرائق، ووزارة المالية، والتخطيط، ووكالة التنمية الاقتصادية، وما إلى ذلك)				
الحصائل الأساسية: الخدمات	إنقاذ الأرواح من خلال الحفاظ على **الوظيفة (الوظائف)**، وتوفير **الجودة** (المأمونة والفعالة، والتي تركز على المريض، وتكون في الوقت المناسب، وتتميز بالكفاءة والإنصاف)، والخدمات الحيوية والأساسية المستمرة أثناء الأزمات، مع **عدم تخلف أحد عن الركب**				

قبل: العمليات الروتينية بالمستشفيات

تشمل هذه المرحلة **تقييم المخاطر والتخطيط، والحد من المخاطر، والتأهب**. ويشمل كل مجال من هذه المجالات الإجراءات الرئيسية قبل حدوث أي حالة طوارئ و/ أو كارثة.

وتتمثل الخطوة الأولى والأهم في تقييم المخاطر للاسترشاد بذلك في التخطيط (1). وتبدأ قدرة المستشفيات على الصمود بإجراء تقييم استراتيجي للمخاطر، تنظر المستشفيات من خلاله في العديد من الأخطار المحتملة ومواطن الضعف، وتُحدد المخاطر ذات الأولوية التي يجب إدارتها لتجنب تعطل خدمات المستشفيات. ويجب دمج تقييم المخاطر في العمليات الروتينية للمستشفيات، ويجب استخدامه لتحديث خطط القدرة على الصمود وتكييفها باستمرار، استنادًا إلى التقييمات المنتظمة للمخاطر التي تشمل الأخطار المتعددة (1).

ويشمل الحد من المخاطر الإجراءات الاستباقية التي تتخذها المستشفيات لإدارة المخاطر من خلال الإدارة التطلعية (الوقاية من المخاطر الجديدة أو المتزايدة) والإدارة التصحيحية (التخفيف من المخاطر الحالية أو الحد منها أو القضاء عليها) (8). ويجب على المستشفيات أن تركز على إضفاء الطابع المؤسسي على خطط الحد من المخاطر وخطط الاستعداد في إطار العمليات الروتينية للمستشفيات، مع ضمان السلامة والمرونة والشمول والتعلم، مسترشدة في ذلك بنهج يسترشد بالمخاطر، ويتصدى لكل الأخطار.

وتركز تدخلات التأهب على تطوير وتعزيز قدرة المستشفى على الاستجابة للأخطار المتعددة، والتعافي من آثارها. واسترشادًا بأُطُر إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث والأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر في المرافق الصحية (8)، يمثل التأهب بداية الإدارة التعويضية للمخاطر، التي تستمر حتى مرحلة التعافي. ويتمثل الهدف من الإدارة التعويضية للمخاطر في تعزيز قدرة المستشفى على الصمود في مواجهة المخاطر المتبقية التي لا يمكن الحد منها بفعالية.

أثناء: مرحلة الاستجابة

أثناء **الاستجابة**، تركز التدخلات والإجراءات الرئيسية على إنقاذ الأرواح، وحماية الممتلكات، واتخاذ إجراءات لتحقيق استقرار الحدث والسيطرة عليه مع تقدمه. وكما ذُكر أعلاه، فإن الإدارة التعويضية للمخاطر تمتد عبر مرحلة الاستجابة، ويتمثل الهدف الرئيسي منها في إدارة المخاطر الفعلية التي لا يمكن للمستشفى أن يُخفِضها بشكل فعال واستباقي (8). وتعتمد قدرة المستشفى ونظمه على حشد استجابة مُنسَّقة في الوقت المناسب أثناء الطوارئ على القدرات التي تُطوَّر خلال مرحلة التأهُّب. وأثناء الاستجابة، تُركِّز المستشفيات على التدخلات التي أُعِدَّت استنادًا إلى الآثار المتوقعة للأخطار؛ وتُفعل النُّظُم؛ وتُطبق الاستراتيجيات، باستخدام المعارف والمهارات الجماعية لموظفي المستشفيات لأداء أدوار ومسؤوليات متفق عليها، ومساندتها بالموارد المناسبة.

بعد: مرحلة التعافي

ينقسم التعافي إلى مجالين: التعافي والتعلُّم. وخلال مرحلة التعافي، يُشرع في تنفيذ التدخلات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل (المُوجَّهة إلى المرافق المتضررة) أثناء **التعافي المبكر وإعادة التأهيل وإعادة البناء** على التوالي. واستنادًا إلى الإدارة التعويضية للمخاطر، تُركِّز التدخلات والإجراءات الرئيسية للتعافي على إعادة تفعيل الخدمات الصحية الأساسية وعمليات المرافق وتعزيزها من مرحلة الانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى العمليات الروتينية والمُحسَّنة (8). ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تنظيف المرافق، وإصلاحها، وإعادة الوظائف والخدمات العادية للمستشفيات، وضمان أن يكون الموظفون في الحالة البدنية والنفسية السليمة للعودة إلى الواجبات والوظائف الروتينية.

وتتحقق قدرة المستشفيات على الصمود نتيجةً لعملية التعلم المستمر، كما يتضح من التحسينات الملموسة التي تحدُّ من مخاطر الكوارث، وتزيد قدرات المستشفيات بمرور الوقت. وتسلط مرحلة التعافي الضوءَ على أهمية تحديد الدروس المستفادة، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية من خلال الاستعراضات اللاحقة للإجراءات، وتخطيط الإجراءات التصحيحية، على النحو الموضح في الإطار المفاهيمي بشأن قدرة المستشفيات على الصمود (الشكل 1).

ويوضح الشكل 3 أن قدرة المستشفيات على الصمود تنتج عن ممارسة دائمة ومستمرة لتحديد الدروس المستفادة، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.

الشكل 3. عملية التعلُّم المستمر



المصفوفة التشغيلية لقدرة المستشفيات على الصمود

تُقسم المصفوفة التشغيلية لقدرة المستشفيات على الصمود إلى ثلاث مراحل: قبل حدوث حالة الطوارئ أو الكارثة، وأثناءها، وبعدها. وتعرض المصفوفة الإجراءات والتدخلات الرئيسية للمكونات الخمسة التالية: الحيز المكاني، والموظفين، والمواد، والنظم، والاستراتيجيات.

			قبل حالة الطوارئ و/أو الكارثة (العمليات الروتينية بالمستشفيات)		أثناء حالة الطوارئ و/ أو الكارثة	بعد حالة الطوارئ و/ أو الكارثة
			تقدير المخاطر والتخطيط	الحد من المخاطر (الوقاية والتخفيف)	التأهب	الاستجابة للطوارئ	التعافي
الأهداف			**تحديد** الأخطار المحتملة، ومواطن الضعف، **وتحديد أولويات** المخاطر التي يمكن أن تعطل العمليات العادية بالمستشفيات	الوقاية من المخاطر الجديدة أو المتزايدة، **والقضاء على المخاطر القائمة أو التخفيف من وطأتها**، وتعميم إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في العمليات العادية بالمستشفيات	تطوير **القدرات للاستجابة** لأثر الأخطار والتعافي منه	إدارة **المخاطر الفعلية** للمستشفى التي لا يمكن الحد منها بفعالية	**العودة** إلى العمليات العادية في المستشفى، وإعادة البناء **على نحو أفضل**، ويشمل ذلك استخلاص الدروس المستفادة من أجل التطوير المستمر للقدرات
الروابط مع المستوى الوطني			آليات التنسيق الوطني **والمبادئ التوجيهية والاستراتيجيات والمعايير** لتعزيز النُّظُم الصحية والأمن الصحي (مثل وزارة الصحة، ووكالة إدارة الكوارث، ووكالة حماية البيئة، وكود البناء الوطني/ السلامة من الحرائق، ووزارة المالية، والتخطيط، ووكالة التنمية الاقتصادية، وما إلى ذلك)				
الحصائل الأساسية: **الخدمات**			إنقاذ الأرواح من خلال الحفاظ على **الوظيفة (الوظائف)**، وتوفير **الجودة** (المأمونة والفعالة، والتي تركز على المريض، وتكون في الوقت المناسب، وتتميز بالكفاءة والإنصاف)، والخدمات الحيوية والأساسية المستمرة أثناء الأزمات، مع **عدم تخلف أحد عن الركب**				
القدرة الصلبة على الصمود	**الحيز المكاني** يشمل كلًا من العناصر الهيكلية (البناء) وغير الهيكلية (البنية الأساسية)	تقدير استراتيجي للطوارئ ومخاطر الكوارث في المستشفيات	تنفيذ **التخفيف الهيكلي** (مثل التحديث، والجدران المانعة لانتشار النيران، وحواجز الفيضانات). واتباع أكواد التصميم ومتطلبات كود البناء الآمن للمرافق الجديدة.		تحديد واختبار **المجالات التشغيلية الرئيسية** لمدى استعداد المستشفى واستجابته (مثل مسارات الإجلاء، ومناطق السلامة، واستقبال المرضى وفرزهم، والعزل، وإزالة التلوث، وتوسيع نطاق الحيز المكاني، ومواقع الرعاية البديلة، ومركز عمليات الطوارئ بالمستشفى، واللوجستيات).	إجراء **تقدير سريع للأضرار**	التنظيف وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمرافق (المدى القصير - المتوسط - الطويل)
		تقدير الأخطار ومواطن الضعف	تنفيذ **تدخلات غير هيكلية للتخفيف** فيما يتعلق بالبنية الأساسية ونظم التشغيل الاحتياطي (مثل حماية المعدات الحيوية بالمستشفى، والمرافق، وشرايين الحياة من حيث الجودة والأداء الوظيفي: الطاقة، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي، ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والوقود، والغاز، وإدارة النفايات الخطرة، والحماية من الحرائق، ويشمل ذلك المصادر البديلة)				استعادة النظم الحيوية مثل الكهرباء والاتصالات والمياه والنفايات والغازات الطبية ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (المدى القصير - المتوسط)
							بناء مستشفى آمن + أخضر جديد وفقًا لأكواد البناء (المدى الطويل)
		تقييم قدرات العمليات الروتينية وعمليات الطوارئ	تقييم **سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البنية الأساسية** وتدخلات الحد من المخاطر بالنسبة لهم			التحلي بالمرونة في توسيع المساحات المتاحة واستخدامها وإعادة توظيفها لغرض آخر	إعادة المساحات التي أعيد توظيفها لغرض آخر إلى وظيفتها الطبيعية واستعمالها بشكل طبيعي (المدى القصير - المتوسط)
							ضمان تصميم المرافق الصحية بحيث تلبي احتياجات المجتمع المحلي (مثل خصوصية المرأة، وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك).
القدرة الناعمة على الصمود	**الاستراتيجيّات** السياسات والخطط والتنسيق، ويشمل ذلك التنوع والإنصاف والإدماج	آلية التنسيق مع السلطات المحلية	إدماج إدارة مخاطر الكوارث في **نُظُم اعتماد المستشفيات**/ إعادة اعتماد المستشفيات وإصدار التراخيص (وإعادة الترخيص) لعمليات المستشفيات العامة والخاصة على حدٍ سواء			رصد **معلومات الإنذار المبكر** الواردة على سبيل المثال من وكالات خدمات الأرصاد الجوية وإدارة الكوارث والصحة العامة.	التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكر ومراجعتها وتوثيقها، ويشمل ذلك الإجراءات المتخذة.
		تقدير احتياجات المجتمع المحلي، وتشمل احتياجات الفئات السكانية المستضعفة	تعزيز **خدمات الطوارئ الروتينية** في وحدة الطوارئ والتنسيق مع الأقسام الأخرى في المستشفى (مثل التدبير العلاجي للرضوح، والأمراض السارية، والفرز الروتيني).		وضع **برنامج للتأهب للطوارئ** يتضمن خطة عمل سنوية، وموارد، وأهداف، وميزانية (مثل الاستجابة المسترشدة بالمخاطر، والتخطيط للتعافي، وإجراءات التشغيل الموحدة، وبرنامج تدريبي للاستجابة، وتوفير الموارد، والتنسيق الخارجي، والشراكات، وتمارين المحاكاة).	تفعيل خطط الاستجابة وإجراءات التشغيل الموحدة على مستوى المستشفى ككل حسب المسببات القائمة (ويشمل ذلك الآليات التشغيلية للتنسيق، واستمرارية الخدمات، والإصابات الجماعية، وإدارة الوفيات).	تقليص إجراءات الاستجابة وتفعيل خطة التعافي.
الاستعراض اللاحق للإجراءات وتخطيط الإجراءات التصحيحية (توثيق الدروس المستفادة والتحسينات)							

وضع خطط وبرامج واستراتيجيات **مسترشدة بالمخاطر** لتطوير الأعمال، ويشمل ذلك العمليات المتعلقة بالميزانية	تعميم منظور الإعاقة والإنصاف والإدماج في التأهب.			وضع خطط العمل الخاصة بالأحداث وتقييمها وتحديثها لتنفيذ أنشطة الاستجابة، مع ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.	
تعزيز **تدخلات المستشفيات الذكية (الآمنة + الخضراء)**، ومنها الخطط والاستراتيجيات وآليات التنسيق لإزالة الكربون من العمليات الروتينية للمستشفيات (مثل إدارة النفايات، والطاقة المتجددة، وشراء منتجات مستدامة)	وضع خطط بشأن استمرارية الخدمات وإجراءات التشغيل الموحدة (مثل فريق التخطيط، وتحديد الخدمات والوظائف الحيوية، وتحديد مواقع الرعاية البديلة، ونُظُم النسخ الاحتياطي للمعلومات والبيانات).				
تعزيز **خدمات الدعم بالمستشفى** عن طريق وضع إجراءات تشغيلية محدَّثة وخطط تنمية القدرات لتنفيذ العمليات الروتينية (مثل الصيانة والهندسة، والنظام الغذائي، والأشعة، والمختبر، والأمن، والإدارة، والإمدادات المركزية، والصيدلية، وخدمات التنظيف، وغير ذلك).	كجزء من خطط الاستجابة لجميع الأخطار في المستشفى، تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل من **فريق إدارة الأحداث بالمستشفى** ومركز عمليات الطوارئ بالمستشفى.			**الوقاية من العدوى ومكافحتها** والترصُّد **مسارات الإحالة** (الداخلية والخارجية)	
	وضع **خطة بشأن فاشيات الأمراض السارية** (مثل نظام الترصد بالمستشفى، والعزل، والفرز، والتدبير العلاجي للحالات، وتنسيق الصحة العامة، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والإبلاغ).				
تعزيز خطط تنمية قدرات المستشفى في مجال خدمات المستشفى وقيادته (مثل الموارد البشرية، وإدارة سلسلة الإمداد، وإدارة الشؤون المالية والتدبير العلاجي السريري، وإدارة مخاطر الكوارث).	وضع **خطة للتدبير العلاجي للإصابات الجماعية** (مثل استقبال المرضى وفرزهم، ورعاية الإصابات، والرعاية الحرجة، والجراحة، والقدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة) **وخطة لإدارة الوفيات الجماعية** (مثل التنسيق، وتحديد الهوية، والمشرحة، والمسائل القانونية، وعودة الجثامين إلى الأسر، ومعدات الوقاية الشخصية، وما إلى ذلك).	إجراء تقدير سريع لاحتياجات الاستجابة	تقدير الأضرار والخسائر (المدى المتوسط - الطويل)		
التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. إقامة **روابط مع وسائل الإعلام المحلية**، والمشاركة في أنشطة العلاقات العامة الروتينية (أي، المسؤولية الاجتماعية للشركات). ضمان **إتاحة المعلومات** والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة والسكان الأصليين والفئات الأخرى					
تعزيز **رسائل السلامة** باستخدام الملصقات، والمنشورات، والحملات الإعلامية، وما إلى ذلك (مثل السلامة من الحرائق، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والسلامة الكيميائية، والأمراض السارية)	إنشاء **برامج توعية مجتمعية** لدعم التأهب في المجتمعات المحلية، بما في ذلك إشراك الفئات المستضعفة وضمان توعية المجتمع بالخطط البديلة (مثل التدريب والتمارين وتخطيط إدارة مخاطر الكوارث المجتمعية) إعداد **رسائل الإبلاغ عن المخاطر** واختبارها وتحديثها لمختلف الفئات المستهدفة			تنفيذ استراتيجيات **التواصل بشأن الأزمات** (مثل البيانات الصحفية الصادرة عن مسؤول الإعلام، وتنسيق المقابلات الإعلامية، وإصدار رسائل السلامة الداخلية والخارجية، والإبلاغ عن المعلومات وتبادلها من خلال نظام إدارة الأحداث: • داخل المستشفى (داخليًا) • مع المرضى والمجتمعات المحلية (آليات المستشفى للتواصل الخارجي) • مع المستشفيات الأخرى، والشبكات، والأطراف الفاعلة في النظم الصحية، وعلى المستوى الوطني إطلاع المجتمعات المحلية على **منصات الخدمات البديلة** أثناء الطوارئ.	
ضمان إتاحة خدمات الدعم المناسبة والمعلومات السهلة الفهم **للفئات السكانية ذات الاحتياجات الخاصة** (مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والسكان الأصليين، وغيرهم).					
إنشاء **نظام قوي لإدارة المعلومات بالمستشفى** من أجل العمليات الروتينية به، بحيث يمكن استخدام مجموعات البيانات لتخطيط إدارة مخاطر الكوارث، والاستجابة لحالات الطوارئ والتعافي منها، والرصد والتقييم	تعزيز **التأهُّب لتفعيل نُظُم الطوارئ** (مثل التدريب، والموارد، والتنسيق، والشراكات مع المستشفيات الأخرى، والروابط مع أصحاب المصلحة الخارجيين، وتمارين المحاكاة، والبحوث المسنَدَة بالبيِّنات لتحسين الإجراءات التشغيلية).	**نظام الإنذار المبكر** (مثل مركز عمليات الطوارئ المحلي، وإدارة الأرصاد الجوية، ونظام ترصد الأمراض، وإجراءات تفعيل خطة الاستجابة، وإبلاغ معلومات الإنذار المبكر وتبادلها)	التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكر ومراجعتها وتوثيقها، ويشمل ذلك الإجراءات المتخذة.		

	النُّظم القيادة والتنسيق، وإدارة المعلومات، والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، ويشمل ذلك الرصد والتقييم، والمساءلة، والتعلم			**نظام/ فريق إدارة الأحداث بالمستشفى** (مثل تحديد أدوار ومسؤوليات فريق إدارة الأحداث، وأوراق عمل الوظائف، وإجراءات تعبئة الموارد، والتنسيق الداخلي/ الخارجي، والاتصالات، والإبلاغ، والتوثيق، واستمرارية الخدمات الأساسية، والسلامة والأمن، ورفاه الموظفين)	تفعيل إجراءات إنهاء عمليات الاستجابة في المستشفى (مثل تحديد أسباب تعطيل عمل مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى، وتجميع المعلومات والوثائق الخاصة بالاستجابة، ووضع خطة استخلاص المعلومات من أجل الاستعراض اللاحق للإجراءات).
				تفعيل **مركز عمليات الطوارئ في المستشفى**، الذي يشمل تفعيل/ تعطيل العمل، والموقع، والترتيبات البديلة، والأمن، والإعداد، والروابط الرأسية والأفقية.	الشروع في **التخطيط للتعافي**.
				تحديد ومعالجة العقبات التي تواجه سير العمل والعمليات (مثل الاكتظاظ في قسم الطوارئ) • الابتكار في تقديم الخدمات • وضع آليات ارتجاع المعلومات وتقييم تدخلات الاستجابة والتعافي. تحديد المؤشرات ومجموعات البيانات الحاسمة لتيسير اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستجابة والتعافي (مثل معدل إشغال الأسرّة، والخرائط، والموارد البشرية المكلفة بمهام، وقائمة بيانات الاتصال بالموظفين، والإمدادات/ المعدات الطبية، والأكسجين، والمياه، والوقود، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك).	
	المواد الشؤون المالية، واللوجستيات، وإدارة سلسلة الإمداد والاستدامة		**تعزيز الإدارة الروتينية للمعدات والإمدادات** (مثل الصيانة الوقائية للمعدات، وسلسلة الإمداد، ونظام اللوجستيات، ونظام المخزون، ونظام الشراء)	**إدارة الأرصدة والمخزون للأدوية والإمدادات في حالات الطوارئ**. النظر في ضرورة وضع استراتيجية للتخصيص/ التوزيع قائمة على الاحتياجات ونظم احتياطية/ بديلة مزدوجة لإدارة الإمدادات. وضع إجراءات **الشراء في حالات الطوارئ**، ويشمل ذلك الميزانية. إعداد **قائمة بالإمدادات اللازمة** في حالات الطوارئ. إبرام **اتفاقيات البائعين والخدمات**.	ضمان أن تكون تعبئة الموارد في الوقت المناسب ومرنة، مما يتيح تنفيذ عمليات استجابة مرنة إجراء تقديرات سريعة للاحتياجات. استخدام معايير قائمة على الاحتياجات ومُعدَّلة حسب المخاطر من أجل تخصيص الإمدادات والأدوية وتوزيعها واستخدامها. تفعيل اتفاقيات المساعدات والبائعين.	تحديث المخزون، وإعادة التزويد بالإمدادات. إدارة المُعدَّات (الفحص، واستبدال الأجزاء التالفة، والتنظيف، والإصلاح، والتجديد حسب الضرورة، والتخزين).
				تأمين **آليات تمويل مرنة ومستدامة للطوارئ**	التخفيف من تكاليف التعافي سواء المباشرة أو غير المباشرة (ويشمل ذلك الإصلاحات وإعادة البناء).
	الموظفون الموارد البشرية		**إدماج إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في استراتيجيات وخطط وبرامج تطوير الموارد البشرية** (مثل تحديد قدرات الموظفين ومهاراتهم، وإدراج أدوار إدارة المخاطر والكوارث في توصيفات وظائف الموظفين، وتوفير التدريب للموظفين، وتحديث دليل الموظفين).	تطوير **كفاءات الموظفين** بشأن تطبيق بروتوكولات الاستجابة وخططها وأدوارها (مثل تدريب الموظفين وتمارينهم، ويشمل ذلك المشاركة في الأنشطة المجتمعية كجزء من نظام الاستجابة الأوسع نطاقًا).	دعم **سلامة الموظفين والأسر وأمنهم وصحتهم ورفاههم** (مثل مرافق الراحة والغذاء ورصد الإجهاد النفسي (الإنهاك) وتدابير الحماية مثل معدات الوقاية الشخصية والتمنيع والتأمين والأمن/ السلامة)	الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي (مثل استخلاص المعلومات عن الإجهاد النفسي، والاستشارة، والرصد، والإبلاغ عن العلامات التحذيرية)
				إنشاء **نظام لتعبئة الموارد البشرية** من أجل الاستجابة (على سبيل المثال، وضع إجراءات التعبئة، وتحديد مدى توافر الموارد والكفاءات، وتحديد مهام وأدوار واضحة، وتحديث دليل الموظفين، واستدعاء الموظفين خارج أوقات العمل، وتقديم الدعم والحوافز مثل الأجور والراحة واعتماد المتطوعين).	**الحوافز المالية وغير المالية** (مثل الإجازات والتأمين للمطالبة بالاستحقاقات).	



تنظيم فريق لتقييم منهجيات المستشفى القادر على الصمود: مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقدير المخاطر في المرافق الصحية؛ مؤشر سلامة المستشفيات؛ إدماج منظور الإعاقة في إدارة مخاطر الكوارث بالمستشفيات. مستشفى الطوارئ في فيلا السلفادور، ليما، بيرو، 2022.

1 قبل: العمليات الروتينية بالمستشفيات

يصف هذا القسم الإجراءات الرئيسية قبل وقوع حالة الطوارئ أو الكارثة. وتنقسم هذه المرحلة إلى ثلاثة أقسام: **تقييم المخاطر والتخطيط؛ والحد من المخاطر؛ والتأهب**. وفي مرحلة ما قبل الطوارئ، تستخدم المستشفيات قدراتها على التعلُّم والاستيعاب والتكيُّف لتحديد المخاطر التي يمكن أن تعطل العمليات وترتيبها من حيث الأولوية، والوقاية منها، والتخفيف من وطأتها.

ومن شأن التقييم الشامل والسليم للمخاطر أن يُمكِّن المستشفيات من تحديد أولويات التدخلات المطلوبة، ووضع تصور لها (8). ويلي هذه الخطوة التخطيط، لتفعيل التدخلات المحددة، وإدراجها في نُظم المستشفيات وعملياتها الروتينية. وسيساعد هذا الإدراج على ضمان عدم اعتبارها تدخلات تقتضيها الظروف أو مجرد مسؤولية إضافية للموظفين.

كما يجب إدراج أنشطة الحد من المخاطر في خطط المستشفيات بشأن إدارة المخاطر والتنمية لضمان تخفيف المخاطر القائمة، وعدم ظهور مخاطر جديدة نتيجة لتقدم المنشأة ونموها.

وبالمثل، وكجزء من المرحلة السابقة للأحداث، يجري التخطيط لتدابير التأهب، وتخصيص الموارد المناسبة لدعم تنفيذها، وكذلك تنمية القدرات والإمكانات اللازمة للاستجابة والتعافي بفعالية. ويُمثل هذا بداية مرحلة الإدارة التعويضية للمخاطر، والتي تسعى من خلالها المستشفيات إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتبقية التي لا يمكن الحد منها بفعالية.

في إطار عملية التعلُّم المستمر، ينبغي للمستشفيات أن تكرر عمليات تقييم المخاطر بصفة مستمرة. وهذا من شأنه أن يمكِّن المرافق من تحديد أولويات المخاطر، وتحديث نظمها وخططها لإدارة مخاطر الكوارث. والتعلُّم المستمر هو إحدى القدرات الحيوية التي يجب على المستشفيات تطويرها للتصدي للمخاطر الجديدة والمستجدة.

1-1 التقييم والتخطيط الاستراتيجيان للمخاطر

يُعد التقييم والتخطيط الاستراتيجيان للمخاطر الخطوة الأولى نحو تحقيق قدرة المستشفيات على الصمود وإدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث (3). ويجب على المستشفيات إجراء عمليات منتظمة لتقييم المخاطر، وتشمل تقييم الأخطار وأوجه الضعف والقدرات، للاسترشاد بها في التخطيط. ويتميز التفاعل بين الأخطار ومواطن الضعف والقدرات بالديناميكية والتطور المستمر. ولذلك يجب، مع تغير المخاطر بمرور الوقت، أن ترصد المستشفيات باستمرار المشهد الآخذ في التطور، وأن تُقدر المخاطر، وتحددها، وترتب أولوياتها من أجل تكييف تدابير التأهب مع السيناريوهات المتغيرة، والحفاظ على الاستعداد للاستجابة.

وخلال هذه المرحلة، ينبغي أن تكفل المستشفيات توافر نُظُم قوية لديها للقيادة والإدارة، في الأوقات العادية وأوقات الطوارئ على حد سواء. ومن المهم أيضًا وجود آليات تنسيق واضحة ومنظمة مع السلطات المحلية، ومنها شبكات المستشفيات المجاورة؛ ووزارات الصحة والمالية والتخطيط؛ ووكالات إدارة الكوارث؛ وسلطات حماية البيئة؛ وغيرها. وبالتنسيق مع هذه الهياكل، يجب أن تُتاح للمستشفيات إمكانية الاطلاع على أحدث التقييمات للاحتياجات المجتمعية، ومنها الاعتبارات الخاصة للفئات المستضعفة.

ويُعرِّف مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الخطر بأنه احتمالية أن يكون لحصيلة ما تأثيرٌ سلبي على الناس أو النظم أو الأصول. ويمكن أن تنتج هذه التأثيرات عن أخطار طبيعية أو من صُنع الإنسان، مقرونة بظروف هشة موجودة بالفعل في المستشفى، ومنها قدرته على حشد استجابة فعالة للطوارئ في الوقت المناسب (9). وقبل أن يبدأ التخطيط، يجب على مديري المستشفيات فهم الأخطار التي قد تؤدي إلى تعطيل خدمات المستشفى وعواقبها المحتملة، سواء كانت داخلية بالمستشفى أو في المجتمع المحيط الذي يخدمه المستشفى.

وتقييم المخاطر هو عملية تهدف إلى تحديد طبيعة هذه المخاطر ومداها، عن طريق تحليل الأخطار، وتقييم ظروف الضعف الحالية التي يمكن لها، مجتمعةً، أن تُلحق ضررًا بالأشخاص والممتلكات، وتُعطل الخدمات، وتؤثر على سبل العيش والبيئة التي يعتمدون عليها. ومن ثَمَّ، فإن تقييم المخاطر جزءٌ لا يتجزأ من عمليات صُنع القرار ورسم السياسات، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف شرائح المجتمع. ويتطلب إجراء تقييم مخاطر المستشفيات التنسيق، والمشاركة مع الخبراء المتخصصين في مجالات مثل الهندسة والهندسة المعمارية والسلامة وإدارة الكوارث. ويمكن للمستشفيات أن تعتمد على عمليات التقييم السابقة التي أجْرتها السلطات المحلية عند إجراء التقييم الخاص بها.

وتُعد خرائط الأخطار ومواطن الضعف التي توضح بالتفصيل الموقع الجغرافي المحدد للمستشفى والمجتمعات المحلية أدوات مرجعية قيّمة ينبغي أن تكون متاحة من خلال السلطات المحلية لإدارة الكوارث أو نظم إدارة المعلومات. كما أن المعلومات المتعلقة بالمجتمعات المحلية ستساعد المستشفيات على توقع الاحتياجات المحتملة اللازمة للاستجابة والتأهب لها، لا سيما إذا طُلب منها تلبية احتياجات محددة للفئات السكانية المستضعفة. ويشمل هذا النوع من المعلومات قدرات المنظمات المحلية على الاستجابة (مثل إدارة الإطفاء والإنقاذ، والدفاع المدني، وإدارة الصحة المحلية، وخدمة الإسعاف)، مما يدعم استجابة المستشفيات أثناء حالات الطوارئ.

1-1-1 ما أهمية إجراء تقييم المخاطر؟

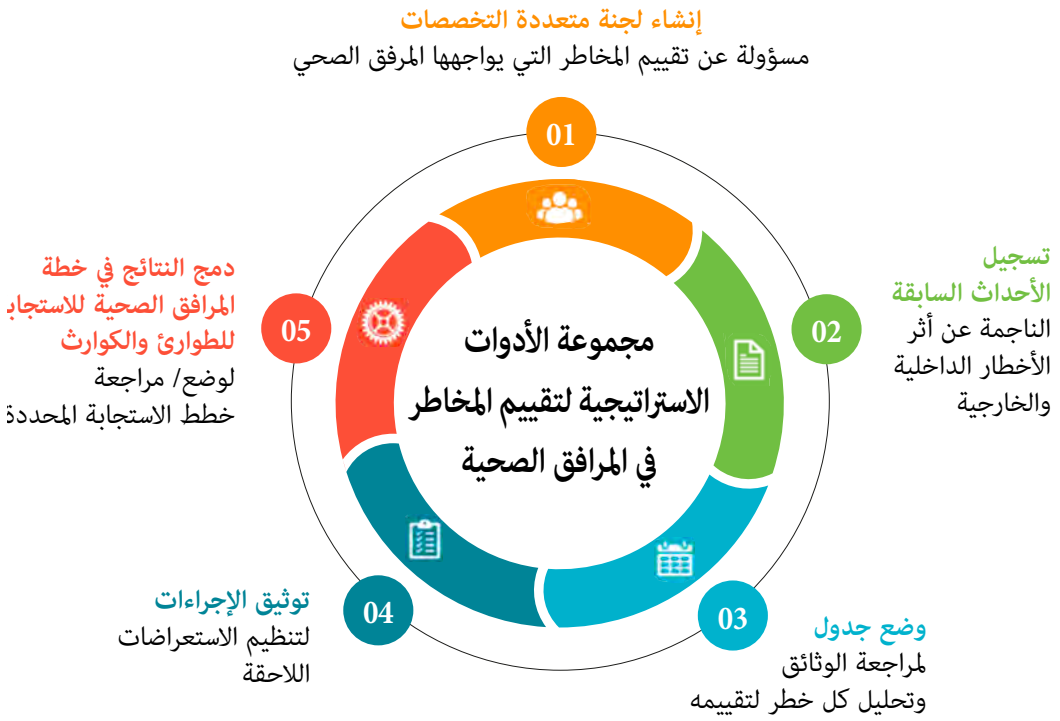
يُقدم تقييم المخاطر معلومات أساسية يجب على المستشفيات أخذها في الاعتبار وتحليلها بينما تبني قدرتها على الصمود.

- تحديد الأخطار المحتملة (الطبيعية والبيولوجية والتكنولوجية والمجتمعية)، واحتمال تأثيرها على المستشفى (حالة طوارئ داخلية) والمجتمع المحلي (أزمة خارجية) أو كليهما معًا.
- استكشاف مواطن الضعف التي تجعل أصول المستشفى (الهيكلية وغير الهيكلية ونُظم إدارة الطوارئ) أكثر عُرضة لتأثيرات الأخطار.
- تحليل العواقب المحتملة للكارثة على الناس والممتلكات (الهيكلية وغير الهيكلية) والخدمات وسُبُل العيش والبيئة، في كلٍّ من المستشفى والمجتمع.
- تحديد القدرات الحالية لإدارة أثر الأخطار، ومنها قدرة المستشفى على الحفاظ على العمليات الروتينية وعمليات الطوارئ، والقيادة والإدارة، وآليات التنسيق مع السلطات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين. ويشمل ذلك القدرات اللازمة لدعم احتياجات المجتمعات المحلية المتضررة، ومنها الفئات المستضعفة.

2-1-1 إجراء تقييم المخاطر على مستوى المستشفى لأغراض التخطيط الاستراتيجي

تُحدد مجموعة الأدوات الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية لتقييم المخاطر في المرافق الصحية نهجًا بسيطًا يتألف من خمس خطوات لتقييم المخاطر في المستشفى (انظر الشكل 4). ويصدر عن مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر في المرافق الصحية تقريرٌ يتضمن درجات الأخطار المحددة، فضلًا عن توصيات عامة لاستخدامها على النحو الملائم. وهو يشمل أربعة أبعاد للتقييم: (أ) احتمالية وقوع الخطر، و(ب) شِدَّة تأثيره على حياة شاغلي المرفق الصحي، والمرفق الصحي ذاته، وعمليات المرفق، و(ج) أوجه الضعف، و(د) القدرة على التكيف.

الشكل 4. مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر في المرافق الصحية



المصدر: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/ منظمة الصحة العالمية مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر في المرافق الصحية: (STAR-H).

3-1-1 أدوات تقييم المخاطر والحد منها

- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر في المرافق الصحية (STAR-H). واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ 2023. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/4bjK0Su.
- جامعة جون هوبكنز، كلية جون هوبكنز للطب. تقييم الاحتياجات الصحية المجتمعية. بالتيمور: جامعة جون هوبكنز؛ c2024. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3SWyC7V.
- مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. تقدير مخاطر الكوارث. نظام الحوكمة، والمنهجيات، واستخدام النتائج. جنيف: مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ 2017. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/49Ba4aq.
- منظمة الصحة العالمية. إرشادات المنظمة بشأن التخطيط لاستمرارية الأعمال. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/42gtwpU.

2-1 الحد من المخاطر (الوقاية والتخفيف)

الحد من مخاطر الكوارث هو مفهوم وممارسة تقليل مخاطر الكوارث من خلال بذل جهود منهجية لتحليل العوامل المسببة للكوارث، والحد منها. وتهدف تدخلاته إلى منع مخاطر الكوارث الجديدة، والحد من مخاطر الكوارث الحالية وإدارة المخاطر المتبقية، وكل ذلك يُسهم في تعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتُشدد مرحلة الحد من المخاطر على إدراج الحد من مخاطر الكوارث في عمليات تخطيط تطوير المستشفى، وتعزيز الأنشطة التشغيلية الروتينية لضمان سلامة المستشفى، والمرونة، والشمولية، والتعلّم. ويتطلب ذلك دراسة نقدية لتخطيط كل برنامج ونشاط ومشروع، ليس فقط من منظور تحسين عمليات المستشفيات، ولكن أيضًا كفرصة للحد من مخاطر الكوارث الحالية. وسيؤدي ذلك إلى التقليل إلى أدنى حد من قدرتها على التسبب في كوارث، وزيادة القدرة على التصدي لآثار الأخطار والتعافي منها. وخلال هذه المرحلة، تدير المستشفيات المخاطر بشكل استباقي من خلال اتباع نهجين لإدارة المخاطر، أحدهما استشرافي (الوقاية)، والآخر تصحيحي (التخفيف).

وتهدف الجهود الرامية إلى التخفيف والوقاية إلى الحد من الأضرار والمعاناة المحتملة التي يمكن أن تسببها الكوارث. وفي حين أن إدارة مخاطر الكوارث لا يمكن أن تمنع وقوع الكوارث، فإنها يمكن أن تَحول دون تفاقمها نتيجة لإهمال العوامل المسببة لها والمخاطر التي يمكن التحكم فيها. ويشير التخفيف على وجه التحديد إلى الإجراءات المُتخَذة للتخفيف من شدة أثر الكارثة. وفي كثير من الأحيان، لا يمكن منع الآثار الضارة للأخطار، ولا سيما الأخطار الطبيعية، منعًا كاملًا، ولكن يمكن لبعض الاستراتيجيات والإجراءات أن تقلل إلى حد كبير من حجمها أو وخامتها. وفي حين أنه لا يمكن القضاء على بعض مخاطر الكوارث، فإن الوقاية تهدف إلى الحد من أوجه الضعف والتعرض في السياقات التي يُزال فيها، نتيجة لذلك، خطر الكوارث. ويمكن أن يؤدي الاستثمار في تدابير الوقاية من الأخطار إلى تخفيف عبء الكوارث إلى حد كبير.

ويوصي القسم التالي باتخاذ إجراءات حسب مكونات قدرة المستشفى على الصمود، في إطار العمليات الروتينية للمستشفى.

الحيز المكاني

تنتج معظم المشاكل المتعلقة بالكوارث في المستشفيات عن الافتقار إلى السلامة والقدرة على الصمود على المستويين الهيكلي وغير الهيكلي. ومع ذلك، وبالإضافة إلى هذه العناصر، يجب على مديري المستشفيات أيضًا أن يضعوا في اعتبارهم الآثار البيئية، وأن يسعوا إلى جعل المستشفيات ليست آمنة فحسب، بل أيضًا خضراء (10) (بيئيًّا) ومستدامة ماليًّا، بالإضافة إلى كونها شاملة. وينبغي النظر في الجوانب الآتية لسلامة المستشفيات:

1-2-1 التخفيف الهيكلي

يجب أن يراعي تصميم المستشفيات الجديدة وتشييدها معلومات المخاطر المتعلقة بالأخطار في المنطقة المحيطة ونقاط الضعف في المبنى. وهذا من شأنه أن يتيح إدماج تدابير التخفيف في المرحلة المبكرة للتصميم، مما يساعد على تعزيز قدرة الهيكل على تحمل آثار الخطر.

وفي حالة مباني المستشفى القائمة التي لم تراع بشأنها معلومات المخاطر في مرحلة التصميم والبناء، لا يزال من الممكن اتخاذ تدابير للتخفيف من حدة المخاطر:

- تحديث المبنى لتعزيز هيكله الحالي بحيث يكون أكثر قدرة على مقاومة الأخطار، لا سيما الزلازل والأعاصير.
- تركيب جدران مانعة لانتشار النيران للحد من احتمالية انتشار الحرائق بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى مناطق مختلفة في المستشفى، مما يسهل قرار الإخلاء أو البقاء في المكان.
- بناء جدران للحماية من الفيضانات كحواجز للاحتواء المؤقت لمياه الجريان السطحي المتدفقة من الأنهار أو المجاري المائية الأخرى، والتي قد ترتفع إلى مستويات استثنائية أثناء الظواهر الجوية الموسمية أو القصوى.

2-2-1 التخفيف غير الهيكلي

يمكن أن يؤدي تضرر العناصر غير الهيكلية إلى شلل حاد في قدرة المستشفى على العمل، حتى وإن لم يُصب الهيكل ذاته أي ضرر. ويشمل ذلك أجزاء المبنى غير الحاملة للأحمال، مثل الجدران الخارجية والجدران الفاصلة، والنوافذ، والأسقف، والمصاعد، والمعدات الميكانيكية والكهربائية، ونظم الإضاءة، والأثاث، وما إلى ذلك. ويمكن أن يكون تعطل خدمات المستشفى بسبب الأضرار التي تلحق بالعناصر غير الهيكلية جسيمًا ومكلفًا، نظرًا لأن هيكل المبنى نفسه لا يمثل سوى حوالي 15-20% من التكلفة الإجمالية للمستشفى.

وينبغي اتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد العناصر غير الهيكلية الضعيفة التي يمكن أن تتضرر، والحد من المخاطر أو القضاء عليها. وينبغي أن توضع في الاعتبار التدابير الستة الآتية التي ستسهم في قدرة المستشفى على مواصلة أداء وظائفه في حالات الطوارئ (11، 12):

- الإزالة: في العديد من الحالات، قد يكون هذا هو الخيار الأفضل. وينبغي تخزين المواد الخطرة التي يمكن أن تتعرض للانسكاب خارج مباني المستشفى.
- النقل إلى مكان آخر: هذا من شأنه أن يقلل الخطر في معظم الحالات. ويشمل هذا على سبيل المثال، وجود جسم ثقيل الوزن على رفٍّ عالٍ، مما قد يعرضه للسقوط، وإحداث إصابة خطيرة لأي شخص. وبالتالي، فإن نقله إلى رف منخفض يقلل من المخاطر.
- التقييد: تقييد حركة أشياء معينة، مثل أسطوانات الأكسجين والمولدات الكهربائية، للحيلولة دون حدوث مزيد من الضرر أو تعرض الموظفين أو المرضى للإصابة.
- التعزيز: تقوية العناصر الموجودة، مثل الجدران أو الفتحات غير المُعززة، باستخدام شبكة من السلك وملئها بالإسمنت.
- الاستبدال: ينبغي أن يكون الاستبدال بشيء لا يمثل خطرًا. فعلى سبيل المثال، تمثل بلاطات الأسقف الثقيلة عبئًا إضافيًا، من حيث الوزن، على المبنى، مما يجعله أكثر عُرضة للتحرك أثناء وقوع زلزال. وبالتالي، فالحل هو تغيير السقف إلى آخر أخف وزنًا وأكثر أمنًا.

- خطة البدائل الجاهزة: التخطيط لتوفير مصادر بديلة للعناصر الحيوية غير الهيكلية في المستشفى، لا سيما تلك التي تمثل شرايين الحياة للمستشفى، ومنها الطاقة والمياه والاتصالات ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والوقود والغاز وإدارة النفايات، وما إلى ذلك.

3-2-1 سهولة الوصول إلى البنية الأساسية ومرونتها

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة إجحافات صحية كبيرة مقارنة بالأشخاص غير المصابين بإعاقة. ووَفقًا لما جاء في «التقرير العالمي عن الإعاقة»، يعيش ما يقرب من 15% من سكان العالم بنوعٍ من أنواع الإعاقة؛ ويواجه نحو 2-4 % منهم صعوبات كبيرة في الأداء الوظيفي (13). ويتفاقم هذا الوضع أثناء حالات الطوارئ، إذ يكون الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر عُرضة للإصابة أو الوفاة بمقدار يتراوح بين ضعفين إلى أربعة أضعاف في حالات الكوارث بسبب قصور التخطيط على نطاق المجتمع المحلي وعدم إمكانية حصولهم على المساعدة في حالات الطوارئ والكوارث.

وبالإضافة إلى الأماكن التي يتعذر الوصول إليها بدنيًّا في المستشفى، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة أيضًا عقبات في التواصل، وتحديات أخرى بسبب نقص الوعي والتدريب. وستؤدي توعية الموظفين بالاحتياجات الفريدة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحسين الإنصاف والشمول في مجال الصحة. ويمكن أن تكون الإعاقات مرئية وغير مرئية، وتشمل على سبيل المثال، الإعاقات السمعية والبدنية والفكرية والنفسية الاجتماعية والبصرية (14). وقد تنظر المستشفيات في إمكانية تخصيص مساحات محددة لعلاج الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء حالات الطوارئ. وقد يستلزم ذلك، كجزء من خطة المستشفى، إحداث تغيير في الحيز المكاني المتاح لتيسير تقديم المساعدة.

ولبناء القدرة على الصمود، يجب على المستشفيات ضمان أن تراعي خطط الاستعداد الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن لأداة إدماج منظور الإعاقة في إدارة مخاطر الكوارث بالمستشفيات أن تُقيّم مدى إدماج الإعاقة وَفقًا لخمسة مجالات: (1) تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و(2) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و(3) الإتاحة الشاملة؛ و(4) تطوير قدرات الاستجابة؛ و(5) خطة المستشفى للاستجابة للطوارئ والكوارث.

وعلى أي مستشفى يتمتع بالقدرة على الصمود، ويتسم بالشمولية أن يأخذ بعين الاعتبار التدخلات الآتية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة:

- مساحة للكراسي المتحركة؛ مساحة مفتوحة قريبة من مكتب الاستقبال؛ مساحة أرضية كافية للتحرك بحرية.
- مداخل واسعة تسمح بمرور الكراسي المتحركة ودراجات التنقل المزودة بمحرك.
- استخدام التكنولوجيات الـمُساعِدة، مثل الشاشات التي تعمل باللمس.
- مفاتيح ومقابض يسهل الوصول إليها (مثل الأضواء والمصاعد والأبواب).
- تقديم إشعارات مرئية للصم، وإشعارات شفهية للمكفوفين (على سبيل المثال، أجهزة إنذار الحريق السمعية البصرية).
- لافتات تسهل رؤيتها وفهمها بسهولة.
- ممرات منحدرة وقضبان يدوية (درابزين).

وأخيرًا، يتعين على مديري المستشفيات أن يبنوا مستشفيات ذكية، وفقًا للمبادئ الآتية:



تقدم ثلاث أدوات أساسية من مجموعة أدوات المستشفيات الذكية (10) معلومات مهمة حول تحسين قدرة المستشفيات على الصمود:

- يُمكِّن مؤشر سلامة المستشفيات مديري المستشفيات من تحديد احتمالية استمرار المستشفى في العمل أثناء الطوارئ. ويركز في المقام الأول على المؤشرات الهيكلية وغير الهيكلية، ويشمل عوامل وظيفية.
- تتيح أداة التقييم الأساسي لمديري المستشفيات جمع المعلومات الأساسية للاسترشاد بها في قرارات التحديث. وهذه الأداة مُكملة لمؤشر سلامة المستشفيات والقائمة المرجعية الخضراء، وتتضمن أقسامًا بشأن استهلاك الطاقة والمياه؛ وجودة البيئة الداخلية؛ ومكونات المباني؛ ومسح خاص بشاغلي المستشفيات؛ واستخدام الأراضي (اللوائح المحلية بشأن تقسيم المناطق) (15).
- تساعد القائمة المرجعية الخضراء المستشفيات على تحديد التدخلات ذات الأولوية التي تقلل من مساهماتها في تغير المناخ، مثل الحفاظ على الموارد، وخفض التكاليف، وزيادة الكفاءة التشغيلية، والحد من انبعاثات الكربون.

وبالإضافة إلى القائمة المرجعية الخضراء، يُوضِّح المنشور الصادر تحت عنوان إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مرافق الرعاية الصحية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والمستدامة بيئيًّا عدة تدخلات تركز على أربعة مجالات: (1) القوى العاملة الصحية؛ و(2) المياه والإصحاح والنظافة الشخصية وإدارة نفايات الرعاية الصحية؛ و(3) خدمات الطاقة المستدامة؛ و(4) البنية الأساسية والتكنولوجيات والمنتجات (16).

الاستراتيجيات

تنتج معظم المشاكل المتعلقة بالكوارث في المستشفيات عن الافتقار إلى السلامة والقدرة على الصمود على المستويين الهيكلي وغير الهيكلي. ومع ذلك، وبالإضافة إلى هذه العناصر، يجب على مديري المستشفيات أيضًا أن يضعوا في اعتبارهم الآثار البيئية، وأن يسعوا إلى جعل المستشفيات ليست آمنة فحسب، بل أيضًا خضراء (10) (بيئيًّا) ومستدامة ماليًّا، بالإضافة إلى كونها شاملة. وينبغي النظر في الجوانب الآتية لسلامة المستشفيات:

وفي إطار سعي المستشفيات لتحقيق هدف القدرة على الصمود، ستكون الاستراتيجية ذات الأهداف والغايات القوية بمثابة المخطط الأوَّلي لتخطيط الإجراءات المناسبة وتنفيذها - في ظل قيود الميزانية الخاصة بالمنشأة. ويجب أن يكون للمستشفيات توجُّه استراتيجي واضح لتطبيق الرقابة المؤسسية اللازمة لتحقيق أهدافها وغاياتها المتعلقة بالقدرة على الصمود.

تُسهم الاعتبارات الاستراتيجية الآتية في تعزيز قدرة المستشفيات على الصمود:

- ينبغي أن تتضمن السياسات أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، على مستوى جميع مكونات استراتيجية المستشفى لإدارة مخاطر الكوارث والشاملة لجميع الأخطار، وأن تشمل المسؤولين عن التخطيط والتنسيق، واللوائح الصحية الدولية (2005)، والترصُّد والإنذار المبكر، والتأهُّب لحالات الطوارئ ومواجهتها، والتعافي، والخدمات الصحية.

- ينبغي أن يُسترشد بنتائج تقييم المخاطر في التخطيط للحد من المخاطر، وتطوير القدرات والتمارين والاستعراضات، لا سيما تلك التي تُجرى لإدارة المخاطر المتعددة القطاعات بمشاركة السلطات والمؤسسات المحلية. وينبغي أن يكون هناك اتساق واستمرارية بين الخطط على مختلف المستويات والاختصاصات.
- ينبغي إنشاء آلية تنسيق لإدارة مخاطر الكوارث في المستشفى، وتعيين وحدات مخصَّصة/ أشخاص مخصَّصين لضمان التنسيق المناسب على مستوى مختلف أقسام المستشفى، والمستشفيات الأخرى في شبكة المنطقة، والسلطة الصحية المحلية، والقطاعات الأخرى.
- ينبغي تعميم التنوع والإنصاف والإدماج في سياسات المستشفى وخططه وبرامجه لتحسين قدرات التكيّف، وتقليل الآثار الضارة للأخطار على الفئات السكانية المستضعفة في المجتمعات المحلية.

4-2-1 نظام اعتماد المستشفيات

تُعَدُّ نُظُم اعتماد المستشفيات وترخيصها، في معظم البلدان، أمرًا حيويًّا لضمان جودة الخدمات وسلامة المرضى، وذلك من خلال تقييم أداء المستشفيات استنادًا إلى المعايير المعمول بها، وتنفيذ التحسينات المستمرة.

وعملية الاعتماد هي أحد مداخل إدماج إدارة مخاطر الكوارث في العمليات العادية للمستشفيات. على سبيل المثال، يمكن ربط جزء من عملية اعتماد المرفق بالامتثال لمعايير الاعتماد الدولية و/ أو الوطنية للمستشفيات فيما يتعلق بإدارة الطوارئ والكوارث. واستنادًا إلى الخبرات المكتسبة خلال جائحة كوفيد-19، نقَّحت اللجنة المشتركة[1] معاييرها ومتطلباتها بشأن إدارة الطوارئ كجزء من عملية اعتماد المستشفيات (17). ومن هذا المنطلق، يتعين على وزارات الصحة بوصفها مسؤولة عن عمليات الترخيص/ تجديد الترخيص في المستشفيات الخاصة والعامة على حد سواء أن تُدرج عناصر إدارة الطوارئ في عملية الاعتماد.

5-2-1 لجنة متعددة التخصصات لإدارة الكوارث

تشير منشورات منظمة الصحة العالمية ومبادئها التوجيهية بشأن إدارة الطوارئ والكوارث، ومنها الاستعراضات الأخيرة للاستجابات الناجحة لجائحة كوفيد-19،[2] إلى أنه من الأهمية بمكان إنشاء لجنة متعددة التخصصات لإدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث. وتُكلف هذه اللجنة بوضع العمليات والسياسات والإجراءات، وتدريب الموظفين وتثقيفهم، وتأمين الموارد اللازمة لضمان استجابة المستشفى الفورية والمنسقة والفعالة لجميع حالات الطوارئ. وتكون اللجنة مسؤولة عن جميع جوانب خطة عمليات الطوارئ، وتشمل إدماج تمارين المحاكاة والاستعراضات اللاحقة للإجراءات التي تهدف إلى دراسة الاستجابة، وتحديد فرص التحسين.

1 تعتمد اللجنة المشتركة أكثر من 22000 مؤسسة وبرنامج للرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وتصدر شهادات لها، ويشمل ذلك المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية التي توفر جراحات إسعافية وجراحات العيادات، والصحة السلوكية، والرعاية الصحية المنزلية، وخدمات المختبرات ومراكز الرعاية التمريضية.

2 هذه الوثائق متاحة عبر الإنترنت عبر مواقع: المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية/ منظمة الصحة العالمية.

6-2-1 خطط تطوير الأعمال للمستشفى

يستطيع المستشفى القادر على الصمود مواصلة العمل في حالات الطوارئ. ويتطلب ذلك الاستعداد لتوفير الموارد وإعادة تخصيصها لضمان الاستدامة المالية واستمرارية تصريف الأعمال والخدمات (18). ويتطلب التطور التنظيمي للمستشفى تحسين العمليات والتوسع فيها باستمرار لتلبية متطلبات المجتمع المحلي الذي يخدمه. ويشمل ذلك التخطيط لتشييد مبنى جديد (إذا لزم الأمر)، أو تحديث المعدات، أو استخدام التكنولوجيا، أو توسيع نطاق الخدمات الصحية، أو تعيين موظفين إضافيين (19). ويجب أن تسترشد خطط استمرارية تصريف الأعمال بالمخاطر، وأن تُدرج في عملية التخطيط لمواءمتها مع أهداف الحد من المخاطر.

7-2-1 العمليات الروتينية بالمستشفيات

خلال الأوقات الروتينية، من الضروري تحسين وظائف المستشفيات وكفاءتها لضمان الاستعداد والقدرة على الصمود. ولا تختلف الموارد التي تُحشد للاستجابة للطوارئ عن الموارد التي تستخدمها المستشفيات في خدمات العمليات الروتينية. لذا يجب قبل وقوع أي حالة طوارئ، أن تكون لدى المستشفيات إجراءات تشغيلية قوية لتقديم التدبير العلاجي، على سبيل المثال، للرضوح والأمراض المُعدية في وحدة الطوارئ، ويشمل ذلك استقبال المرضى، والفرز، والتقييم، وإزالة التلوث، والعَزْل، ورعاية المصابين. وسيكون من الضروري أيضًا ضمان توافر الأدوية والإمدادات الطبية وعلامات الفرز والمعدات لتلبية الطلب المتزايد عليها.

ولا تقل خدمات الدعم غير الطبي أهميةً عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على قدرة المستشفى على مواصلة العمل. ومن أمثلة هذه الخدمات الشؤون الإدارية والمالية؛ والهندسة والصيانة؛ وخدمات التنظيف؛ والأمن؛ والمختبر؛ والأشعة؛ وبنك الدم؛ والإمدادات المركزية. وقد تنظر المستشفيات في مسألة دمج خدمات الدعم والخدمات الصحية المساعدة خلال الأوقات العادية، لتيسير إجراء تعديلات بما يتناسب مع متطلبات الطوارئ.

وتكتسي تدابير المستشفيات الأمنية التي وُضعت لحماية العمليات الروتينية بها أهمية بالغة أثناء حالات الطوارئ لحماية المرضى والموظفين وممتلكات المستشفى؛ وضمان استمرارية الرعاية؛ ومنع انتشار المرض؛ والحفاظ على ثقة الجمهور. وينبغي وضع النقاط الآتية في الاعتبار:

- وجود نظام مُطبَّق لضمان سلامة المرضى والزوار والموظفين، ويشمل ذلك مراقبة الدخول، وتأمين المناطق الحساسة، وحماية الموظفين والممتلكات من الحشود، وتفعيل نظام استخدام بطاقات الهُوية والأقفال والمفاتيح.
- حماية ممتلكات المستشفى خلال مرحلة التعافي من خلال تأمين المعدات والإمدادات الطبية، ومراقبة المخزون، ورصد السرقة والأضرار.
- الحفاظ على التواصل مع الموظفين والمرضى وأصحاب المصلحة الآخرين لإطلاعهم على أحدث التدابير الأمنية وأي تغييرات في عمليات المستشفى.
- التنسيق مع السلطات المحلية لإنفاذ القانون لضمان الاستجابة المنسقة للتهديدات الأمنية، وتلقي الدعم في تأمين مباني المستشفيات. ويجب إدراجها في الاستعراض اللاحق للكارثة فيما يتعلق بتنفيذ الخُطط الأمنية.

8-2-1 عمليات المستشفيات الخضراء

يؤثر تغيُّر المناخ على الرعاية الصحية والنظم الصحية نظرًا لأنهما تضطران لتحمل التكاليف المرتبطة بزيادة الاعتلالات، والتغيرات في معدلات انتشار الأمراض، والآثار الصحية المترتبة على أحداث الطقس القصوى الأكثر تواترًا. وفي الوقت نفسه، تسهم عمليات الرعاية الصحية ذاتها بشكل كبير في تغير المناخ. فالمستشفيات تؤثر تأثيرًا كبيرًا على صحة البيئة، في المراحل الأولية والنهائية لنقطة تقديم الخدمات، وذلك من خلال الموارد الطبيعية والمنتجات التي تستهلكها والنفايات التي تولدها. ويتعين النظر في التوصيات الآتية لإزالة الكربون من عمليات المستشفيات.

الإطار 1. المستشفيات العالمية الخضراء والصحية: عمليات إزالة الكربون في المستشفيات

المستشفيات العالمية الخضراء والصحية: عمليات إزالة الكربون في المستشفيات

المستشفيات العالمية الخضراء والصحية هي شبكة مناصرة عالمية تضم أكثر من ٧٠ بلدًا. وتعمل هذه الشبكة الدولية للمستشفيات والنظم الصحية والمنظمات على الحد من بصمتها البيئية، ويشمل ذلك إزالة الكربون من عمليات المستشفيات. وهناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك:

- إنشاء فريق عمل متعدد التخصصات معْني بالاستدامة على مستوى المستشفى أو النظام ككل للمساعدة في ضمان تنفيذ خطط الصحة البيئية والاستدامة في جميع أنحاء المستشفى.
- وضع سياسات وبروتوكولات بشأن المواد الكيميائية الخطرة لحماية المرضى والعاملين وصحة المجتمع والبيئة، مع المساعدة في توجيه الطلب على نطاق المجتمع نحو البدائل.
- فصل النفايات عند المصدر، وبدء إعادة تدوير النفايات غير الخطرة.
- الحد من النفايات وانبعاثات غازات الدفيئة من خلال تحويل النفايات إلى أسمدة، وإعادة التدوير (بما في ذلك الغازات المخدرة)، والشراء الذكي (التقليل إلى أدنى حد من التعبئة، واستخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام بدلًا من المنتجات التي تُستعمَل مرةً واحدة، وشراء المنتجات المعاد تدويرها)، والتقليل إلى أدنى حد من نقل النفايات (معالجتها في الموقع، والتخلص منها).
- الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتكاليف الطاقة مع مرور الوقت باستخدام أشكال بديلة من الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي.
- تنفيذ استراتيجيات حفظ المياه: تركيب صنابير ومراحيض تتميز بكفاءة استخدام المياه، والفحص الروتيني للسباكة والمواسير لمنع التسرب، ووقف استخدام المياه في مانع التسرب والتبريد في مضخات ضغط وتفريغ الهواء الطبية، وتحديث نظم التبريد.
- النظر في تجميع مياه الأمطار و/ أو إعادة تدوير المياه لاستخدامها كمياه معالجة.
- تنفيذ تكنولوجيات معالجة المياه المستعملة في الموقع عندما تكون الخدمات المحلية غير متاحة.

9-2-1 خطط تنمية القدرات

تنمية القدرات هي عملية مستمرة يقوم بموجبها الأفراد والمستشفى كمؤسسة بتطبيق القدرات وتعزيزها وتشكيلها وتكييفها والحفاظ عليها مع مرور الوقت لتحقيق الأهداف الإنمائية. وللحفاظ على هذه القدرات

واستخدامها على النحو المناسب في الوقت المناسب وفي الموقف المناسب، يجب أن تكون كفاءات إدارة مخاطر الكوارث جزءًا لا يتجزأ من خطط تنمية قُدُرات موظفي المستشفيات التي تنفذها إدارات الموارد البشرية (20)، وأن تُدمج هذه الكفاءات في هذه الخطط. وينبغي أن تشمل أنشطة تنمية القُدُرات، مثل التدريب والحلقات الدراسية والتمارين وتبادل الدروس المستفادة، كفاءات إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث، ومنها تفعيل الوظائف العادية المرتبطة بسلسلة الإمداد وإدارة المرافق وإدارة الشؤون المالية وإدارة المعلومات، والتي تكون أيضًا من الأمور البالغة الأهمية أثناء حالات الطوارئ.

النُّظم

كما نوقش سابقًا، فإن الأداء الراسخ والقوي للخدمات الروتينية بالمستشفى، والذي يتحقق على أيدي موظفين مدربين تدريبًا جيدًا وسياسات وخطط وإجراءات ومعايير راسخة، يسهم إسهامًا كبيرًا في استمرارية الخدمات أثناء حالات الطوارئ، وفي القدرة على الصمود في نهاية المطاف. وبالمثل، فإن تعزيز القدرة الناعمة للمستشفى على الصمود، لا سيما نُظُمه، في الأوقات الروتينية أمرٌ بالغ الأهمية حتى يتسنى تقديم استجابة فعالة.

10-2-1 التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

يُعدّ التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية جزءًا أساسيًّا من إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث. فهو لا يؤدي فقط إلى تحسين عمليات المستشفيات وكفاءتها وثقافتها بشكل يومي، بل إنه حجر الزاوية في الإدارة الفعالة لحالات الطوارئ. وينبغي أن تستهدف معلومات التواصل بشأن المخاطر موظفي المستشفيات والمرضى والزوار والمجتمع المحلي الأوسع نطاقًا لمساعدة الناس على اتخاذ أفضل القرارات الممكنة من أجل سلامتهم وصحتهم وعافيتهم.

الإطار 2. مبادئ التواصل الفعال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

مبادئ التواصل الفعال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

- تُحفَّز أفعال الأفراد عن طريق تصور الخطر، وليس التقييم التقني للخطر. وعادة ما يكون تصور الخطر قائمًا على العواطف، ويتأثر بعوامل محلية وثقافية.
- يفهم الناس الأمور وفقًا لتجاربهم وخلفياتهم الخاصة. ولذلك، يجب أن يكون التواصل بشأن المخاطر سياقيًّا.
- غالبًا ما يُظهر الناس «سلوك القطيع»، ويتبعون القادة في حالات الطوارئ. ولذلك، من الضروري إشراك القادة المناسبين والشخصيات المؤثرة في المجتمع المحلي.
- إن التغيير السلوكي لاتخاذ إجراءات بشأن التدخل الصحي هو عملية متسلسلة. فهو يتطلب وسائل تواصل متعددة، تُكرر بشكلٍ استراتيجي مرات عديدة ومن مصادر مختلفة.
- في حالات الطوارئ، يكون الناس في حالة من الخوف، ولا يفكرون دائمًا بعقلانية. وبالتالي، يجب أن يناشد التواصل بشأن المخاطر القلب والغريزة.

توجد مخاطر عديدة داخل المستشفيات، حتى في الأوقات العادية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الحرائق، والأمن، وسلامة المرضى، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والسلامة الكيميائية، وما إلى ذلك. وقد تساعد الإجراءات الآتية على دمج التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في العمليات الروتينية للمستشفى:

- تعزيز رسائل السلامة باستخدام الملصقات والنشرات والحملات الإعلامية، بلغة مناسبة للسياق.
- اغتنام فرصة احتفالات اليوم الوطني/ الدولي لتعزيز رسائل السلامة (مثل شهر السلامة من الحرائق، واليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، واليوم الدولي لسلامة المرضى، واليوم الدولي لكادر التمريض، ويوم الأرض، وما إلى ذلك). اضغط هنا لعرض قائمة كاملة بالأيام والأسابيع الدولية للأمم المتحدة.
- استخدام المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل. ويمكن لهذه المنصات أن تقدم معلومات ارتجاعية سريعة للجمهور بحيث يمكن تعديل الرسائل، إذا لزم الأمر.
- التصدي للوباء المعلوماتي عن طريق نشر معلومات ورسائل مُتحقَّق من صحتها من مصادر موثوقة (السلطات الصحية، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهما)، ودحض الخرافات الضارة المتعلقة بالطوارئ الصحية.
- الفئات المستضعفة (مثل المهاجرين ومجتمعات الأقليات والفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها) مُعرَّضة بشكل خاص للآثار المترتبة على المعلومات الصحية المغلوطة، بسبب محدودية وصولها إلى مصادر معلومات موثوقة ودقيقة. وقد يُقلل هذا من فرص الحصول على الرعاية الصحية والإقبال عليها، وهو ما قد يكون محدوداً بالفعل. وينبغي تحديد هذه الفئات المستضعفة، واستخدام الاستراتيجيات والرسائل وأدوات التواصل المناسبة للوصول إليها.
- إقامة روابط مع وسائط الإعلام المحلية، والمشاركة في أنشطة العلاقات العامة الروتينية كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات.

11-2-1 نظام إدارة المعلومات بالمستشفى

تسهل نظم المعلومات تخطيط خدمات الرعاية الصحية وعمليات المستشفيات وإدارتها وتقديمها، مثل الرعاية المتكاملة للمرضى، وسير أعمال المستشفى ووظائفه القانونية، والموظفين وإدارة الموارد البشرية، وإدارة سلسلة الإمداد. ونظرًا لأنه يمكن استخدام بيانات النظام في الإدارة الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبحوث، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ، فإن النظم القوية لإدارة معلومات المستشفى تدعم بشكلٍ كبير الحد من مخاطر المستشفى، والتأهب والاستجابة لها والتعافي منها. فعلى سبيل المثال، تكتسي مجموعات البيانات المهمة، مثل تعداد المرضى، وتوافر الأسرّة، وقدرات الموظفين، والموارد، ومخططات البناء الأولية، وخرائط المرافق، أهمية في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب في حالات الطوارئ.

وينبغي أن يكون نظام معلومات المستشفى قادرًا على تبادل بيانات المرضى مع مستشفيات الشبكة الأخرى مما يسمح باستمرارية الرعاية عن طريق التطبيب عن بُعد ووسائل أخرى. وبالمثل، يمكن أن تسهم المعلومات في قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالصحة وإدارة الكوارث عن طريق توفير معلومات عن تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض، وجهود الكشف المبكر، والتخطيط، وتخصيص الموارد، وعلم الأوبئة، وما إلى ذلك، على المستويات المحلية ودون الوطنية والوطنية. كما ينبغي أن يكون نظام معلومات المستشفيات قادرًا على توفير المعلومات لأنظمة الأطراف الأخرى مثل المجلس الوطني لمأمونية الدواء، وإدارة التسجيل، ومجلس السلامة على الطرق، والشرطة، وخدمات الطوارئ، وغيرها.

وفي حالة عدم وجود برمجيات لإدارة معلومات المستشفيات، يمكن أن تنظر المستشفيات في استخدام نظام المعلومات الصحية على مستوى المناطق. ويمكن استخدام منصة بيانات إدارة شؤون الصحة النموذجية المفتوحة المصدر والموجودة عبر شبكة الإنترنت لجمع البيانات الإحصائية وتجميعها، والتحقق من صحتها وتحليلها وإدارتها وعرضها.

المواد

كما ذُكر أعلاه، من المهم إدراك أهمية تعميم إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في العمليات الروتينية للمستشفيات. وبتعزيز الإدارة الروتينية للمعدات والإمدادات، على سبيل المثال، لن تعزز المستشفيات هذه الخدمات والوظائف الحيوية فحسب، بل ستمكنها أيضًا من التكيف بسرعة مع حالات الطوارئ. وهذا يمنح المستشفيات المرونة اللازمة لإعادة تخصيص الموارد المادية المحدودة إلى حيث تشتد الحاجة إليها من أجل تلبية الزيادة المفاجئة في الطلب على رعاية المرضى. ويمكن أن تساعد النقاط الآتية في تعزيز الإدارة الروتينية للمعدات والإمدادات.

12-2-1 برنامج الصيانة الوقائية

يشكل برنامج الصيانة الوقائية جزءًا أساسيًّا من الإدارة الناجحة للمرافق. ويحافظ على كفاءة تشغيل المعدات، ويعزز سلامة الموظفين، ويساعد على تجنب الإصلاحات الواسعة والمكلفة مع مرور الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون مفيدًا من الناحية المالية، لأن تكاليف الصيانة بغرض الإصلاح تزيد من ثلاث إلى أربع مرات عن تكاليف الصيانة الوقائية. ويكمن الأساس هنا في وجود نظام راسخ لرصد الصيانة، ووضع جدول زمني لها لتعزيز الإنتاجية، وضمان استمرار عمل أصول المستشفيات عندما تشتد الحاجة إليها.

الإطار 3. مزايا برامج الصيانة الوقائية

مزايا برامج الصيانة الوقائية

- تقليل حالات التعطل التشغيلي إلى أدنى حد. ويمكن التخطيط لإجراء الصيانة المقررة، مما يقلل من تعطل العمليات اليومية بالمستشفى.
- تَحول الصيانة الوقائية دون حدوث أي تعطل غير مخطط له، والذي قد يؤدي إلى توقف الموظفين عن العمل، وتوقف العمليات، وتفويت المواعيد النهائية، وعدم إنجاز الغايات المستهدفة.
- الحفاظ على الأجهزة في حالة تشغيلية جيدة، مع الانتظام في استبدال الأجزاء التي تحتاج إلى تبديل، وتغيير السوائل والزيت، وإجراء عمليات فحص الجودة.
- توفر المعدات التي تعمل بكفاءة تكاليف الطاقة والكهرباء.
- إطالة دورة حياة المعدات وزيادة أدائها.
- تعزيز ظروف العمل الآمنة، إذ تكشف الفحوصات الروتينية الأخطار، وتَحول دون العمل في ظروف غير آمنة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الإصابات والحوادث أثناء العمل.

وينبغي النظر في إجراءات الصيانة الوقائية الآتية:

- التأكد من خلو الأجهزة من أي بقايا قبل وبعد كل مناوبة.
- الفحص الروتيني لجميع سيور الماكينات ومستويات السوائل والمرشحات، واستبدالها حسب الحاجة.
- معايرة الآلات بانتظام.
- فحص عناصر البناء الهيكلي مرة واحدة على الأقل في السنة.
- فحص وإصلاح نظم المبنى (الكهرباء، والسباكة، والشبكة) بشكل شامل مرة واحدة على الأقل في السنة.
- فحص أجهزة الكشف عن الحرائق مرتين في السنة، والتأكد من أنها متوافقة مع اللوائح المحلية.
- التأكد من وضع علامات مناسبة على المناطق الآمنة وتلك التي ينبغي توخي الحذر داخلها.
- مراجعة أمن الشبكة وتحديده بانتظام (مثل الفيروسات والبرمجيات الخبيثة).
- التأكد من التزام الموظفين بالممارسات الآمنة، مثل تأمين كلمات المرور والممارسات الملائمة لاستخدام البريد الإلكتروني (تجنب مخططات التصيد الاحتيالي، وما إلى ذلك).
- تغيير كلمات المرور الخاصة بشبكة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت والشبكات الأخرى مرتين في السنة على الأقل.

13-2-1 سلسلة الإمداد، والمخزون، واللوجستيات المتعلقة بالمشتريات

اللوجستيات عنصر رئيسي في سلسلة الإمداد، وتتطلب تخطيط وتنفيذ الإجراءات التي تدعم الشراء وإدارة المخزون وتجديد السلع والخدمات. ويساعد الحفاظ على سير سلسلة الإمداد بكفاءة وبتكلفة معقولة وبشكل استباقي على تحقيق نتائج إيجابية للمرضى من خلال ضمان حصول المرضى ومقدمي الخدمات على الأدوية والمعدات التي يحتاجون إليها.

ومن شأن القدرة على متابعة مخزون المستشفيات من المنتج إلى المريض وتتبعه وتدقيقه بسهولة أن تنقذ الأرواح، لأنها تتيح اتخاذ إجراءات سريعة وقرارات فورية عندما يتعلق الأمر بتعبئة الموارد لدعم الاستجابة للطوارئ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود نظام لوجستي يعمل بشكل جيد وسلسلة إمداد قوية يُمكِّن المستشفى بصفة دائمة من الحد من حالات التأخير وأوجه القصور غير المبررة. وينبغي النظر في هذه الإجراءات الرئيسية لتعزيز سلسلة الإمداد والشؤون اللوجستية في المستشفى:

- تنفيذ نظام شراء مركزي لتحسين مراقبة المخزون والإشراف عليه.
- تطبيق نظام المخزون المدار بواسطة المورِّد باستخدام ماسحات الباركود حتى لا تكون هناك حاجة إلى إدخال الطلبات يدويًا، أو إجراء مكالمات هاتفية عاجلة لتجديد المخزون.
- امتلاك نظام رقمي آمن ودقيق لضمان صحة السجلات حتى يتمكن الموظفون من التركيز على المرضى، وليس الأعمال الورقية.

14-2-1 إدارة الشؤون المالية للرعاية الصحية

يتمثل دور إدارة الشؤون المالية في مؤسسات الرعاية الصحية في إدارة الأموال والمخاطر بطريقة تساعد المستشفيات على تقديم خدمات رعاية صحية فعالة لجميع المرضى. ومن المهم أن تكون لدى المستشفيات القدرة على الوصول إلى الاحتياطات المتاحة، وصرف الأموال على الفور لتلبية الاحتياجات الطارئة، مما يضمن استمرار تدفق الإمدادات والخدمات.

وتشمل المسؤوليات الروتينية لإدارات الشؤون المالية في الفترات التي لا تشهد حالات طوارئ تنفيذ أوامر الشراء، والانتهاء من بيع السلع والخدمات، والتفاوض بشأن العقود مع مقدمي الخدمات والمقاولين، وإدارة الرواتب، والحفاظ على الاحتياطيات النقدية لأي نفقات غير متوقعة أو غير مخطط لها. ومن شأن إرساء أساس قوي واتباع ممارسات ومعايير مالية جيدة قبل حدوث أي حالة طوارئ أن يُيسر اتخاذ الإجراءات والقرارات بسرعة وفي الوقت المناسب في حالات الطوارئ.

الموظفون

تتعامل إدارة الموارد البشرية مع المسائل المتعلقة بالموظفين مثل التوظيف والتدريب والتطوير والتعويض والتحفيز والاستبقاء والتواصل والإدارة. ومن شأن إدماج إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في التنمية الروتينية للموارد البشرية بالمستشفيات أن يعزز قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على التأهب للكوارث والاستجابة لها.

15-2-1 إدماج إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في التنمية الروتينية للموارد البشرية

يتطلب إدماج إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية الروتينية للموارد البشرية في المستشفيات مزيجًا من التقييم، وتطوير التدريب، والإدماج في توصيفات الوظائف، وإنشاء فرق عمل، وعقد شراكات، وإجراء تقييمات. وفيما يلي الإجراءات الرئيسية لتيسير هذه العملية:

- تقييم القدرة الحالية: إجراء تقييم لمعارف العاملين في مجال الرعاية الصحية ومهاراتهم ومواقفهم فيما يتعلق بإدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث، وذلك لتحديد الثغرات وفرص التحسين. وينبغي تحديد قدرات الموظفين ومهاراتهم ورصدها والحفاظ عليها.
- إعداد برامج تدريبية على إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث: إعداد برامج تدريبية تدمج إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في العمليات الروتينية لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية وتطوير قدراتهم. وينبغي أن تشمل هذه البرامج مجموعة من الموضوعات، مثل التأهب للكوارث، والاستجابة لها، والتعافي منها، والتواصل بشأن المخاطر، والدعم النفسي الاجتماعي.
- إدراج الكفاءات المرتبطة بإدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في توصيفات الوظائف وتقييمات الأداء للموظفين لضمان تمتعهم بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء أدوارهم في حالات الطوارئ. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الرصد والتقييم، ويمكن أن يكون أساسًا للمكافآت والحوافز والترقيات.
- تحديث دليل بيانات الاتصال بالموظفين بانتظام. ويمكن استخدام قائمة بجهات الاتصال في تمارين شجرة الاستدعاءات عندما يكون من الضروري استدعاء الموظفين أو حشد فريق إدارة الأحداث في المستشفى.

- تشجيع الموظفين على مواصلة النمو المهني فيما يتعلق بإدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث من خلال وضع غايات وخطط لبرنامج تدريب كجزء من إدارة الأداء والتطوير المهني للموظفين.
- إدراج أدوار ومسؤوليات الموظفين المرتبطة بإدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في توجيه الموظفين الجدد وتدريبهم.
- إنشاء فرق عمل أو لجان لإدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث تضم عاملين في مجال الرعاية الصحية من مجموعة متنوعة من الإدارات للإشراف على إدماج إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في تنمية الموارد البشرية.
- إقامة شراكات مع خبراء ومنظمات إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث لتقديم الدعم والإرشاد التقنيين لإعداد برامج تدريب حول إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث وتنفيذها.
- إجراء تقييم منتظم لفعالية برامج التدريب على إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث وتحديثها بناءً على التعقيبات والاحتياجات والظروف المتغيرة.

16-2-1 أدوات وموارد الحد من المخاطر

- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. موارد مبادرة المستشفيات الذكية. واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ [2023؟]. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/49Txp6U.
- منظمة الصحة العالمية. إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مرافق الرعاية الصحية القادرة على تحمل تغير المناخ والمستدامة بيئيًّا جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3HBQRZS.
- منظمة الصحة العالمية. قوائم مرجعية لتقييم مواطن الضعف بمرافق الرعاية الصحية في سياق تغير المناخ. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3OG4b3i.
- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالإعاقة في إدارة مخاطر الكوارث في المستشفيات (INGRID-H). واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ 2018. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3HYgofV.
- المستشفيات العالمية الخضراء والصحية. وثائق إرشادية لشبكة المستشفيات العالمية الخضراء والصحية. [ريستون، فرجينيا]: شبكة المستشفيات العالمية الخضراء والصحية؛ [c2024]. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3SWJTFi.
- منظمة الصحة العالمية. التخطيط لاستمرارية الخدمات الصحية في حالات الطوارئ الصحية العامة: دليل للمرافق الصحية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/492h6nU.
- منظمة الصحة العالمية. إرشادات خطة العمل المتعلقة بالتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. التأهب لجائحة كوفيد-19 والاستجابة لها. إرشادات مؤقتة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3UaBw9U
- منظمة الصحة العالمية. مشاورة تقنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التعامل مع «الوباء المعلوماتي» المتعلق بكوفيد-19: دعوة إلى العمل. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3SySlZX.

- مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. التواصل العام من أجل الحد من مخاطر الكوارث. جنيف: مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ 2017. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3UEph62.
- الشبكة الدولية للمستشفيات والخدمات الصحية الداعية لتعزيز الصحة. معايير المستشفيات والخدمات الصحية الداعية لتعزيز الصحة لعام 2020 هامبورغ: الشبكة الدولية للمستشفيات والخدمات الصحية الداعية لتعزيز الصحة؛ 2020. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3HWdxUz.

3-1 التأهب

إن أي خطر يؤثر على المستشفى، مما يؤدي إلى حالة طوارئ أو كارثة، يمكن أن تنجم عنه مجموعة متنوعة من العواقب. ولذلك، فإن التخطيط السابق على الأزمة ضروري لضمان تطوير المعارف والمهارات المناسبة، وجعلها قيد التنفيذ للاستجابة والتعافي بأمان.

ويمكن للمستشفيات المستعدة أن تستجيب بسرعة وبشكل مناسب، مما يحد من الوَفَيَات والإصابات وأوجه المعاناة غير المبررة. وهذا يقلل من أثر الخطر أو التهديد، ويسهم في القدرة على الصمود. وتتمحور القدرات حول الروابط مع نظم الإنذار المبكر، وتشمل أنشطة مثل تخطيط الاستجابة، وتوفير الموارد، والتنسيق، والشراكات، والإجلاء، والتواصل بشأن المخاطر، والتدريب، والتمارين. ولا غنى عن الدعم الرسمي المؤسسي والقانوني ودعم الميزانية.

يبني التأهب القدرات اللازمة لإدارة جميع أنواع حالات الطوارئ بكفاءة، وتحقيق انتقال منظم من الاستجابة وصولًا إلى التعافي المستدام.

ويُعرِّف مكتب الأمم المتحدة للحدِّ من مخاطر الكوارث التأهب بأنه «المعرفة والقدرات التي تطورها الحكومات ومنظمات الاستجابة والتعافي المهنية والمجتمعات والأفراد للتنبؤ بآثار الأحداث أو الظروف الخطرة المحتملة أو الوشيكة أو الحالية، والاستجابة لها، والتعافي منها بشكل فعال».

والاستعداد، وَفقًا لتعريف المنظمة، هو «التفاعل بين إجراءات التأهب على المدى الطويل، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ. وتهدف التدخلات إلى بناء القدرات التشغيلية وتحسينها والحفاظ عليها للاستجابة للمخاطر، وضمان استدامة القدرات، وبالتالي الحفاظ على حالة الاستعداد للاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة».

الحيز المكاني

1-3-1 تنظيم الحيز المكاني لتفعيل الاستجابة

يجب أن تتسم المستشفيات بالمرونة، وأن تكون قادرة على تكييف المرافق أو الأماكن المتاحة لديها لتلبية متطلبات الطوارئ. ويجب تفعيل الوظائف التشغيلية الحيوية في مناطق معينة مُحددة مسبقًا في المستشفى. وينبغي النظر في تنفيذ الإجراءات الآتية:

- التحديد المسبق للمناطق التي سيكون لها دور حاسم في عمليات الاستجابة. ويمكن أن تشمل هذه المناطق استقبال المرضى وفرزهم؛ ومناطق العلاج المقسمة حسب الأولوية؛ ومنطقة الإجلاء/ الأمان؛ ومنطقة إزالة التلوث؛ ومركز عمليات الطوارئ في المستشفى؛ وما إلى ذلك. ويجب وضع الترتيبات الملائمة لدعم هذه الوظائف، وتجهيز الخطط والخرائط.
- تحديد المناطق التشغيلية باستخدام اللافتات أو العلامات الملونة أو الرموز، مثل الأسهم، لتوجيه تدفق المرضى أثناء الاستجابة للإصابات الجماعية.
- تحديد المرافق أو الأماكن التي يمكن تكييفها أو تحويلها لزيادة قدرة المستشفى على تقديم الرعاية الجماعية (مثل استخدام الممرات/ البهو، أو المساحات المفتوحة، أو صالة الألعاب الرياضية، أو قاعة الاستماع كمواقع بديلة للرعاية، أو استخدام قاعة الاجتماعات كمركز لعمليات الطوارئ بالمستشفى). وستتطلب مرافق الخفض التدريجي للرعاية اعتمادات وموارد بشرية محددة. (لمعرفة المزيد عن مرافق الخفض التدريجي للرعاية، انظر القسم 3: الاستجابة).
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لدعم تشغيل المجالات الوظيفية أثناء الاستجابة: مصادر المياه (ترتيبات الجريان السطحي)؛ ومعدات الحماية الشخصية المتاحة في منطقة إزالة التلوث؛ وعلامات/ أشرطة الفرز ومعدات الحماية الشخصية في منطقة الفرز؛ ومعدات الاتصال والخرائط والمخططات في مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى.
- تجميع المرضى في مجموعات، حسب خطر إصابتهم بالعدوى أو ما إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية لمرض معين أثناء فاشية. ويمكن أن يؤدي استخدام أجنحة منفصلة أو مبانٍ محددة أثناء فاشيات الأمراض المُعْدية إلى الحد من انتشار المرض (21). وأثناء التجميع حسب المجموعات، من المهم تخصيص مناطق مناسبة ومنفصلة لأفراد الأسر والزوار. وينبغي تعيين مسؤول اتصال بالمستشفى، وتقديم تحديثات منتظمة حول حالة المرضى.

الاستراتيجيات

2-3-1 برنامج التأهُّب لحالات الطوارئ

إن التأهب لحالات الطوارئ أكثر من مجرد وضع خطة. فهو يتطلب برنامجًا، مع خطة عمل واضحة وميزانية مقررة، وشخصًا متفرغًا مسؤولًا عن تنفيذه ورصده. ويوفر برنامج التأهب لحالات الطوارئ هيكلًا لوضع خُطط الاستجابة للطوارئ، والتعافي منها.

- ينبغي أن تسترشد خطط الاستجابة والتعافي بالمخاطر، وأن تستند إلى عملية سليمة لتقييم المخاطر. وينبغي وضعها بطريقة تشاركية وتشاورية، مع إشراك الإدارات الداخلية الرئيسية لتعزيز المسؤولية، والمؤسسات الخارجية مثل السلطات المحلية لإدارة الكوارث، وسلطات الصحة العامة المحلية، وإدارات المطافئ والشرطة، والجمعية الوطنية للصليب الأحمر/ الهلال الأحمر، وغيرها.
- يجب أن تكون المستشفيات على دراية بالخصائص الديموغرافية للسكان في المنطقة التي يخدمها المستشفى (مثل المسنين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة)، وبمرتسمات المخاطر المجتمعية. وتشكل هذه المعلومات الأساس اللازم لتطوير قدرات الاستجابة. ولأغراض التخطيط، يمكن للمستشفيات أن تستخدم البيانات الديموغرافية من وثائق التعداد المحلي، أو المسوحات، أو السجلات الإدارية من السلطات المحلية أو مراكز الصحة العامة.
- ينبغي ربط خطط المستشفيات بخطط الشبكة الصحية المحلية أو الموجودة في المنطقة، والخطط الاستراتيجية الوطنية.
- تكون الخطة عبارة عن وثيقة مكتوبة مفصلة تصف مَن يفعل ماذا، وكيف، وأين، ومتى. ولوزارة الصحة دورٌ معياري في وضع السياسات والمبادئ التوجيهية وإطار قياسي للمستشفيات لاتباعه في وضع خططها. وهذا يعزز بدوره التآزر والتشغيل البيني عند تفعيل الخطط أثناء الاستجابة.
- تُعدُّ الخطط وثائق حية تتطلب تحديثًا مستمرًا نظرًا لأن تفاصيل الخطة تصبح غالبًا قديمة بمجرد كتابتها. ويجب كذلك تنقيح الخطة في كل مرة تُفعّل فيها، لتعكس ما تم تعلمه، سواء أثناء التمارين السابقة للكوارث أو أثناء الاستجابة لحالة طوارئ حقيقية. وينبغي توثيق الدروس المستفادة وتبادلها عبر مختلف منصات التعلم وإدارة المعارف، مثل المؤتمرات وغيرها من فعاليات التعلم المشتركة، ومنها شبكات المستشفيات. يُرجى الرجوع إلى القسم 3-2 بشأن الاستعراض اللاحق للإجراءات وعملية استخلاص الدروس المستفادة للاطلاع على مزيد من المعلومات.

3-3-1 تخطيط استمرارية الخدمات

بمجرد أن يحدد المستشفى الخدمات التي يجب أن تظل مُفعَّلة في أعقاب وقوع أي كارثة، سيمكنه تحديد الموارد اللازمة من الخدمات الأخرى وتحديد أولوياتها لدعم هذه الوظائف الحيوية وتعزيزها، مثل وحدة الطوارئ، وقسم الجراحة، والمختبر، وما إلى ذلك. ويمكن إرجاء بعض الخدمات غير الأساسية أو تعليقها مؤقتًا، ومنها أقسام العيادات الخارجية والعمليات الجراحية الانتقائية. ويمكن اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن بمجرد تلبية الاحتياجات من الاستجابة وتقييم الموارد.

وخلال الاستجابة للكوارث الواسعة النطاق، غالبًا ما يتعذر على المستشفى أو أجزاء من المرفق مواصلة العمل، إما لأن المرفق نفسه قد تضرر وإما لأن الزيادة السريعة المفاجئة في الطلب على الرعاية الصحية تتجاوز طاقته الاستيعابية (مثلما حدث لبعض المستشفيات أثناء جائحة كوفيد-19). وللتخطيط لهذه السيناريوهات، يجب تحديد مواقع بديلة للرعاية. وينبغي أن تشمل الخطط النقاط التي تُتخذ القرارات على أساسها، والتي تحدد متى ينبغي تفعيل هذا النوع من المواقع، وكيفية إعداد المرفق وتجهيزه، ومتطلبات التوظيف، ونقل المرضى إلى الموقع الجديد.

ويُعدّ الحصول على المعلومات والبيانات جانبًا آخر من جوانب استمرارية خدمات المستشفيات. ولما كانت معظم نظم إدارة معلومات المستشفيات قد تحولت إلى سجلات بيانات إلكترونية، فإن نظم النسخ الاحتياطي وأمن البيانات ضروريان لتقليل تعطل المعلومات والإجراءات الإدارية والسريرية إلى الحد الأدنى.

4-3-1 خطة المستشفى للاستجابة للطوارئ بما يشمل كلَّ الأخطار

تتبع هذه الخطة الشاملة نهجًا متعدد الأخطار، مما يُمكِّن المستشفيات من توسيع نطاق قدرتها على التعامل مع جميع الأخطار من خلال تعزيز الوظائف الأساسية للاستجابة للطوارئ. وتُعدُّ خطة الاستجابة لحالات الطوارئ بما يشمل كل الأخطار نهجًا منهجيًّا ومنسقًا للتخفيف من وطأة حالات الطوارئ، والاستجابة لها، والتعافي منها. ويُقدم هذا النهج التوجيه والتعليمات للموظفين الرئيسيين بشأن أدوارهم ومسؤولياتهم، ويحدد بروتوكولات التواصل، وإجراءات إدارة الموارد، وخطط الإجلاء، وتقييم الأحداث، واستراتيجيات صُنع القرار. وينبغي النظر في الخطوات الآتية عند وضع هذه الخطة:

1. إنشاء لجنة تخطيط: تشكيل لجنة تخطيط متعددة التخصصات تضم ممثلين من مختلف أقسام المستشفى، بما في ذلك الإدارة، والخدمات السريرية، وإدارة الطوارئ، والأمن، والمرافق، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات. وستقود هذه اللجنة عملية التخطيط.

2. إجراء تحديد للأخطار وتقييم للمخاطر: تحديد الأخطار والمخاطر المحتملة، ومنها الأخطار الطبيعية (مثل الزلازل والأعاصير)، والأخطار التكنولوجية (مثل انقطاع التيار الكهربائي، وانسكاب المواد الخطرة)، والأخطار البيولوجية (مثل الجوائح وفاشيات الأمراض المُعْدية)، والأخطار المجتمعية (مثل حوادث النقل والتجمعات الحاشدة ووقائع إطلاق النار النشط). ويجب تقييم احتمال كل خطر وأثره المحتمل لتحديد أولويات جهود التخطيط.

3. تحديد الوظائف الأساسية: تحديد وظائف المستشفى التي يجب الحفاظ على استمرارها أثناء الطوارئ. وقد تشمل رعاية المرضى، والاتصالات، وإدارة الموارد، والمرافق، والأمن، وما إلى ذلك. ويجب تحديد أولويات هذه الوظائف استنادًا إلى مدى أهميتها لسلامة المرضى، والقدرة على تنفيذ مهمة المستشفى.

4. وضع إجراءات الاستجابة للطوارئ: وضع إجراءات موحَّدة للاستجابة للطوارئ لكل خطر يُتعرَّف عليه. وينبغي أن يشمل ذلك تعليمات واضحة وموجزة بشأن إجراءات الموظفين. ويجب تناول المجالات الرئيسية مثل تقييم الأحداث والتبليغ بها، والتدبير العلاجي للمرضى، والاتصالات، والإجلاء، وإدارة الموارد، وأدوار الموظفين ومسؤولياتهم، والتنسيق مع الوكالات الخارجية.

5. إنشاء نظام إدارة الأحداث: يُعدُّ نظام إدارة الأحداث هيكلًا موحدًا لإدارة حالات الطوارئ. ويجب أن يُعين قائد للأحداث يكون مسؤولًا عن التنسيق العام واتخاذ القرارات. كما تنشأ مناصب للوظائف القيادية، مثل العمليات، والتخطيط، واللوجستيات، والشؤون المالية/ الإدارية، لضمان إدارة الموارد والموظفين بكفاءة.

6. إنشاء مركز لعمليات الطوارئ: يُعين موقع فعلي لمركز عمليات الطوارئ، الذي سيكون بمثابة مركز للقيادة والتنسيق المركزي. ويُزود مركز عمليات الطوارئ بأدوات الاتصالات اللازمة، ونُظُم المعلومات، وقدرات إدارة الموارد. وتُحدد متطلبات التوظيف والبروتوكولات اللازمة لتفعيل مركز عمليات الطوارئ. ويمكن، كخيار مطروح، تحويل قاعة اجتماعات موجودة بالفعل إلى مركز لعمليات الطوارئ.

7. التنسيق مع الشركاء الخارجيين: تُقام الشَّرَاكات، ويُضفى الطابع الرسمي على الاتفاقات مع كيانات خارجية، ومنها الوكالات المحلية لإدارة الطوارئ، والمستشفيات المجاورة، وإدارات الصحة العامة، والمستجيبين الأوائل. ويُجرى التعاون بشأن التخطيط، وتبادل الموارد، وتبادل المعلومات، واتفاقات المساعدة المتبادلة. ويجب التأكد من وجود خطوط واضحة للتواصل والتنسيق أثناء حالات الطوارئ.

8. تدريب الموظفين وتثقيفهم: تُعقد دورات تدريبية وتثقيفية منتظمة لتعريف موظفي المستشفيات بخطة الاستجابة للطوارئ، وأدوارهم ومسؤولياتهم، والإجراءات ذات الصلة. ويجب توفير التدريب على إدارة الأحداث، والتواصل بشأن حالات الطوارئ، والإسعافات الأولية، والموضوعات الأخرى ذات الصلة. وينبغي التأكد من دراية الموظفين بأدوارهم داخل نظام إدارة الأحداث.

9. اختبار الخطة والتمرين عليها: تُجرى تمارين وتدريبات منتظمة لاختبار فعالية خطة الاستجابة للطوارئ. وقد ينطوي ذلك على تمارين المحاكاة النظرية، أو تمارين وظيفية، أو تمارين محاكاة واسعة النطاق. ويجب تقييم الاستجابة، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، وتنقيح الخطة وفقًا لذلك. ومن الضروري إشراك الشركاء الخارجيين والوكالات الخارجية في تمارين مشتركة لتعزيز التنسيق والتشغيل البيني.

10. الحفاظ على الخطة وتحديثها: تُراجع خطة الطوارئ وتُحدث، على الأقل سنويًّا، أو عند حدوث تغييرات كبيرة في البنية الأساسية للمستشفى أو عملياتها أو لوائحها. وينبغي البقاء على علم بالتهديدات المستجدة، وأفضل الممارسات المتطورة في إدارة الطوارئ. ويجب مواصلة تحسين الخطة استنادًا إلى الدروس المستفادة من الأحداث الحقيقية والتمارين والتعقيبات المُقدمة من الموظفين والشركاء الخارجيين.

5-3-1 فريق إدارة الأحداث بالمستشفى

فريق إدارة الأحداث بالمستشفى هو مجموعة من الأفراد المسؤولين عن إدارة الاستجابة لحالات الطوارئ أو الأحداث في المستشفى والتنسيق بشأنها. وعادةً ما يُفعّل عمل فريق إدارة الأحداث بالمستشفى أثناء الأحداث الكبرى التي تتطلب اتباع نهج منسق ومنظم لإدارة الطوارئ.

الإطار 4. **وظائف فريق إدارة الأحداث بالمستشفى**

وظائف فريق إدارة الأحداث بالمستشفى

- قيادة الأحداث: من شأن تعيين مدير أحداث أن يُرسي قواعد هيكل واضح للقيادة. ويكون مَن يشغل هذا المنصب مسؤولًا عن إدارة الحدث ككل، والتوجيه الاستراتيجي، واتخاذ القرارات.
- التنسيق والتواصل: ضمان التنسيق والتواصل الفعالين بين الأقسام والموظفين والوكالات الخارجية المشارِكة في الاستجابة للطوارئ، مما يؤدي إلى سهولة تدفق المعلومات، وإنشاء قنوات التواصل، وضمان نشر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.
- إدارة الموارد: تقييم الاحتياجات من الموارد، وتحديد الموارد المتاحة، وتنسيق تخصيصها واستخدامها. وتشمل الموارد الموظفين والمعدات والإمدادات والمرافق. ويمكن لفريق إدارة الأحداث بالمستشفى أيضًا أن ينشئ نظمًا لتتبع الموارد، والمشتريات، والدعم اللوجستي.
- تقييم الأحداث والإلمام بالوضع: جمع المعلومات وتحليلها لتقييم أثر الحدث ونطاقه واحتياجاته المتغيرة. والحفاظ على الإلمام بالوضع من خلال رصد تطور الحدث وتقييم الأخطار واستباق التحديات أو التغيرات المحتملة في الموقف.
- التخطيط والعمليات: يشمل هذا وضع خطط عمل الأحداث واستراتيجياتها وإجراءاتها التشغيلية استنادًا إلى التقييمات والأهداف. وكذلك الإشراف على تنفيذ إجراءات الاستجابة، وإدارة الفترات التشغيلية الخاصة بالأحداث، وتكييف الخطط حسب الحاجة.
- السلامة والأمن: يكفل هذا سلامة وأمن المرضى والموظفين والزوار أثناء الحدث. وتُنفذ تدابير للتخفيف من وطأة المخاطر، ومواجهة المخاوف الأمنية، ووضع بروتوكولات لإدارة الإتاحة، ومراقبة حركة الدخول والخروج، والجوانب الأخرى المرتبطة بالسلامة.

الإطار 5. عناصر فريق إدارة الأحداث بالمستشفى

عناصر فريق إدارة الأحداث بالمستشفى

- القيادة والأدوار: تحديد الأدوار والمسؤوليات وعلاقات التسلسل الإداري بشكلٍ واضح لأعضاء الفريق، وتوفير التدريب لقائد الحدث ورؤساء الأقسام الرئيسية.
- الهيكل التنظيمي: إنشاء مخطَّط تنظيمي يعكس هيكل فريق إدارة الأحداث، والتسلسل الإداري، وتدفق الاتصالات.
- إجراءات التشغيل الموحدة: وضع إجراءات تشغيل موحدة تحدد بروتوكولات تفعيل الأحداث؛ والاتصالات، واتخاذ القرارات، وإدارة الموارد، والتنسيق.
- نُظم الاتصالات: إنشاء نظم اتصالات موثوقة، وتشمل بدائل للوسائل التقليدية.
- التدريب على التأهب: توفير التدريب على مبادئ إدارة الأحداث، وإجراءات الطوارئ، والأدوار، والمسؤوليات. وإجراء تدريبات وتمارين ومحاكاة منتظمة لتحسين التأهب، وضمان التنسيق الفعال بين أعضاء الفريق.
- التفعيل والاستجابة: تفعيل فريق إدارة الأحداث استجابةً للأحداث الكبرى، باتباع البروتوكولات والمعايير المعمول بها. وتجميع الفريق، وعقد جلسات إعلامية أولية، وضمان الانتقال السلس إلى وضع الاستجابة.
- تخطيط إجراءات الأحداث: وضع خطط عمل الأحداث مع أهداف الاستجابة واستراتيجياتها ومهامها المحددة. ويشمل هذا أيضًا تحديد الفترات التشغيلية، وإسناد المسؤوليات، وتنسيق الأنشطة داخل فريق إدارة الأحداث ومع الكيانات الأخرى المعنية بالاستجابة.
- التوثيق والإبلاغ: الاحتفاظ بسجلات دقيقة للأنشطة والقرارات المتعلقة بالأحداث واستخدام الموارد. وإعداد تقارير الحالة، وتحديثات حول حالة الأحداث، وغيرها من الوثائق اللازمة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
- التنسيق مع الشركاء الخارجيين: إقامة اتصالات وتنسيقات فعالة مع الوكالات الخارجية، ومنها المؤسسات المحلية لإدارة الطوارئ، وإدارات الصحة العامة، وسلطات إنفاذ القانون، وغيرها من مرافق الرعاية الصحية. وتعزيز الشراكات واتفاقات المساعدة المتبادلة، وتبادل المعلومات لتعزيز قدرات الاستجابة ككل.

6-3-1 مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى

يحتل مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى موقعًا مركزيًّا داخل المستشفى أو المرفق الصحي، ويجري فيه تنسيق وإدارة الموظفين الرئيسيين والموارد الرئيسية أثناء حالات الطوارئ أو الأحداث الكبرى. ويكون بمثابة المركز الرئيسي للاتصالات وصُنع القرار وتخصيص الموارد، مما يكفل استجابة منظمة وفعالة. وفيما يلي لمحة عامة عن الوظائف والعناصر الرئيسية لمركز قيادة المستشفى.

الإطار 6. وظائف مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى

وظائف مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى

- إدارة الأحداث والتنسيق بشأنها: هذا من شأنه أن ييسر الإدارة والتنسيق الشاملين لاستجابة المستشفى لحالات الطوارئ. ويكفل أن تعمل جميع الأقسام والموظفين معًا، وفقًا للبروتوكولات والإجراءات المتفق عليها.
- الإلمام بالوضع: يحافظ مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى على فهم الحدث في حينه، وإدراك الوضع التشغيلي للمستشفى. وهو يجمع المعلومات من مصادر مختلفة، ويحللها، ويرصد تطور الحدث، ويُقدر أثره على المرفق.
- اتخاذ القرارات ووضع السياسات: يوفر معلومات دقيقة، وفي الوقت المناسب للقيادة وأصحاب المصلحة لدعم عملية اتخاذ القرار، ويساعد في وضع السياسات والإجراءات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالحدث، بما يضمن استجابة متسقة ومترابطة.
- إدارة الموارد: تُقدر احتياجات الموارد وتوافرها داخل المستشفى، وتشمل الموظفين والإمدادات والمعدات والحيز المكاني. وتنسق عملية تخصيص الموارد واستخدامها، مع ضمان توجيهها إلى المجالات ذات الأولوية القصوى.
- الاتصالات وإدارة المعلومات: إنشاء قنوات للاتصالات الداخلية في المستشفى وخارجه مع أصحاب المصلحة والوكالات المعنية، وضمان تدفق المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب، وتيسير التنسيق، وإطلاع الموظفين وأصحاب المصلحة الرئيسيين على آخر المستجدات.
- التنسيق مع الشركاء الخارجيين: التواصل مع المنظمات الخارجية، مثل وكالات إدارة الطوارئ، وإدارات الصحة العامة، ومرافق الرعاية الصحية الأخرى، وتبادل المعلومات، وتنسيق الدعم المتبادل للمساعدة، والتعاون في جهود الاستجابة الأوسع نطاقًا.
- تتبع المرضى وتوفير التدبير العلاجي لهم: الإشراف على تتبع المرضى، وتوفير التدبير العلاجي لهم على مستوى المرفق. وهذا يضمن فرز المرضى وعلاجهم ونقلهم على النحو المناسب حسب الضرورة، مع الاحتفاظ الدقيق بسجلات عن حالة المرضى وموقعهم.
- استمرارية العمليات: تساعد في الحفاظ على وظائف المستشفى وخدماته أثناء الطوارئ. وتعمل على تقييم الآثار التشغيلية ومعالجتها، ووضع خطط احترازية، وتنسيق استئناف العمليات العادية بعد وقوع الحدث.

الإطار 7. عناصر مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى

عناصر مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى

- الحيز المكاني المادي: يحتاج مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى إلى حيز مكاني مادي مخصص له داخل المستشفى بحيث يمكنه استيعاب الموظفين ونظم الاتصالات وعرض المعلومات وأدوات إدارة الموارد. وينبغي أن يكون هذا الحيز آمنًا، ويمكن الوصول إليه، ومُجهزًا بالتكنولوجيا والبنية الأساسية اللازمة.
- فريق إدارة الأحداث: يتضمن الموظفون الرئيسيون أعضاء فريق إدارة الأحداث، ورؤساء الأقسام، والقادة الإداريين، والخبراء المتخصصين في المجال. ولكلٍّ منهم مسؤوليات وهياكل تسلسل إداري مُحددة بوضوح.
- نُظم الاتصالات: تُعد نظم الاتصالات الموثوقة أمرًا أساسيًّا، وقد تشمل الهواتف وأجهزة اللاسلكي والاتصال بالإنترنت، وشبكات الحاسوب، وغيرها من أدوات الاتصالات الداخلية والخارجية.
- أدوات إدارة المعلومات: تتيح هذه الأدوات جمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وتشمل نُظم الكمبيوتر، وشاشات العرض، وبرمجيات إدارة الأحداث، ومنصات تبادل المعلومات.
- تتبع الموارد وإدارتها: ينبغي أن يكون لدى مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى نُظُم لإدارة المخزون وبرمجيات تتبع لإدارة موارد المستشفى، وتشمل الموظفين والإمدادات والمعدات والأسرَّة.
- إجراءات التشغيل الموحدة: تحدد إجراءات التشغيل الموحدة الموثقة بشكل جيد الوظائف والأدوار والمسؤوليات. وينبغي مراجعتها وتحديثها وإطلاع الموظفين عليها بانتظام.
- نُظم التشغيل الاحتياطي وخطة البدائل الجاهزة: لضمان استمرار العمليات، ينبغي أن يكون لمركز القيادة نظام طاقة احتياطي، ونُظم اتصالات بديلة، وخطط احترازية.

7-3-1 التدبير العلاجي للإصابات الجماعية وإدارة الوفيات الجماعية:

تستند خطط **التدبير العلاجي للإصابات الجماعية** إلى قدرة وحدات الطوارئ في المستشفيات على توفير التدبير العلاجي لضحايا الرضوح خلال الأوقات الروتينية، مثل الحوادث المرورية أو الصناعية الكبرى. وأثناء الكوارث الواسعة النطاق، يجب على المستشفيات أن تتعاون مع الشركاء الآخرين في إطار نظام شامل يضم أصحاب المصلحة من السلطات المحلية، والمؤسسات المعنية بالاستجابة، والمستشفيات الأخرى.

ونظرًا لأن الموارد اللازمة لتلبية متطلبات الاستجابة للطوارئ محدودة، يجب أن تشمل الاستراتيجيات إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد حيث تشتد الحاجة إليها (وهذا من شأنه أن يساعد أيضًا في إنقاذ الأرواح). ويبدأ التخطيط للتعامل مع الإصابات الجماعية من منطقة وقوع الحدث (منطقة الأثر)، ويراعي المستجيبين الأوائل ونقل المرضى الخاضع للرقابة، حتى لا يثقل ذلك كاهل أي مستشفى منفردًا. ومع تطور الحدث، يجب أن تراعي الاستراتيجية أيضًا التدبير العلاجي للمرضى عند وصولهم إلى المستشفى، وهو ما يتطلب التنسيق مع مختلف خدمات المستشفى/ أقسامه، ويشمل ذلك الحاجة المحتملة للنقل الثانوي للمرضى إلى مرافق أخرى لاستمرارية الرعاية. وينبغي للمستشفيات أن تبني القدرات اللازمة للتعامل مع التدخلات الحاسمة المُبيَّنة في خطط المستشفيات للاستجابة. ويشمل التخطيط لأحداث الإصابات الجماعية الآتي:

- آلية للإدارة الداخلية للحدث، ترتبط بهياكل ونظم الإدارة المحلية والوطنية للأحداث. ويتولى فريق إدارة الأحداث بالمستشفى وظائف القيادة والرقابة والتنسيق والاتصالات، التي يضعها مركز عمليات الطوارئ المعين في المستشفى.

- يجب تنسيق الترتيبات بشأن استقبال المرضى، وفرز الإصابات الجماعية، والرعاية الطارئة، بقيادة قسم الطوارئ، مع خدمات المستشفى الأخرى مثل المختبر والأشعة والجراحة ووحدات رعاية الحالات الحرجة والعنابر.
- يجب أن تحدد خطط الاستجابة كيفية دعم الخدمات غير الطبية الأخرى بالمستشفى لجهود الاستجابة:

◊ الهندسة/ الصيانة، لضمان توفر شرايين الحياة في المستشفى دون انقطاع لدعم العمليات الحيوية مثل الطاقة والمياه ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والاتصالات وإدارة النفايات، وما إلى ذلك، عندما يتضرر أيضًا مقدمو الخدمات المحليون. وتؤدي الوحدة دورًا في تجهيز مواقع رعاية بديلة؛ ومركز عمليات الطوارئ بالمستشفى؛ ومرافق راحة الموظفين الذين يعملون لنوبات عمل ممتدة.

◊ الترتيبات الإدارية والمالية، ضرورية للحصول بسرعة على احتياطات نقدية لشراء السلع والخدمات في حالات الطوارئ، ويشمل ذلك إبرام اتفاقات المساعدة المتبادلة مع البائعين. وينبغي أن تخطط إدارة المستشفى لتبادل المعلومات الحيوية المتعلقة بتعداد المرضى، والسعة السريرية، وقائمة الموارد (المواد والموظفين على حد سواء)، وما إلى ذلك مع فريق إدارة الأحداث بالمستشفى لتيسير اتخاذ القرارات. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يجب عليها توثيق السجلات الخاصة بالمشتريات والتعاقد والاحتفاظ بها. وسيكون تحليل هذه المعلومات عنصرًا مهمًّا من عناصر الاستعراض اللاحق للإجراءات.

◊ الأمن، لضمان الرقابة على الدخول إلى المناطق الحرجة في المستشفى والخروج منها. ويهدف هذا إلى منع الاكتظاظ، وتوفير بيئة عمل آمنة لموظفي المستشفى، وضمان التدفق السلس للمركبات والأشخاص داخل المستشفى ومحيطه. وتتولى هذه الوحدة أيضًا التنسيق مع وحدات إنفاذ القانون المحلية عند الاقتضاء.

◊ إدارة التغذية، تكفل كفاية الإمدادات الغذائية للمرضى والموظفين وجودتها، ولا سيما خلال عمليات الاستجابة الممتدة.

تعالج **إدارة الوفيات الجماعية** التحدي الذي تواجهه المستشفيات عند إدارة عدد كبير من الجثث. فمعظم المستشفيات إما لا تمتلك خطة لإدارة الوفيات الجماعية، وإما أن الخطة الحالية غير كافية أو قديمة. ويجب أن تُحدَّد مقدمًا القدرة الإضافية على تلبية الاحتياجات المفاجئة. ويجب وضع خطط لتوسيع المساحة الحالية المتاحة في المشرحة، إذا لزم الأمر، واستكشاف بدائل أخرى، مثل شاحنات التخزين المبردة أو حيز في الثلاجات، مع إيلاء العناية الواجبة للحساسية الاجتماعية والثقافية لهذه المسألة. ويمكن للمستشفيات أن تُنسق الخطط مع السلطات المحلية ومؤسسات الاستجابة من أجل التعامل مع الجثث في الموقع بدلًا من نقلها إلى المستشفى، مما يسمح للمرافق الصحية بتركيز الجهود والموارد على الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

ويجب أن تكون المستشفيات قادرة على تحديد المرضى الذين تعرضوا لمواد خطرة تشكل تهديدًا على صحتهم وسلامة المرفق وإزالة التلوث منهم. ويجب على المستشفيات أن تخطط لأن يتولى الموظفون المدربون والمحميون تنفيذ إجراءات إزالة التلوث بعيدًا عن قسم الطوارئ، باستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة. ويجب مراعاة خصوصية المرضى (الحفاظ على الأشياء الثمينة والملابس الخاصة بهم)، والتعامل مع أي أسلحة تُجلب إلى المستشفى.

ستؤثر **حالات فشل الاتصالات**، التي غالبًا ما تكون إحدى العواقب التي يمكن التنبؤ بها والمترتبة على كارثة، تأثيرًا كبيرًا على جهود الاستجابة. ويجب أن تفحص المستشفيات نُظُم الاتصالات الداخلية (الموظفين والمرضى) وقنوات الاتصال مع الوكالات الخارجية. وهناك حاجة إلى مستويات متعددة لخطة البدائل الجاهزة للتعامل مع التحديات المتوقعة فيما يتعلق بالاتصالات. ويشمل ذلك أجهزة اللاسلكي الثنائية الاتجاه، وشبكات التخاطب العامة، والهواتف المحمولة، والرسائل النصية القصيرة، وخطوط الهاتف المخصصة في مركز عمليات الطوارئ. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للنظام الاحتياطي استخدام مراسيل لحمل الرسائل (أشخاص يوصِّلون الرسائل بأنفسهم).

8-3-1 خطة التعامل مع فاشيات الأمراض السارية

يمكن أن تطغى فاشيات الأمراض المعدية على قدرة المستشفى على تقديم الخدمات الروتينية. وقد لا تكون الموارد البشرية والمادية، ومنها حيز المستشفى والأدوية، كافية لتلبية الطلب، لا سيما في حالة انتشار وباء يدوم عدة أسابيع أو أشهر أو سنوات، كما كان الحال مع جائحة كوفيد-19. ويتطلب هذا النوع من المواقف أن يكيف المرفق الصحي أولوياته وأعماله الروتينية لتقديم استجابة منسّقة ومنهجية للوضع الآخذ في التطور بسرعة، والذي قد يكون معقدًا. وكذلك، تؤثر الأوبئة والجوائح على قدرة القطاعات الأخرى على مواصلة تقديم الخدمات، ويمكن أن يكون لها أثر اجتماعي واقتصادي كبير على المجتمع المحلي الأوسع. وينبغي أن تأخذ المستشفيات بعين الاعتبار العواقب المحتملة على الموظفين (مثل وسائل النقل والأعمال المصرفية) وعلى مقدمي الخدمات الخارجية، لا سيما شرايين الحياة في المستشفى وموردي الإمدادات الطبية الحيوية.

وعلى المستشفيات أن تراجع مدى استعدادها للتعامل مع تدفق المرضى وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية. ويشمل ذلك إعطاء الأولوية لإجراءات التصدي للتهديدات البيولوجية وتنفيذها، لا سيما تلك التي قد تسبب اعتلالات تنفسية حادة وخيمة، من أجل تحديد الحالات المشتبه فيها، والحد من انتقال العدوى داخل المرفق، وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة. وتشمل الإجراءات تفعيل بروتوكولات وإجراءات العزل في الحيز المادي الفعلي؛ وتثقيف الموظفين وتدريبهم على استخدام معدات الحماية الشخصية؛ والتدبير العلاجي للمرضى؛ وجمع العينات ومناولتها.

وينبغي للمستشفيات، أثناء الطوارئ البطيئة الحدوث، مثل فاشية الأمراض المُعْدية، أن يكون لديها الآتي:

- نظام ترصُّد في المستشفى.
- تعريف مُحدَّث لـ «الحالة» من وزارة الصحة.
- بروتوكولات الفرز الخاصة بفاشيات الأمراض.
- عددٌ كافٍ من معدات الوقاية الشخصية، وتدريب الموظفين على استخدامها على نحو صحيح.
- بروتوكولات وحدة الطوارئ لعزل المرضى المشتبه فيهم.
- مسارات إحالة مُتفق عليها، في الداخل والخارج على حد سواء.
- تفعيل نظام إدارة المعلومات بالمستشفى، على أن يشكل الموظفون المعنيون بالوقاية من العدوى ومكافحتها جزءًا من فريق إدارة الأحداث بالمستشفى.

الإطار 8. تعزيز استعداد المستشفى لحالات الطوارئ الناجمة عن الفاشيات

تعزيز استعداد المستشفى لحالات الطوارئ الناجمة عن الفاشيات

- تعتبر القيادة وفريق إدارة الأحداث بالمستشفى ضروريين لإدارة عمليات الطوارئ. وفي المستشفيات التي تمتلك بالفعل خططًا لإدارة الأزمات والتأهب لحالات الطوارئ، يُقترح تكييف هذه الخطط بما يتلاءم مع المتطلبات الأساسية لكل من الاستجابة للفاشيات والحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية الروتينية.
- يكفل كلٌّ من التنسيق والتواصل الاسترشاد بالبيانات في تحليل المخاطر واتخاذ القرارات، مما يضمن بناء ثقة فعالة بين جميع موظفي المستشفى وأصحاب المصلحة. ويشمل ذلك التواصل والتنسيق داخل المستشفى، وإقامة روابط مع السلطات المحلية والوطنية، ومنها المجتمعات المحلية وخدمات الصحة الأولية.
- يُعدُّ الترصُّد وإدارة المعلومات أمرين أساسيين لرصد الفاشيات ومكافحتها، لا سيما في المستشفيات ومرافق الرعاية الطويلة الأجل. وتُكمِّل إدارة معلومات المستشفيات الترصُّد، وهذا مهم لإذكاء الوعي العام بشأن المخاطر الصحية ذات الصلة والتدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر.
- التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية سيساعدان في الحد من انتشار الشائعات حول فاشية ما أو وقفها، ويمكن استخدامهما لنقل معلومات دقيقة وواضحة عن المرض.
- القدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة (الموارد البشرية/ السعة السريرية/ المعدات/ الإمدادات) تُمكِّن المستشفى من زيادة قدرته على تلبية الاحتياجات المفاجئة أو الآخذة في التزايد بسرعة طلبًا للخدمات. ويجب مراعاة الذين يقدمون الخدمات الصحية للسكان المتضررين: أعضاء الفرق الطبية في حالات الطوارئ، والأطباء، وطواقم التمريض، وغيرهم ممن قد يأتون من بلدان أخرى أو من أجزاء أخرى من البلد نفسه لم تتضرر بالأزمة الراهنة، وما إلى ذلك.
- استمرارية خدمات الدعم الأساسية هي مسألة يجب أن تتناولها خطط الاستجابة. وبينما تتطور الفاشية، وتتطلب التوسُّع السريع في التأهب للطوارئ والاستعداد الميداني، يجب على المستشفيات أيضًا أن تُولي اهتمامًا بالحاجة إلى الرعاية الطبية والجراحية الروتينية.
- التدبير العلاجي للمرضى يشمل حالات الإدخال إلى المستشفى أو الإحالة، والفرز، والتشخيص، والعلاج، وتدفق المرضى، وتتبعهم، وتخريجهم، ومتابعتهم، بالإضافة إلى إدارة خدمات الدعم، والخدمات الصيدلانية، ووظائف اللوجستيات والإمدادات.
- الوقاية من العدوى ومكافحتها تقلل من خطر انتقال العدوى إلى موظفي المستشفى والمخالطين المباشرين والزوار والمرضى الأصحاء الآخرين أو النزلاء في مرافق الرعاية الطويلة الأجل الذين يتلقون الرعاية داخل المستشفى.
- التحديد والتشخيص السريعان يضمنان سلسلة منطقية وعملية من الأحداث أثناء التدبير العلاجي للحالات. وستقدم الخدمات المختبرية الدعم لبعض الأنشطة مثل الترصد والوقاية من العدوى ومكافحتها والتدبير العلاجي للمرضى.
- الصحة المهنية، والصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي هي أمور ضرورية للحد من الآثار النفسية والاجتماعية الضارة لحالة الطوارئ على مرضى المستشفيات والموظفين وأفراد المجتمع المحلي المتضرر.

النُّظم

9-3-1 المشاركة المجتمعية

كما ذُكر آنفًا، فإن حالات الطوارئ والكوارث تُنهك إلى حد كبير الموارد المحدودة للمستشفى ونظام الاستجابة المحلي الأوسع نطاقًا. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في السيطرة على الوضع الفوضوي في الموقع، إذ تنطوي الاتصالات في أغلب الأحيان على مشاكل (انظر القسم 1-3-7 حول التدبير العلاجي للإصابات الجماعية وإدارة الوفيات الجماعية). وفي كثير من الأحيان، ينقل الأشخاص الموجودون في الموقع المرضى إلى أقرب مستشفى، باستخدام أي وسيلة نقل متاحة، دون الاتصال بالمستشفى الذي سيستقبل الحالة. ويمكن أن يطغى ذلك على قدرة أقرب مستشفى، ويقلل من استخدام المرافق المجاورة الأخرى.

ويجب أن ترتبط خطط الطوارئ في المستشفيات بالخطط المجتمعية من أجل تضافر الجهود، وجعل الاستجابة للطوارئ تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. ويمكن للمستشفيات أن تبدأ هذه العملية من خلال المشاركة في التأهب المجتمعي وتطوير مهارات الاستجابة الأساسية لدى المستجيبين الأوائل في المجتمع، بحيث يُصنف المرضى وتُحدد أولوياتهم ويُنقلون إلى المستشفى المناسب. وهذا من شأنه أن يساعد على تحديد المرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية ومنحهم الأولوية؛ وتقليل الوقت الضائع (مما يساعد في إنقاذ الأرواح)؛ والحيلولة دون إنهاك أي مستشفى. ويمكن مواصلة تعزيز التوعية المجتمعية من خلال التخطيط، وتمارين المحاكاة، والاستعراضات اللاحقة للإجراءات.

10-3-1 التواصل بشأن المخاطر

يكون التواصل بشأن المخاطر استراتيجية فعالة عندما يتفاعل الجمهور والمجتمع المحلي المتضرر مع السلطات الصحية والخبراء باعتبارهم شركاء على قدم المساواة في تبادل المعلومات والمشورة والآراء. ويمثل التواصل بشأن المخاطر حلقة وصل مع الجمهور، إذ يعمل على إقناع المجتمعات المحلية المستضعفة بالمشاركة في الجهود الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث، مع مراعاة احتياجاتها وتصوراتها وتقاليدها وثقافتها.

وينبغي أن يكون لدى المستشفيات خطة للعمل مع وسائل الإعلام، على الرغم من أنه لا يُوصى بالسماح لوسائل الإعلام بدخول المستشفى أثناء الكوارث. ويمكن بدلًا من ذلك، أن تتلقى وسائل الإعلام تحديثات منتظمة وواقعية عن حالة المرفق والأنشطة الجاري تنفيذها. وينبغي تحديد مواعيد الجلسات الإعلامية في مكان وزمان محددين سلفًا. ويُعين ضمن فريق إدارة الأحداث بالمستشفى مسؤولٌ إعلامي لقيادة جهود التواصل، تحت إشراف قائد الأحداث في المستشفى. ويضطلع المسؤول الإعلامي بالمسؤوليات الآتية:

- إنشاء منطقة مخصصة لتقديم إحاطات بالمعلومات وعقد جلسات إعلامية، تقع بعيدًا عن مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى والمناطق التي يُعالَج فيها المرضى.
- التواصل مع المسؤولين الإعلاميين المجتمعيين والمسؤولين الإعلاميين في الوكالات المحلية للتعاون في إعداد رسائل إعلامية ومعلومات عامة متسقة.

- عرض المعلومات والرسائل الإعلامية على قائد الحدث ليراجعها، ويعتمدها قبل نشرها.
- إعداد مواد إعلامية وتحديث الرسائل عن الوضع الراهن بانتظام لإطلاع موظفي المستشفى والمرضى والزوار على آخر المستجدات بشأن الحدث والوضع الراهن في المجتمع المحلي والمستشفى.

الإطار 9. إعداد رسائل التواصل بشأن المخاطر

إعداد رسائل التواصل بشأن المخاطر

- وضع الأهداف والرسائل الرئيسية. يُعزَى الفشل في التواصل بشكل فعال في أغلب الأحيان إلى عدم وجود أهداف تواصل واضحة ورسائل رئيسية. وينبغي الانتهاء من وضع الأهداف وتحديد الرسائل قبل إصدار أي تعليق عام، لا سيما في حالات الطوارئ. ويمكن لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تقديم الإرشادات التقنية في هذا الشأن.
- تحديد الجمهور. لا يشكل عامة الناس جماعةً واحدةً، وإنما هم مجموعة من الجماعات الفرعية. وسيتطلب التواصل الفعال تحديد هذه الفئات الفرعية أو تقسيمها، وإعداد رسائل مُوجَّهة (مثل الفئات السكانية المُعرَّضة للخطر، أو المؤثرين، أو صانعي القرارات، أو أولئك الذين لم يتضرروا بشكل مباشر ولكنهم معنيون بحالة الطوارئ).
- اختبار الرسائل. الرسالة التي تصلح بالنسبة لك، قد لا تصلح بالضرورة لجمهورك. ومن شأن اختبار الرسائل أن يساعدك في دراسة افتراضاتك حول ما سينجح، ولماذا. إذ يفيدك ذلك في معرفة المزيد عن الجمهور المستهدف الذي تتواصل معه. وسيوفر الاختبار دليلًا على أن التواصل ناجح، أو سيوضّح كيفية تعديله. وهي عملية ضرورية توفر الوقت والمال بعدم إهدار الجهود على طرق التواصل غير الفعالة.
- القنوات والأدوات. يجب تصميم رسائل وقنوات التواصل بما يتلاءم مع الجمهور المُستهدَف، حتى وإن كان محتوى الرسالة متماثلًا في الأساس. ويجب أن تحوز المصادر ثقة الفئات السكانية المستهدفة (مثل وسائل التواصل الاجتماعي، ومجالس المجتمعات المحلية، ووسائل الإعلام الإذاعية، وقادة المجتمع، والشخصيات المؤثرة).
- الرصد. يتمثل الغرض من الرصد في تحديد ما إذا كان يمكن الوصول إلى الجمهور المستهدف المقصود، وما إذا كانت الرسائل مفهومة. ويجب رصد التغيرات السلوكية المدروسة التي حدثت. ويمكن استخدام الاتجاهات الوبائية ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وعقد مقابلات مع مصادر المعلومات الرئيسية، وإجراء مسوحات للتحقق من فعالية الرسائل. ويساعد الرصد أيضًا في التعامل مع المعلومات المغلوطة ومواجهتها وتصحيحها.

11-3-1 تفعيل نُظُم الطوارئ

تمثل نُظُم الطوارئ والخطط القوية التي تعكس عملية التخطيط التعاوني نقطة الانطلاق للشروع في تنفيذ أنشطة الاستجابة. ومن المهم إدماج المستشفيات في النُّظُم الوطنية للرعاية الطارئة في إطار التدخلات الروتينية الرامية إلى تحقيق القدرة على الصمود. ولتعزيز تفعيل هذه النُّظُم، ينبغي أخذ الإجراءات الآتية بعين الاعتبار:

- دمج التأهب في برامج التدريب لتطوير قدرات الموظفين، ومنها قدرتهم على استخدام المعدات.

- عقد جلسات توجيهية لأصحاب المصلحة الرئيسيين، وتشمل دورهم في النظام (مثل السلطات المحلية، وإدارة الصحة المحلية، والمستشفيات الأخرى، وإدارة الإطفاء).
- إجراء تمارين محاكاة في المستشفيات لاختبار الترتيبات وتنقيحها على النحو المطلوب. وجلب مشاركين من مختلف أقسام المستشفى، وإجراء تدريبات بشكل متكرر وخلال أوقات الليل وعطلات نهاية الأسبوع، مما يُمكّن المستشفى بعدها من وضع تمارين وظيفية شاملة تتضمن استخدام تقنية المولاج «محاكاة الإصابات بشكلٍ واقعي». وتكتسي مشاركة المجتمع المحلي أهمية حاسمة في تحديد العناصر الناجحة أو التي تحتاج إلى تحسين.
- إجراء بحوث ميدانية لتحسين النُّظُم والإجراءات.

ويضمِّن إطار منظمة الصحة العالمية لنظام رعاية الطوارئ الوظائف الأساسية للرعاية الطارئة في موقع الإصابة أو المرض، وأثناء النقل، وصولًا إلى وحدة الطوارئ وتقديم الرعاية المبكرة للمرضى الداخليين. وترد هذه الإشارة في القسم 1-3-18 حول الأدوات والموارد.

المواد

12-3-1 إدارة الأرصدة والمخزون

عندما تتطلب المستشفيات الإتاحة الفورية للأدوية والإمدادات، فإنها تنظر في المخزونات الطبية للحصول على معلومات دقيقة عن مستويات المخزون الحالية والموقع المحدد لها. ويجب أن تكون نظم إدارة المخزون في المستشفيات قوية ومرنة، وهذا درس تعلمته المستشفيات خلال جائحة كوفيد-19. وكذلك يجب أن تكون عمليات إدارة المخزون قادرة على تتبع سير أصناف المخزون منذ التسليم وحتى الاستخدام النهائي، ويشمل هذا البيانات المتعلقة بالاستخدام. وستساعد التوصيات الآتية على ضمان إسهام نظم إدارة إمدادات المستشفيات ومخزوناتها في التأهب لحالات الطوارئ:

- تقييم مواطن الضعف في البنية الأساسية لسلسلة الإمداد الرئيسية (مثل مسارات النقل، والجسور، والموانئ البحرية، والمطارات) التي يمكن أن تعطل الإمدادات؛ وكذلك وضع خطط احترازية لسلسلة الإمداد للحد من الآثار المحتملة.
- الاحتفاظ بمخزون مركزي.
- الاحتفاظ بقائمة دقيقة بالأصناف، مع ضرورة الحفاظ على مستويات كافية من المخزون. وهذا من شأنه أن يتيح الشراء على أساس الطلب، وتحديد الاتجاهات، والمساعدة في التنبؤ بالاحتياجات في المستقبل.
- متابعة تواريخ انتهاء الصلاحية وعمليات الاسترجاع، مما يَحول دون حدوث هدر وخسائر مالية لا داعي لها.
- تحديد بدائل للأصناف المُدرَجة في قائمة الجرد أو تحديد بائعين جدد.
- توفير مخزون احتياطي لتجنب استنفاد المخزون الحالي.
- وضع إجراءات طارئة للمشتريات والرقابة والأمن والإبلاغ.

13-3-1 شراء الأدوية والإمدادات اللازمة في حالات الطوارئ وإدارتها

تتطلب إجراءات الشراء الفعالة في حالات الطوارئ مزيجًا من التخطيط المسبق والمرونة والسرعة والشفافية وإدارة المخاطر والتنسيق. وهذا سيضمن أن تمتلك المستشفيات المخزون اللازم من الأدوية والإمدادات اللازمة في حالات الطوارئ لتلبية الطلب المتزايد خلال فترات الزيادة المفاجئة للاحتياجات، وأن يتلقى المرضى الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.

وتمكِّن نُظُم الشراء الفعَّالة المستشفيات أيضًا من تعظيم الاستفادة من الموارد، وتجنُّب ازدواجية الجهود، مما قد يؤدي إلى تحقيق وفورات في التكاليف. وتكتسي إجراءات الشراء في حالات الطوارئ أهميةً حاسمة لضمان سرعة الحصول على السلع والخدمات اللازمة لمساعدة المتضررين من الأزمة. وفيما يلي الاعتبارات الرئيسية لتعزيز استعداد المستشفيات:

- في حالة حدوث طارئة صحية أو كارثة، ينبغي للمستشفيات أن تضع في الاعتبار وجود إمدادات وترتيبات مخصصة لديها لأن جهود الاستجابة سوف تستنفد المخزونات الحالية بسرعة. وستساعد عمليات التدقيق المنتظمة في تحديد ما إذا كانت مستويات المخزون دقيقة. ويمكن إدراج إمدادات الطوارئ ضمن الاستخدام اليومي لضمان عدم انتهاء صلاحية الأصناف المُخزَّنة.
- ينبغي، قبل حدوث حالة الطوارئ، أن تكون هناك معايير وعتبات محددة مسبقًا لشتى أساليب الشراء لضمان شفافية عملية الشراء واتساقها.
- ينبغي أن تكون إجراءات الشراء في حالات الطوارئ مرنة بما يكفي للتكيف مع الاحتياجات والظروف المتغيرة. ويشمل ذلك القدرة على تغيير عتبات وأساليب الشراء، والنظر في مصادر بديلة للسلع والخدمات.
- يجب على مكتب المشتريات أن يبرم مسبقًا عقودًا محتملة لتوريد الأصناف التي تُستخدم عادة في حالات الطوارئ المعلنة. وسيوفر هذا ترتيبات للبائعين لتسليم الأصناف والخدمات اللازمة بسرعة.
- وضع إجراءات الشراء في حالات الطوارئ مما يقلل وقت عملية الشراء لتوفير الوقت. ويشمل ذلك تخصيص ميزانيات متاحة بحيث يمكن استخدامها بسرعة لإتمام عمليات الشراء أثناء الطوارئ.
- إعداد قائمة بالمعدات والمستلزمات الطارئة الحرجة. وينبغي رصد حالتها في الظروف العادية، ووضع ترتيبات احترازية فيما يتعلق بمكان وكيفية الحصول على هذه الأصناف.
- يجب أن تتسم إجراءات الشراء في حالات الطوارئ بالشفافية، وأن تكون قابلة للمساءلة والتدقيق. ويشمل ذلك التوثيق الواضح لعملية الشراء، والاتصالات المفتوحة، والإبلاغ المنتظم عن أنشطة الشراء.
- ينبغي أن تشمل إجراءات الشراء في حالات الطوارئ استراتيجيات لإدارة المخاطر لضمان الحصول على السلع والخدمات بأمان وكفاءة. ويشمل ذلك تقييم المخاطر المرتبطة بعملية الشراء وتخفيف وطأتها، مثل الغش والفساد ومخاطر السلامة.
- من الضروري وجود تنسيق واتصال فعالين بين جميع الأطراف المشاركة في عملية الشراء. ويشمل ذلك التنسيق مع الوكالات الأخرى المعنية بالاستجابة للكوارث، والسلطات المحلية، والجماعات المجتمعية.

14-3-1 اتفاقات البائعين والخدمات

يتطلب إبرام اتفاقات البائعين والخدمات، في إطار التأهب، مزيجًا من تقييم الاحتياجات، واختيار البائعين، والتفاوض بشأن العقود، ورصد الأداء، وإدارة المخاطر، والمراجعة والتحديث بانتظام. والهدف من ذلك هو ضمان توافر السلع والخدمات الضرورية أثناء حالات الطوارئ، ومساءلة البائعين عن الوفاء بالمعايير المتفق عليها. وعند إبرام مثل هذه الاتفاقات، ينبغي النظر في العناصر الرئيسية الآتية:

- إجراء **تقييم للاحتياجات** لتحديد أنواع السلع والخدمات التي ستكون مطلوبة خلال حالات الطوارئ.
- **اختيار البائعين** القادرين على توفير السلع والخدمات اللازمة أثناء حالات الطوارئ، مع الأخذ في الاعتبار توافرهم وموثوقيتهم والفعالية من حيث التكلفة.
- وضع **اتفاقات مستوى الخدمات** التي تحدد نطاق العمل والمنجزات المستهدفة والجداول الزمنية ومعايير الجودة لكل بائع.
- **التفاوض على عقود** مع البائعين تتضمن شروطًا وأحكامًا، مثل التسعير وشروط السداد ومقاييس الأداء وآليات تسوية المنازعات.
- إنشاء نظام **لرصد أداء البائعين** لضمان وفائهم باتفاق مستوى الخدمات والالتزامات التعاقدية.
- وضع خطة **لإدارة المخاطر** تشمل خططًا احترازية لحالات تعطل سلسلة الإمداد، وإخفاق البائعين في الوفاء بالتزاماتهم، والأحداث الأخرى غير المتوقعة.
- **مراجعة وتحديث** اتفاقات البائعين والخدمات بانتظام استنادًا إلى الاحتياجات والظروف المتغيرة، بالإضافة إلى الملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة.

15-3-1 الآليات المالية في حالات الطوارئ

يضمن وضع آليات مالية مرنة ومستدامة قبل الاستجابة للكوارث توافر الأموال عند الحاجة إليها. ولا تتوقف الاستجابة الفعّالة لحالات الطوارئ على توافر التمويل فحسب، بل تعتمد أيضًا على كيفية تخصيص الأموال وإنفاقها. والهدف من ذلك هو ضمان توافر التمويل واستخدامه بكفاءة وفعالية. ومن شأن التوصيات الآتية أن تحسِّن من الجاهزية المالية للمستشفى:

- **رسم خرائط الموارد:** تحديد مصادر التمويل الخارجية المحتملة (وتشمل المنح الحكومية، والتبرعات الخاصة، والمعونة الدولية) والأموال المتاحة داخليًّا.
- **إعداد الميزانية:** إعداد ميزانية تحدد التكاليف المرتبطة بأنشطة الاستجابة للطوارئ.
- **استراتيجيات التمويل:** وضع استراتيجيات لتأمين التمويل، مثل طلبات المنح، ورعاية الشركات، وفعاليات جمع الأموال. ويجب إنشاء صندوق للطوارئ، ووضع إجراءات للتتبع السريع لكيفيات الإنفاق لتسريع وتيرة الصرف، مصحوبة بالإدارة السليمة للشؤون المالية والمساءلة.

- **الشَّرَاكات:** إقامة شَرَاكات مع المنظمات الأخرى، ومنها الوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية وكيانات القطاع الخاص، للاستفادة من الموارد والتمويل.
- **المرونة:** ضمان أن تكون الآليات المالية مرنة بما فيه الكفاية للاستجابة للاحتياجات والظروف المتغيرة، مثل حجم الكارثة ووخامتها وظهور تهديدات جديدة. ويجب وضع قواعد مرنة للشراء تسمح للمستشفيات بالتفاوض مباشرة مع الموردين. ويجب رفع القيود المفروضة على عملية العطاءات من حيث الوقت والعناية الواجبة، والحد الأدنى لعدد المرشحين، والدفعات المُقدمة.
- **الاستدامة:** وضع آليات مالية مستدامة يمكن استخدامها على المدى الطويل، وتشمل استراتيجيات للحفاظ على التمويل، واجتذاب مصادر دعم جديدة.
- **المساءلة:** وضع نظام وإجراءات لتتبع استخدام الأموال، وإعداد تقارير بهذا الشأن، ويشمل ذلك إجراء عمليات تدقيق الحسابات وتقييمات الأداء بانتظام. ويجب تحديد مستويات واضحة للتصريح بالإنفاق في حالات الطوارئ في إطار خطط استجابة المستشفيات.
- **التوقيت المناسب:** وضع عمليات وإجراءات لضمان الحصول على الأموال في الوقت المناسب أثناء الاستجابة للكوارث. وينبغي التشاور مع السلطات الوطنية والمحلية بشأن اللوائح والمتطلبات الخاصة برد التكاليف، والتأكد من إعداد الوثائق المطلوبة وفقًا للمبادئ التوجيهية.

الموظفون

16-3-1 تنمية كفاءات الموظفين

يتطلب تطوير كفاءات الموظفين في المستشفيات تطبيق بروتوكولات الاستجابة للطوارئ وخططها وأدوارها تطبيقًا منهجيًا وشاملًا. ويتمثل الهدف من ذلك في ضمان تمتُّع موظفي المستشفيات بالمعارف والمهارات اللازمة للاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ والتخفيف من آثارها على المرضى والمجتمع المحلي. ويُوصى بالنظر في الإجراءات الآتية لتعزيز تأهب الموظفين:

- **تقييم احتياجات التدريب:** إجراء تقييم لمستوى معارف موظفي المستشفيات ومهاراتهم وقدراتهم فيما يتعلق ببروتوكولات الاستجابة للطوارئ، وخططها، وأدوارها للوقوف على الثغرات والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.
- **تخصيص الأدوار والمسؤوليات في حالات الطوارئ.** عند إسناد المهام، يُستخدم اللقب الوظيفي بدلًا من اسم الموظف، لأن الوظيفة ستظل قائمة، ولكن اسم الشخص قد يتغير بسبب تناوب الموظفين أو تناقص عددهم.
- **إعداد أوراق عمل الوظائف.** عبارة عن إرشادات مرجعية سريعة بشأن مهام محددة في حالات الطوارئ، وتشمل: الغرض، والمشرف الذي تُرفع التقارير إليه، وتقسيم زمن المهمة (فورية: 0-ساعتين؛ ومتوسطة: ساعتان-12 ساعة؛ ومهمة استجابة ممتدة: أكثر من 12 ساعة)، والتسريح. ويمكن استخدام أوراق عمل الوظائف في جلسات استخلاص المعلومات والاستعراضات اللاحقة للإجراءات للتعلم من التجارب السابقة، وإدخال التحسينات عند الحاجة.

- **إعداد البرامج التدريبية:** إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مُصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات موظفي المستشفيات وأدوارهم، مثل خطط وإجراءات الاستجابة للطوارئ، ونُظُم قيادة الأحداث، والفرز والتدبير العلاجي للمرضى، وبروتوكولات التواصل، واستخدام معدات الوقاية الشخصية. وينبغي تقديم تدريب منتظم لتجديد المعلومات لضمان احتفاظ موظفي المستشفيات بالكفاءات والمعرفة ببروتوكولات الاستجابة للطوارئ وأدوارها.
- **إعداد برنامج سنوي للتمارين**، يستطيع الموظفون من خلاله مراجعة المهام المتوقعة في حالات الطوارئ وممارستها وتطبيق بروتوكولات الاستجابة للطوارئ وأدوارها في بيئة واقعية. ويمكن أن تتراوح التمارين بين تمارين بسيطة قائمة على المناقشة (تمارين المحاكاة النظرية) لمختلف الوحدات أو الوظائف إلى تمارين شاملة أو وظيفية في نهاية العام، على أن تجمع بين جميع وظائف الاستجابة. وكذلك ينبغي تشجيع المستشفيات على المشاركة في التمارين المجتمعية مع السلطات المحلية، ومنظمات الاستجابة، والمستشفيات الأخرى في شبكة المنطقة لممارسة تطبيق الخطط والترتيبات الخاصة بالمنطقة المحلية واختبارها.
- **دمج كفاءات الاستجابة للطوارئ في تقييمات الأداء:** ينبغي أن تعكس توصيفات الوظائف الكفاءات المطلوبة للاستجابة للطوارئ، وأن تكون جزءًا من تقييمات أداء موظفي المستشفيات، لضمان المساءلة عن الأدوار والمسؤوليات في حالات الطوارئ.
- **تعزيز ثقافة التأهب** على مستوى المستشفى بأسره، من خلال التواصل المستمر، والمشاركة مع الموظفين والمرضى والشركاء المجتمعيين. ويمكن أن يشمل هذا أنشطة مثل حملات التوعية، والتوعية المجتمعية، والشراكات مع الوكالات المحلية لإدارة الطوارئ.

17-3-1 تعبئة الموارد البشرية لأغراض الاستجابة

يتطلب إنشاء نظام فعال لتعبئة الموارد البشرية وإخطارها قبل وأثناء تفعيل خطة الاستجابة للكوارث التخطيط والتدريب والتوظيف والشراكات والموارد والتقييم. وعلى المستشفيات أن تتأكد من أن لديها الموارد البشرية اللازمة للاستجابة للكوارث، وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى من خلال النظر في التوصيات الآتية:

- **وضع خطة لإدارة الموارد البشرية** تحدد أدوار الموظفين ومسؤولياتهم أثناء الكوارث، وتحدد المهارات والكفاءات اللازمة، وتضع بروتوكولات لحشد الموظفين وإدارتهم.
- **إعداد مصفوفة توظيف** تحدد عدد وفئة الموظفين اللازمين لمختلف أنواع الطوارئ ومستوياتها. وينبغي أن تأخذ مصفوفة التوظيف في الاعتبار عدة عوامل مثل العدد المتوقع للمرضى، وشدة الإصابات، ومدى توفر الموارد.
- **إنشاء نظام استدعاء** لإخطار الموظفين وحشدهم بسرعة خلال حالات الطوارئ. وينبغي أن يتضمن نظام الاستدعاء بروتوكولات للاتصال بالموظفين (بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية، يمكن للمستشفيات استخدام الرسائل النصية القصيرة، أو أجهزة المناداة (البيجر)، أو عمل إعلانات باستخدام شبكة تخاطب عامة للمستشفيات)، والتحقق من توافرهم، ونشرهم إلى موقع مناسب.

- **الاحتفاظ بدليل مُحدث لبيانات الاتصال بالموظفين**، من خلال التكليف بمسؤولية تحديث بيانات الاتصال الخاصة بأعضاء فريق إدارة الأحداث بالمستشفى، وكذلك مسؤولي التنسيق في المنظمات والوكالات المحلية: مركز عمليات الطوارئ، والصحة العامة، وإدارة الإطفاء، والشرطة، والدفاع المدني، وغيرها.
- **وضع ترتيبات وسائل النقل** لاستدعاء الموظفين خارج أوقات العمل.
- **تقديم التسهيلات للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة**، والذين لا يستطيعون العودة إلى المنزل، وتشمل الطعام والمرطبات ومرافق الراحة. وقد تنظر المستشفيات في أفضل سبل دعم أسر الموظفين الذين تم استدعاؤهم، والذين أُجبروا على الإجلاء. وينبغي أن تشمل برامج التدريب في المستشفيات تأهب الأسر، وتعزيز قدرة الموظفين على الصمود (قدرتهم على استئناف العمل عند الحاجة).
- **النظر في تقديم حوافز للموظفين** الذين يُستدعون للعمل أثناء الطوارئ، والذين يعملون في نوبات عمل ممتدة. ويمكن أن يكون ذلك في شكل بَدَلات، أو أجر عمل إضافي، أو تأمين، أو إجازة مدفوعة الأجر بعد انقضاء الأزمة، بما في ذلك إصدار شهادات تكريم/ شهادات للخدمة المثالية يمكن إدراجها في سجلات أداء الموظفين للترقية في المستقبل وتعديلات المرتبات.
- **إقامة شَرَاكات** مع المرافق والمؤسسات الصحية الأخرى ووكالات إدارة الطوارئ لتبادل الموارد والخبرات أثناء الكوارث. ويمكن أن يشمل ذلك اتفاقات المساعدة المتبادلة، والعقود المرتبة سلفًا، وبرامج التدريب المشترك.
- **ضمان توافر الموارد الكافية** لدعم حشد الموظفين أثناء الكوارث. ويمكن أن يشمل ذلك الإمدادات والمعدات ووسائل النقل.
- إجراء **تقييم للنظام وتحسينه** بانتظام لضمان فعاليته وكفاءته. ويشمل هذا مراجعة مصفوفات التوظيف، وإجراء استعراضات لاحقة للإجراءات، وتحديث البرامج والبروتوكولات التدريبية.

18-3-1 أدوات وموارد التأهب لحالات الطوارئ

- الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ. أداة التقييم الذاتي لاستعداد المستشفيات لمواجهة الكوارث. [إيرفينغ، تكساس]: الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ؛ [التاريخ غير معروف]. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3Hu3xBM.
- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. مؤشر الاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية والكوارث. واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ 2019. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/4b8yY27.
- منظمة الصحة العالمية. قائمة مرجعية بشأن التأهب السريع للمستشفيات: إرشادات مؤقتة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/4b4tBRw.
- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. مجموعة الأدوات الاستراتيجية لتقييم المخاطر في المرافق الصحية (STAR-H). واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ 2023. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/4bjK0Su.

- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالإعاقة في إدارة مخاطر الكوارث في المستشفيات (INGRID-H). واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ 2018. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3u7P8s3.
- منظمة الصحة العالمية. نُظُم التدبير العلاجي للإصابات الجماعية: استراتيجيات ومبادئ توجيهية لبناء قدرات القطاع الصحي. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2007. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3SrQ5or.
- منظمة الصحة العالمية. الدليل المرجعي لتقييم توفر الخدمات وجاهزيتها، الإصدار 2-2. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2015. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3UhIWZj.
- أكاديمية منظمة الصحة العالمية. الاستعداد للإصابات الجماعية والاستجابة لها في وحدات الطوارئ. [جنيف]: منظمة الصحة العالمية؛ 2022. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3OgKI98.
- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، منظمة الصحة العالمية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. التعامل مع الجثث بعد الكوارث: دليل ميداني للمستجيبين الأوائل. الطبعة الثانية (المُنقَّحة). واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ 2016. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3UCZgUn.
- منظمة الصحة العالمية. إرشادات بشأن إعداد خطة عمل للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في إطار الاستعداد لكوفيد-19 والاستجابة له. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3UaBw9U.
- مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لغرب المحيط الهادئ؛ 2012. حزمة إرشادات لمرافق الرعاية الصحية بشأن التواصل بشأن مخاطر كوفيد-19. مانيلا: مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لغرب المحيط الهادئ؛ 2020. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3vP6Cdi.
- منظمة الصحة العالمية. أداة منظمة الصحة العالمية للتنبؤ بالإمدادات الأساسية لمواجهة كوفيد-19، الإصدار الرابع. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2022. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3Ss6QzI.
- الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ. مبادئ توجيهية للفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ. جنيف: الفريق الاستشاري الدولي للبحث والإنقاذ؛ 2020. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/4979L6i.
- منظمة الصحة العالمية. تصنيف الفِرَق الطبية للطوارئ ومعاييرها الدنيا. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3u8cU7d.
- منظمة الصحة العالمية. موارد عمليات المحاكاة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2024 [تاريخ الاستشهاد: 19 آذار/ مارس 2024]. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3ws9pcw.

- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. Herramienta de Evaluación de la Preparación Hospitalaria Frente a la Violencia [Hospital Preparedness Assessment Tool for Violence] [بالإسبانية فقط]. واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ 2024 [تاريخ الاستشهاد: 19 آذار/ مارس 2024]. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3TgjRwK.
- نظام السيطرة على الحوادث للمستشفيات (متاح حاليًا باللغة الإسبانية فقط؛ وسيُتاح قريبًا باللغة الإنجليزية). متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3P39EkW.
- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. Caja de herramientas: prepare ación de los países para emergencias de salud y desastres [مجموعة أدوات: تأهب البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية والكوارث] [بالإسبانية]. واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ [التاريخ غير معروف] [تاريخ الاستشهاد: 19 آذار/ مارس 2024]. (متاح حاليًا باللغة الإسبانية فقط؛ وسيُتاح قريبًا باللغة الإنجليزية). متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/47GNw6g.
- منظمة الصحة العالمية. إطار نظام رعاية الطوارئ. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018. متاح عبر الرابط: https://bit.ly/3V14jhF.
- منظمة الصحة العالمية. أدوات المنظمة لتعزيز نُظُم الرعاية الطارئة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ [التاريخ غير معروف]. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3P2OB1H.



النظام الاحتياطي لمكافحة الحرائق. المستشفى العام الإقليمي 2، المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، الماركيز، كويريتارو، المكسيك. مركز (MEX-35) المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية القادرة على الصمود، 2021.

4-1 دور المتطوعين

جذبت الكوارث الماضية العديد من المتطوعين الراغبين في تقديم المساعدة، في ظاهرة تُعرف باسم «العمل التطوعي المتقارب»، وفيه يصل العاملون في مجال الرعاية الصحية غير المتوقعين و/ أو غير المدعوين لتقديم المساعدة. وفي حين يمكن أن يشكل المتطوعون مصدرًا جيدًا لقوة عاملة إضافية في حالات الطوارئ، إلا أن المتطوعين الذين لديهم نوايا حسنة، ويفتقرون إلى الخبرة، وغير الملمين بنظام الاستجابة المحلي في المستشفيات والمجتمع المحلي المتضرر، يمكن أن يزيدوا من حالة الارتباك أو حتى يعرقلوا العمليات. ويجب أن تنظر المستشفيات بعناية في كيفية الاستفادة من المتطوعين وإدارة خدماتهم على أفضل وجه. وينبغي أخذ النقاط الآتية بعين الاعتبار قبل إشراك المتطوعين في المستشفى.

- يمكن أن تعتمد المستشفيات مسبقًا مجموعة متعددة التخصصات من المتطوعين، وتحديد متى وكيف يُستخدمون، والمهام المحددة المتوقع منهم أداؤها. وستتمكن المستشفيات أيضًا من إشراك هذه المجموعة من المتطوعين في أنشطة التأهب في مرحلة ما قبل الكوارث، مثل التدريب والتمارين.
- تنفيذ خطط لمراجعة أوراق الاعتماد المهنية للممارسين الطبيين والتحقق منها وإعادة التحقق منها بصفة دورية. وتكفل عملية اعتماد المتطوعين الطبيين اتساق المؤهلات مع المهام المسندة إليهم، وارتباطها بالممارسات الطبية في البلد المتضرر. وتُعد الجامعات والكليات الطبية مصدرًا جيدًا للمتطوعين، خاصة عندما يكون المستشفى تابعًا لإحداها.
- معرفة كيفية تحديد المتطوعين المناسبين وطلبهم. ويجب كذلك بيان الترتيب المفضل اتباعه في قبول المتطوعين: (على سبيل المثال، الموظفون من المرافق التابعة، تليها المرافق الشريكة، ثم المتطوعون الطبيون الوطنيون، وأخيرًا المهنيون الصحيون غير المخطط للاستعانة بهم أو الذين يُستعان بهم وفقًا لما تمليه الظروف).
- وضع ترتيبات لكيفية الإشراف على المتطوعين وتقييمهم في إطار خطة المؤسسة للاستجابة للطوارئ.

5-1 مبادرة الفرق الطبية في حالات الطوارئ

استنادًا إلى تجارب المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ، أعدَّت المنظمة مبادرة الفرق الطبية في حالات الطوارئ لتحسين توقيت وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها الفرق الطبية الوطنية والدولية في حالات الطوارئ، وتعزيز قدرة النظم الصحية الوطنية على تفعيل قدرات الاستجابة السريعة وتنسيقها.

وفي إطار هذه المبادرة، أعدت المنظمة إرشادات بشأن التصنيف الموحد لفرق الاستجابة واعتمادها. وتتألف الفرق المعتمدة من المهنيين الصحيين - الأطباء، وطواقم التمريض، والمسعفين، والعاملين في مجال الدعم، وأخصائيي اللوجستيات - الذين يعالجون أو يدعمون المرضى المتضررين من الطوارئ أو الكوارث. وكما هو مُبيَّن في منشور منظمة الصحة العالمية، تنقسم الفرق الطبية في حالات الطوارئ إلى أربع فئات على أساس تنقلها ومستوى الرعاية التي تقدمها. ويوضح الجدول 2 التوازن بين التنقل ومستوى الرعاية بما يميز كلَّ نوع من أنواع الفرق الطبية في حالات الطوارئ.

الجدول 2. تصنيف منظمة الصحة العالمية للفرق الطبية في حالات الطوارئ

تصنيف منظمة الصحة العالمية للفرق الطبية في حالات الطوارئ			
النوع	الوصف	القدرة	الحد الأدنى لمدة النشر
1 فرق متنقلة	فرق متنقلة معنية بالمرضى الخارجيين للوصول إلى المجتمعات المحلية الأصغر في المناطق النائية	أكثر من 50 مريضًا خارجيًّا في اليوم	أسبوعان
1 فرق ثابتة	مرافق للمرضى الخارجيين سواء كانت في مخيمات مشيدة أو لا	أكثر من 100 مريض خارجي في اليوم	أسبوعان
2	مرافق للمرضى الداخليين مع خدمة الجراحة	أكثر من 100 مريض خارجي، و20 مريضًا داخليًّا 7 عمليات كبرى، أو 15 عملية بسيطة في اليوم	3 أسابيع
3	رعاية حالات الإحالة، ومرافق المرضى الداخليين، والجراحة، والرعاية الفائقة	أكثر من 100 مريض خارجي، و40 مريضًا داخليًّا، ويشمل ذلك 4-6 أسرَّة للعناية المركزة 15 عملية كبرى، و30 عملية بسيطة في اليوم	من 4 إلى 6 أسابيع
فرق الرعاية المتخصصة	الفِرَق التي يمكن أن تنضم إلى المرافق المحلية أو الفرق الطبية في حالات الطوارئ لتقديم رعاية متخصصة تكميلية	متغيرة	متغير

تُنمَّى القدرات وفقًا للإجراءات التشغيلية الموحَّدة لتوجيه أنشطة الاستجابة الخاصة بالفرق الطبية في حالات الطوارئ. وبمجرد اجتياز فريق لعملية التصنيف، يمكنه الانضمام إلى سجل منظمة الصحة العالمية للفرق القابلة للنشر دوليًّا. وبالمثل، ستكون الفرق المحلية من البلدان المضيفة قادرة على الاندماج بسلاسة في الفرق الطبية الأجنبية في حالات الطوارئ والعمل معًا بشكل تعاوني. ويضمن ذلك تقديم رعاية طارئة موحّدة وجيدة، ونشر استجابة طبية جيدة التنسيق، مما يحسّن الحصائل الصحية للسكان المتضررين.

2 أثناء: مرحلة الاستجابة

حتى المستشفيات الأفضل استعدادًا ستواجه بعض العواقب الحتمية الناجمة عن طارئة صحية أو كارثة. وتشمل التحديات المعقدة زيادة مفاجئة في حجم الطلب على الخدمات الطبية، ومحدودية الموارد، وتعطل الاتصالات وخطوط الإمداد. وبالمثل، يمكن أن تطغى الزيادة غير المتوقعة في حالات الإدخال إلى المستشفى حتى وإن كانت طفيفة على قدرة المستشفى. ويمكن أن يؤدي تناقص عدد الموظفين ومحدودية توافر المعدات والإمدادات الحيوية إلى زيادة تقليص الحصول على الرعاية الصحية.

وعلى الرغم من بدء الإدارة التعويضية للمخاطر خلال مرحلة التأهب، فإنها تستمر في مرحلة التعافي، وذلك بهدف تعزيز قدرة المستشفى على الصمود أمام المخاطر المتبقية التي لا يمكن الحد منها بفعالية. وخلال مرحلة الاستجابة، من المُرجَّح أن تعتمد المستشفيات على قدرات الصمود الأربع المذكورة سابقًا: استيعاب المخاطر المتبقية التي لا يمكن الحد منها بفعالية؛ والتكيف مع الزيادة الكبيرة المفاجئة في الطلب على خدمات صحية عالية الجودة ومستمرة؛ والتحول، والتعلم من التعافي بينما تستأنف أداء الوظائف العادية.

وفي خضم هذه التحديات والمطالب، يجب أن تكون المستشفيات قادرة على بدء استجابة فعالة في الوقت المناسب.

الإطار 10. دليل سريع لبدء استجابة المستشفى للطوارئ

دليل سريع لبدء استجابة المستشفى للطوارئ

1. تفعيل خطة المستشفى للاستجابة للطوارئ، وإنشاء نظام إدارة الأحداث في المستشفى.
2. فتح مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى.
3. جمع المعلومات الحرجة المتعلقة بالحدث وحالة نُظُم المستشفيات وقدرتها التشغيلية والتحقق منها والتأكد من صحتها سريعًا.
4. وضع أهداف خاصة بالحدث لتقديم التوجيه وتحديد الأولويات. ووضع استراتيجيات وإجراءات لتحقيق أهداف الخطة.
5. توزيع تكليف الوظائف في فريق إدارة الأحداث بالمستشفى، بناءً على مؤهلات الموظفين وتوافرهم.
6. تقييم الاحتياجات وتخصيص الموارد، استنادًا إلى تقييمات الموقف.
7. بدء التنبيهات والإخطارات المجتمعية المناسبة.
8. إقامة روابط للاتصالات، والاستجابة مع شركاء الاستجابة المحليين المناسبين.
9. عقد جلسات إعلامية لعرض خطة عمل الأحداث وآلية تنفيذها والتقدم المحرز بشأنها.
10. إعادة تقييم فعالية استراتيجيات وتكتيكات خطة عمل الأحداث. وعند توافر معلومات جديدة، تُعدّل الخطة وتُخصص الموارد وتُرتب الأولويات.

1-2 تقييم الأضرار وإعادة تخصيص الحيز المكاني في المستشفى

يمكن أن يكون لبعض الأخطار، مثل الزلازل أو الفيضانات أو الأعاصير أو الحرائق أو الانفجارات، أثرٌ مباشرٌ على السلامة الهيكلية للمبنى وعلى العناصر غير الهيكلية. وعندما يكون الأمر كذلك، يجب أن تكون المستشفيات مستعدة لإجراء تقييم سريع للأضرار التي تلحق بمرافقها. وتحدد هذه العملية طبيعة وحجم الضرر، وتوفر معلومات بالغة الأهمية لتحديد أولويات الاستجابة. ومن المهم ملاحظة أن الإجراءات الواردة في هذا القسم ترتبط بمكون التأهب (انظر القسم 1-1)، الذي وُضِعت في إطاره بروتوكولات الأداء الخاصة بخطط استجابة المستشفيات.

وفور تفعيل نظام إدارة الأحداث وخطة الاستجابة، ينبغي النظر في الخطوات الفورية الآتية:

- ينبغي لرؤساء الوحدات أن يقوموا على وجه السرعة بتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية الحيوية في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتهم وأدائها لوظائفها، وذلك باستخدام نموذج موحد أو قائمة مرجعية.
- ينبغي أن تتضمن التقييمات معلومات عن حالة النظم الآتية: نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والطاقة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وإمدادات المياه، والغاز الطبي، والصرف الصحي، والطرق (الداخلية والمحيطة مباشرة بالمبنى)، مع إدراج الاحتياجات من المساعدة الخارجية.
- ينبغي إرسال تقارير التقييم إلى القيادة المعينة في فريق إدارة الأحداث بالمستشفى، من خلال قنوات متفق عليها. وكمثال على ذلك، في كثير من هياكل فرق إدارة الأحداث بالمستشفيات، يُبلَّغ مدير قسم البِـنْية الأساسية الذي يقوده رئيس وحدة الإدارة الهندسية بهذه المعلومات تحت إشراف رئيس قسم العمليات.
- يناقش فريق إدارة الأحداث بالمستشفى تقارير التقييم لتحديد أولويات خطة عمل الأحداث.

ويجب أن تخطط المستشفيات أيضًا لتعظيم الاستفادة من الحيز المكاني المتاح لديها لاستيعاب الطلب المتزايد على رعاية المرضى. وينبغي أن توضح خطط الاستجابة كيفية تحويل المناطق القائمة، مثل الممرات، والبهو، وصالة الألعاب الرياضية، وقاعة الاستماع، وقاعات الاجتماعات، حسب الحاجة لتلبية الطلب.

2-2 رصد معلومات الإنذار المبكر

يُعدُّ الوصول إلى نُظُم الإنذار المبكر والمعلومات التي توفرها أمرًا بالغ الأهمية لاستجابة المستشفيات للطوارئ والكوارث. وتشمل مصادر المعلومات المتعلقة بالإنذار المبكر ما يأتي:

- نظم ترصُّد الأمراض، إما داخل المستشفى أو من خلال وزارة الصحة.
- قسم الأرصاد الجوية، للعواصف والفيضانات والجفاف.
- الوكالة الوطنية المعنية بإدارة الكوارث.
- السلطات المحلية ومراكز عمليات الطوارئ.
- وسائل الإعلام المحلية.

ويمكن إخطار المستشفيات بحدوث طارئة أو كارثة من خلال نظام إرسال مركزي، مثل إنفاذ القانون، أو الخدمات الطبية الطارئة، أو إدارة الصحة المحلية، أو السلطة المحلية لإدارة الطوارئ. وهناك ثلاثة أنواع من الإخطارات:

- إخطار استشاري، ويشير إلى عدم الحاجة إلى استجابة النظام، ولكن لا تزال إمكانية الاستجابة قائمة.
- إخطار تنبيهي، ويشير إلى أن الحاجة إلى استجابة محتملة أو وشيكة، مما يتطلب رفع مستوى الاستعداد للاستجابة.
- إخطار بالتفعيل، ويشير إلى ضرورة الاستجابة.

وفي معظم الحالات، تتلقى المستشفيات إنذارًا محدودًا أو لا تتلقى إنذارًا مسبقًا على الإطلاق بوقوع حدث ما، ولا سيما في حالة الكوارث ذات الأثر المفاجئ مثل الزلازل أو الفيضانات المفاجئة أو الانهيارات الأرضية أو الانفجارات. ولكن عندما يقع الضرر، يجب أن تكون المستشفيات مستعدة لتعبئة الاستجابة بسرعة، ومواجهة مختلف المشاكل مثل الحرائق والإصابات والإجلاء والأضرار التي تلحق بالهيكل والمعدات، وما إلى ذلك.

3-2 تفعيل خطة الاستجابة الشاملة لكل الأخطار

يبدأ تفعيل خطة استجابة المستشفى بمعلومات الإنذار المبكر (السيناريوهات التي من المرجح أن تؤدي إلى تعطل العمليات العادية في المستشفى) والمسببات المحددة مسبقًا (نقاط اتخاذ القرار بناءً على التغييرات في توافر الموارد، مما يتطلب إدخال تعديلات على تقديم خدمات الرعاية الصحية على امتداد سلسلة الرعاية) (22). ويتعين النظر في التوصيات الآتية لتفعيل استجابة المستشفيات للطوارئ وحشدها في الوقت المناسب:

- تحديد عوامل تحفيز الاستجابة بوضوح، مما سيساعد على الإدراك المبكر للموارد اللازمة للاستجابة وحشدها بسرعة (مثل عدد الإصابات المحتملة، وحجم حالة الطوارئ، والمواد الخطرة، والنشاط الإرهابي).
- وضع مستويات متدرجة لتفعيل الاستجابة. وينبغي أن يكون لكل مستوى بارامترات محددة بوضوح (مثل الأثر على المستشفى، وخدمات المستشفى اللازمة، والمتطلبات اللوجستية).
- ضرورة الاستعداد والقدرة على حشد الاستجابة على مدار الساعة، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات.

- تحديد المسؤول عن خطة الاستجابة والمخوَّل بتفعيلها، بمسمى وظيفته (على سبيل المثال، كبير المسؤولين الطبيين المناوبين، أو مدير المستشفى، أو رئيس وحدة الطوارئ، أو غيرهم).
- تفعيل مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى.

يعرض الجدول 3 مثالًا على مصفوفة تفعيل استجابة المستشفيات. وعند تكييف هيكل مشابه، من المهم أن يستند الهيكل إلى القدرة الفردية لكل مستشفى.

الجدول 3. مصفوفة تفعيل استجابة المستشفى

مستوى التفعيل	التعريف/ البارامترات	سلطة التفعيل	الإخطار
1 التنبيه/ الإخطار	معلومات واردة تشير إلى وضع أو حدث ما سيكون له أثر فعلي أو محتمل غير معتاد على عمليات مرفق المستشفى.	**المسؤول الإداري الموجود على رأس العمل (أثناء ساعات العمل) أو المشرف على التمريض (في جميع الأوقات الأخرى)**	• مسؤول إداري تحت الطلب • الممرضة المسؤولة عن وحدة الطوارئ، قائد الحدث • مشرف الخدمات البيئية أو الشؤون الهندسية • مركز عمليات الطوارئ للنظم الصحية أو الشبكة الصحية • مسؤول السلامة، مشرف الأمن • وحدة الاتصالات السلكية واللاسلكية • الحكومة المحلية
2 أثر طفيف	موقف أو حدث فعلي ذو أثر طفيف على عمليات المرفق	**قائد الحدث**	• مسؤول إداري تحت الطلب • الممرضة المسؤولة عن وحدة الطوارئ • مشرف بيئي أو هندسي • مركز عمليات الطوارئ للنظام الصحي أو الشبكة الصحية • مسؤول السلامة/ الأمن • الاتصالات السلكية واللاسلكية • مديرو الأقسام الأخرى، حسبما تقتضي الظروف • الحكومة المحلية/ السلامة العامة/ الصحة العامة/ مركز عمليات الطوارئ
	وحدة الطوارئ/ العوامل السريرية • 10 مرضى فعليين، أو 3 مرضى مصابين برضوح شديدة • وقت الانتظار يتجاوز 4 ساعات في وحدة الطوارئ • زيادة التعداد الطبيعي لمرضى وحدة الطوارئ بأكثر من 50% • عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى بنسبة تتجاوز عدد الأسِرَّة المُرخَّص بها يتراوح من مريض واحد إلى 10 مرضى		
	العوامل اللوجستية • حالات التعطيل محدودة و/ أو يمكن احتواؤها و/ أو لها أثر طفيف على العمليات • 15% من الموظفين غير موجودين لأداء عملهم • نقص الأصناف غير الحرجة، أو الإمدادات المتبقية من الأصناف الحرجة تكفي لمدة 48 ساعة فقط • هناك حاجة إلى الإجلاء الأفقي للمرضى/ الزوار/ الموظفين من منطقة ما في المبنى		

مستوى التفعيل	التعريف/ البارامترات	سلطة التفعيل	الإخطار
3 أثر متوسط	موقف أو حدث فعلي ذو أثر متوسط أو غير معتاد على عمليات المرفق	**قائد الحدث**	• المسؤول الإداري، الممرضة المسؤولة عن وحدة الطوارئ، منسق إدارة الطوارئ • مشرفو البيئة والشؤون الهندسية • مركز عمليات الطوارئ للنظام الصحي أو الشبكة الصحية • مكتب التمريض • مسؤول السلامة ومشرف الأمن • الاتصالات السلكية واللاسلكية • مديرو الأقسام الأخرى، حسبما تقتضي الظروف • الحكومة المحلية/ السلامة العامة/ الصحة العامة/ مركز عمليات الطوارئ
	وحدة الطوارئ/ العوامل السريرية • 20 مرضى فعليين، أو 5 مرضى مصابين برضوح شديدة • وقت الانتظار يتجاوز 8 ساعات في وحدة الطوارئ • زيادة التعداد الطبيعي لمرضى وحدة الطوارئ بأكثر من 100%، لأكثر من 8 ساعات • عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى بنسبة تتجاوز عدد الأسِرَّة المُرخَّص بها يتراوح بين 11 مريضًا إلى 30 مريضًا (في تعداد المرضى)		
	العوامل اللوجستية • اضطرابات تؤثر على منطقة رئيسية أو نظام رئيسي بالغ الأهمية لتنفيذ المهام أو تؤثر على العمليات العامة • 25% من الموظفين غير موجودين لأداء عملهم • نقص الأصناف الحرجة، أو الإمدادات المتبقية من الأصناف الحرجة تكفي لمدة 24 ساعة فقط • هناك حاجة إلى الإجلاء الرأسي للمرضى/ الزوار/ الموظفين من طابق واحد في المبنى • استمرار الحدث لأكثر من 8 ساعات		
4 أثر كبير	موقف أو حدث فعلي ذو أثر كبير أو غير معتاد على عمليات المرفق	**قائد الحدث، بالتشاور مع المدير التنفيذي للمستشفى**	• المسؤول الإداري، الممرضة المسؤولة عن وحدة الطوارئ، منسق إدارة الطوارئ • مشرفو البيئة والشؤون الهندسية • مركز عمليات الطوارئ للنظام الصحي أو الشبكة الصحية • مكتب التمريض • مسؤول السلامة ومشرف الأمن • الاتصالات السلكية واللاسلكية • مديرو الأقسام الأخرى، حسبما تقتضي الظروف • الحكومة المحلية/ السلامة العامة/ الصحة العامة/ مركز عمليات الطوارئ
	وحدة الطوارئ/ العوامل السريرية • 50 مريضًا فعليًا • وقت الانتظار يتجاوز 12 ساعة في وحدة الطوارئ • زيادة التعداد الطبيعي لمرضى وحدة الطوارئ بأكثر من 200% • عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى بنسبة تتجاوز عدد الأسِرَّة المُرخَّص بها يتراوح بين 31 مريضًا إلى 50 مريضًا (في تعداد المرضى)		
	العوامل اللوجستية • تعطل المبنى/ المعدات أو المرفق مما يؤثر على مناطق أو نظم متعددة • 40% من الموظفين غير موجودين لأداء عملهم • نقص حاد في المواد الأساسية • إخلاء مبنى رعاية المرضى بالكامل • استمرار الحدث لأكثر من 24 ساعة		

4-2 الوقاية من العدوى ومكافحتها

تُستخدم نُظُم الترصُّد بالمستشفيات للكشف عن فاشيات الأمراض المُعدية. ويمكن أن يدفع رصد اتجاهات المرض والتغيرات التي تطرأ على الأنماط مديري المستشفيات، وفريق الوقاية من العدوى ومكافحتها، ولجنة إدارة الكوارث في المستشفيات إلى استقصاء الحالات وإصدار الإخطارات، وفقًا للمبادئ التوجيهية للوائح الصحية الدولية بشأن التبليغ.

وتؤدي ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها دورًا رئيسيًّا في الحد من فاشيات الأمراض المُعدية، لا سيما في مرافق الرعاية الصحية. ويتعين على كل برنامج من برامج المستشفى أن يعين مسؤول تنسيق لتضمين الاحتياطات القياسية للوقاية من العدوى ومكافحتها، باستخدام المبادئ التوجيهية للوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات على النحو الآتي:

- نظافة اليدين.
- حماية القوى العاملة الصحية (على سبيل المثال، على الأقل توفير العلاج الوقائي بعد التعرض للإصابة، والتطعيمات، واستخدام معدات الحماية الشخصية).
- استعمال الأدوات الحادة، والتخلص منها بطريقة مأمونة.
- إزالة التلوث من الأجهزة والمعدات الطبية.
- فرز المرضى المصابين بأمراض معدية.
- إعادة معالجة المعدات والأدوات الطبية القابلة لإعادة الاستخدام.
- التنظيف البيئي الروتيني.
- نظافة الجهاز التنفسي وآداب السعال.
- التقنيات المانعة للتلوث عن طريق عدم اللمس.
- الإدارة الفعالة للنفايات.
- التعامل المناسب مع البياضات وأغطية الفراش.

5-2 التقييم السريع للاحتياجات

في الفترة التي تلي وقوع الأثر مباشرة، يُجري قائد الحدث تقييمًا سريعًا للمناطق المتضررة في المستشفى لتحديد احتياجات الاستجابة. ويقدم هذا التقييم الشامل (بدلًا من تقييم كل مكون من مكونات المستشفى على حدة) استعراضًا عامًّا للأثر الواقع على بيئة عمل المستشفى ككل. وهو يحدد أولويات إجراءات الاستجابة ومواردها، ويركز على ما يلزم تنفيذه لإنقاذ الأرواح، والوقاية من الوفيات الناجمة عن الأثر. وتعتمد الاحتياجات المطلوبة من حيث الإمدادات والمعدات والأدوية على نوع حالة الطوارئ، وقدرة المستشفى على الاستجابة.

ويمكن الاسترشاد بالأسئلة الآتية في إجراء تقييم سريع للاحتياجات.

- ما الحالة الطارئة؟ ما الخطر القائم؟
- هل يوجد خطر على السلامة/ الأمن (مثل المواد الخطرة والعنف)؟
- هل الوضع مستقر أم يمكن أن يتحول ليصبح أكثر خطورة؟
- ما الأثر الواقع على مرفق المستشفى (مثل الضرر والإصابات والتعطُّل)؟
- ما عدد المرضى المتوقع وصولهم؟ وهذه مجرد تقييمات مبنية على خطر الإصابات ونمطها. فعلى سبيل المثال، يتسبب حدوث زلزال في ارتفاع عدد مرضى الرضوح، ولكن قد يتأخر وصول المرضى بسبب انسداد الطرق. ومع ذلك، يمكن نقل الموجة الأولى من المرضى (الجرحى السائرين أو المصابين بإصابات طفيفة) بواسطة المارة دون الحصول على الرعاية الطبية.
- ما الموارد اللازمة لإدارة حالة الطوارئ؟ هل هي متاحة أم هناك حاجة إلى دعم خارجي؟

ويجب على المستشفيات أيضًا أن تتخذ الترتيبات اللازمة من أجل:

- إدارة تدفق أفراد الأسر عن طريق إنشاء مركز/ حيز مكاني للتنسيق الأسري للتعامل مع مخاوف الأسر، مع الحفاظ على إخضاع الدخول إلى مناطق المستشفيات الحيوية للرقابة.
- ترتيب تنظيم زيارات كبار الشخصيات حتى لا تُعطِّل الاستجابة للطوارئ.

6-2 نظام إدارة الأحداث بالمستشفى

فور تفعيل خطة الاستجابة للطوارئ في المستشفى، يبدأ تفعيل نظام إدارة الأحداث بالمستشفى (23). ويُعد نظام إدارة الأحداث بالمستشفى الكيان الأساسي للقيادة والرقابة والتنسيق والاتصالات فيما يتعلق بالاستجابة الجماعية للمستشفى. وفور تفعيل نظام إدارة الأحداث بالمستشفى، يبدأ فريق إدارة الأحداث في المستشفى العمل من مركز عمليات الطوارئ الصحية المحدد.

وفور تفعيل نظام إدارة الأحداث بالمستشفى، ينبغي النظر في اتخاذ الإجراءات الحاسمة الآتية:

- يتولى قائد الحدث، الذي أجرى تقييمًا سريعًا للأضرار والاحتياجات، إسناد المهام إلى أعضاء فريق إدارة الأحداث بالمستشفى.
- يراجع فريق إدارة الأحداث بالمستشفى والعاملون والمستجيبون الرئيسيون في المستشفى أوراق عمل الوظائف (ما سيفعلونه، ومتى سيفعلونه، وإلى مَن سيرفعون تقاريرهم بمجرد الانتهاء من المهام المُسنَدة إليهم).
- تُحدَّث المعلومات المرتبطة بتوافر موارد المستشفيات (الموارد البشرية والمادية، وحيز الأسرّة، والقدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة).
- توضع خطة عمل الأحداث، ويطلع عليها مركز عمليات الطوارئ المحلي أو مركز القيادة الميدانية (انظر القسم التالي).
- يستخدم المستشفى بروتوكولات محددة مسبقًا للتحضير لاستقبال المرضى وإجراء الفرز.

- يتلقى فريق إدارة الأحداث بالمستشفى معلومات محدثة عن حالة الاستجابة، ويعدل خطة عمل الأحداث وفقًا لذلك.
- تُحدث إجراءات الاستجابة، استنادًا إلى الاتصالات الداخلية والخارجية.
- يدير مسؤول الاتصال التعاملات مع وكالات الدعم الخارجي.
- يرصد موظفو السلامة المسائل الأمنية المتعلقة بعمليات الاستجابة، ويسدون المشورة لمعالجة المشاكل.

وفي المواقف التي تتطلب استجابة موسعة، يجب أن يكفل فريق إدارة الأحداث بالمستشفى الآتي:

- يجب أن تحصل المناطق/ الخدمات ذات الأولوية في المستشفى على الدعم اللازم حتى تظل قادرة على مواصلة عملها.
- يجب تفعيل إجراءات استدعاء الموظفين والنظر في الاستعانة بمتطوعين.
- يجب إلغاء الجراحات الانتقائية وغيرها من الخدمات غير الأساسية بالمستشفيات أو تأجيلها خلال مرحلة الاستجابة الممتدة.

7-2 عملية تخطيط إجراءات الأحداث

تكتسي عملية تخطيط إجراءات الأحداث وخطة عمل الأحداث أهمية محورية في الاستجابة للطوارئ. وتساعد عملية تخطيط إجراءات الأحداث على مزامنة العمليات وضمان دعمها لأهداف الحدث.

وتُوضع خطة عمل الأحداث لكل فترة تشغيلية.[1] وتوجه خطة عمل الأحداث عملية اتخاذ القرارات الأولية بشأن إدارة الأحداث وأنشطة التخطيط المستمرة. وخطة عمل الأحداث هي الوسيلة التي يُتواصل بشأن التوقعات من خلالها. وهي تقدم إرشادات واضحة بشأن الإجراءات ذات الأولوية للمسؤولين عن إدارة الحدث. وتكون خطة عمل الأحداث أيضًا بمثابة وثيقة مرجعية رئيسية لعملية الاستعراض اللاحق للإجراءات.

وتتضمن خطة عمل الأحداث قائمة شاملة بالتكتيكات والموارد والدعم اللازم لتحقيق الأهداف في إطار زمني محدد. وتساعد الخطوات المختلفة في العملية، التي تنفذ على التوالي، في ضمان وجود خطة عمل شاملة للأحداث. وينبغي مراعاة الآتي عند وضع خطة عمل الأحداث:

- يُعد وضع خطة عمل الأحداث عملية دورية قائمة على فترة تشغيلية مُحددة؛ أي ينبغي تكرار خطوات التخطيط خلال كل فترة تشغيلية.
- يضع فريق إدارة الأحداث بالمستشفى خطة عمل الأحداث، باستخدام أفضل المعلومات المتاحة في وقت الاجتماع التخطيطي. وينبغي للموظفين ألا يؤخروا اجتماعات التخطيط أملًا في تلقي مزيدٍ من المعلومات في وقت لاحق.

1 الفترة التشغيلية هي الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ مجموعة معينة من الإجراءات التكتيكية، على النحو المحدد في خطة عمل الأحداث. ويمكن أن تختلف الفترات التشغيلية من حيث طولها، ولكنها لا تتجاوز عادةً 24 ساعة.

- خلال المرحلة الأولى من إدارة الأحداث، يمكن أن يكون الوضع فوضويًّا، ويصعب الإلمام به. وغالبًا ما يضطر قائد الحدث إلى وضع خطة أولية بسرعة باستخدام معلومات محدودة أو غير كاملة. وينبغي إطلاع فريق إدارة الأحداث بالمستشفى على الخطة الأولية.
- مع تطور الحدث، سيتيح توفر وقت إضافي، وموظفين، ونظم معلومات، وتكنولوجيات، إجراء تخطيط أكثر تفصيلًا وفهرسة الإجراءات واستخلاص الدروس المستفادة.

الإطار 11. السمات الرئيسية لخطة عمل الأحداث

السمات الرئيسية لخطة عمل الأحداث

- إبلاغ مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى، والمنظمات الخارجية، والموظفين عن أهداف الحدث خلال الفترة التشغيلية المقبلة، والموارد المحددة اللازمة، والإجراءات ذات الأولوية لتحقيق الأهداف، والمعلومات التشغيلية الأخرى (مثل الطقس، والعقبات والقيود، والسلامة).
- تحديد مهام العمل، ووضع خارطة طريق للفترة التشغيلية لمساعدة الأفراد على فهم كيفية مساهمة جهودهم في نجاح العملية بشكل عام.
- توضيح كيفية إدماج الموظفين المشرفين المحددين والعناصر التشغيلية المختلفة في هيكل المؤسسة.
- عرض جدول بالاجتماعات الرئيسية والجلسات الإعلامية خلال الفترة التشغيلية.

وتشكل الاجتماعات والجلسات الإعلامية التالية جزءًا من عملية التخطيط، وتتكرر في كل دورة تشغيلية إلى حين انتهاء الحدث.

- **وضع/ تحديث الأهداف:** يحدد قائد الحدث أهداف الحدث خلال الفترة التشغيلية الأولية. وفي نهاية الفترة التشغيلية الأولية، يستعرض قائد الحدث أهداف الحدث، وقد يحتاج إلى التحقق من صحتها أو تعديلها أو وضع أهداف جديدة.
- **اجتماع الاستراتيجية/ اجتماع القيادة وموظفي الخدمة العامة:** بعد وضع أهداف الحدث أو مراجعتها، يجتمع قائد الحدث مع القيادة وموظفي الخدمة العامة (وآخرين، حسب الاقتضاء) لمناقشة الأهداف وتقديم التوجيه.
- **التحضير لاجتماع وضع الأساليب التكتيكية:** بمجرد تحديد نهج تحقيق أهداف الأحداث أو العمل على تحقيقها، يخطط رئيس قسم العمليات لعقد اجتماع لوضع الأساليب التكتيكية، وتحديد الموارد اللازمة خلال الفترة التشغيلية.
- **اجتماع وضع الأساليب التكتيكية:** تستعرض الجهات الفاعلة الرئيسية الأساليب التكتيكية المقترحة، وتخطط لكيفية تخصيص الموارد. ويقود رئيس قسم العمليات اجتماع وضع الأساليب التكتيكية. ومن بين المشاركين الرئيسيين في الاجتماع رئيس قسم اللوجستيات ومسؤول السلامة وممثل التخطيط وغيرهم.

- **اجتماع التخطيط:** عقب اجتماع وضع الأساليب التكتيكية، يتعاون الموظفون على تحديد احتياجات الدعم وتخصيص موارد محددة. ويُعَدُّ اجتماع التخطيط بمثابة استعراض نهائي للخطط التشغيلية وتخصيص الموارد التي أُعِدَّت أثناء اجتماع وضع الأساليب التكتيكية وبعده، واعتمادها. وفي نهاية اجتماع التخطيط، تؤكد القيادة وموظفو الخدمة العامة دعمهم للخطة.
- **إعداد خطة عمل الأحداث واعتمادها:** بناءً على الموافقة في الاجتماع التخطيطي، يعتمد قائد الحدث الخطة.
- **جلسة إحاطة عن الفترة التشغيلية:** تبدأ كل فترة تشغيلية بجلسة إحاطة عن الفترة التشغيلية. ويتلقى الموظفون المعنيون بالإشراف على الحدث والأساليب التكتيكية خطة عمل الأحداث خلال جلسة الإحاطة. ويعرض أعضاء القيادة وموظفو الخدمة العامة أهداف الحدث، ويستعرضون الوضع الراهن، ويتبادلون المعلومات بشأن الاتصالات أو السلامة. ثم يُطلِع المشرفون الموظفين المكلفين على مهام كل منهم.

8-2 مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى

يستخدم فريق إدارة الأحداث بالمستشفى مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى لعقد اجتماعات لأعضاء الفريق وتنسيق أنشطة الاستجابة (السريرية، وخدمات الدعم، والشؤون الإدارية والمالية)؛ وتحديد أولويات الموارد؛ وإدارة المعلومات؛ وضمان سلامة العمليات وأمنها. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستخدم آليات الأربعة «تاء»، ألا وهي: التواصل والتعاون والتنسيق والتضافر، لتسهيل عملية اتخاذ القرار.

ونظرًا إلى أن مركز عمليات الطوارئ في المستشفى ليس مرفقًا دائمًا، يجب على المستشفيات أن تحدد العوامل التي سيُتخذ على أساسها قرار بتفعيل العمليات، إذ إن ذلك سيتطلب تحويل الحيز المكاني المتاح، والحصول على المعدات والموارد الأساسية، مثل معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخرائط واللوحات وما إلى ذلك. ويجب أن تحدد خطة استجابة المستشفى هذه العوامل بوضوح، وأن تحدد الشخص المُخوَّل بتفعيل عمل مركز عمليات الطوارئ. وتشمل المعايير المحتملة لتفعيل عمل مركز عمليات الطوارئ الآتي:

- زيادة الطلب على المستشفى لإدارة حالة الطوارئ.
- عددًا كبيرًا من المرضى.
- وضعًا يتطلب تحديد أولويات الموارد المحدودة وتخصيصها للمناطق الحرجة لضمان استمرار العمليات.
- الحاجة إلى تنسيق المشاركة فيما بين أقسام المستشفى المتعددة، وتشمل المشاركة المحتملة لوكالات الدعم الخارجي، والتنسيق مع مراكز عمليات الطوارئ التابعة للوكالات الأخرى.

وينبغي النظر في الاحتياجات الآتية عند اختيار موقع مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى وتصميمه:

- **سهولة الوصول إليه:** يجب أن يكون في منطقة يسهل الوصول إليها من أي جزء من المستشفى على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ولكن دون أن يعوق ذلك العمليات الحيوية، مثل وحدة الطوارئ، أو المناطق العامة المفتوحة.
- **المرونة:** توافر مساحة كافية تتسع للمعدات والأثاث والإمدادات والتكنولوجيا لاستيعاب فريق إدارة الأحداث بالمستشفى.

- **الاستدامة:** توافر بنية أساسية كافية لدعم عمليات الطوارئ دون انقطاع على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ويشمل ذلك الوصول في حالات الطوارئ إلى الدوائر الكهربائية ومخارج الكهرباء والإضاءة ونظم الحاسوب، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن توافر الغذاء والماء والراحة خلال فترات العمل الممتدة.
- **الأمن:** يجب حماية المرفق والمتواجدين فيه ونظم ومعدات الاتصالات، والمعلومات الحساسة. ولا يُسمح بدخول المنطقة إلا للأشخاص المُصرَّح لهم بذلك.
- **القدرة على البقاء:** يجب أن يكون الموقع قادرًا على تحمل أثر الأخطار المحلية، وتجنب مناطق الخطر الداخلية المعتادة. وفي الحالات التي لا يعمل فيها الموقع الرئيسي بشكل جيد، يجب أن تتضمن الخطة موقعًا بديلًا.
- **قابلية التشغيل البيني:** يجب التخطيط للموقع بما يكفل إمكانية استخدام التكنولوجيا لتبادل المعلومات الروتينية والتي لا تحتمل الانتظار مع مراكز عمليات الطوارئ الأخرى.

9-2 التواصل والتنسيق

يصف التواصل بشأن الأزمات عملية تقديم حقائق عن حالة طارئة أو كارثة تتطلب استجابة فورية. وتتصف المرحلة الأولى من الأزمة بالارتباك والاهتمام الإعلامي المكثف. وعادة ما تكون المعلومات ناقصة، والحقائق قليلة. وكثيرًا ما تتعطل قنوات التواصل. ومن الضروري إدراك أن المعلومات الواردة من وسائل الإعلام والمؤسسات الخارجية، وحتى وكالات الاستجابة الأخرى، قد لا تكون دقيقة تمامًا. ومن المهم معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ما حدث، والوقوف على ردود المؤسسة أو الوكالة في إطار عملية التواصل، والتأكد من حجم الحدث في أسرع وقت ممكن. وتتمثل وظيفة القائمين على التواصل بشأن الأزمات في تزويد موظفي المستشفى والمرضى والجمهور بمعلومات يسهل فهمها وموثوقة ودقيقة ومتسقة وفي الوقت المناسب، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وفي المرحلة الأولى من الأزمة، تكون دقة المعلومات التي تُنشر وسرعة اعتراف المسؤولين عن الاستجابة بالموقف الراهن من الأمور البالغة الأهمية. وعدم توافر جميع الحقائق في المتناول في أولى مراحل الأزمة لا يعفي القائمين على التواصل بشأنها من مسؤوليتهم عن إبلاغ الموظفين وصُناع القرار والجمهور بما هو معروف. والتزام الصدق وقول «ما زلنا لا نعرف» أفضل من تعتيم كامل للمعلومات.

ويُعد جمع المعلومات وتبادلها (داخليًّا وخارجيًّا على حد سواء) أمرًا بالغ الأهمية لإدارة الحدث بنجاح **داخل المستشفى**. وستعزز الاستراتيجيات والتكنولوجيات التالي ذكرها (حيثما كانت متاحة) التواصل الداخلي الفعال:

- جمع المعلومات من أقسام المستشفى المختلفة عن طريق الهاتف أو شبكة المعلومات الداخلية (الإنترانت) أو البريد الإلكتروني أو الفاكس.
- توفير أجهزة لاسلكية لمناطق محددة في المستشفى، وتخصيص قنوات أو ترددات معينة.
- إتاحة الاستمارات، التي يستكملها الموظفون، على شبكة الإنترانت/ الإنترنت أو تقديمها في شكل مطبوع.
- تبادل تحديثات الموقف بانتظام، وإرشادات الاستجابة، وطلبات المساعدة عبر جهاز اللاسلكي، أو الإنترانت/ الإنترنت، أو النسخ الورقية، أو الاجتماعات المباشرة.

- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستخدام نظام المراسيل في نقل المعلومات (أشخاص يوصِّلون الرسائل بأنفسهم)، خاصة إذا فشلت قنوات التواصل الرئيسية.
- إشراك موظفي القيادة الرئيسيين والأخصائيين الطبيين والتقنيين لضمان حصول جميع موظفي المستشفى على المعلومات الصحيحة، مما يؤدي إلى دحض الشائعات، والقضاء على المخاوف. وهذا من شأنه أن يساعد أيضًا في إدارة التدفق المفرط في المعلومات (وتشمل المعلومات الكاذبة أو المضللة).

ومن الضروري إبقاء المرضى والزوار على علم بالمعلومات الصحيحة. ويمكن استخدام الوسائل الآتية لنقل المعلومات حول ما حدث والجاري تنفيذه لمعالجة مختلف المسائل:

- الإعلانات عبر شبكة تخاطب عامة للمستشفى.
- تطمينات شخصية من الموظفين.
- من خلال قناة المستشفى التلفزيونية (إن وجدت).
- نشر تحديثات المعلومات بشكل استراتيجي في جميع أنحاء المستشفى.
- طباعة مواد لتُوزَّع مع صواني الوجبات الفردية للمرضى.

ويُعدُّ التواصل مع **شركاء الاستجابة الخارجيين** أمرًا ضروريًّا. وإذا تكشف وضع ما دون إخطار أولي بواسطة الخدمات الطبية الطارئة، أو إدارة الإطفاء أو جهات إنفاذ القانون، يجب إطلاع شركاء الاستجابة الخارجيين على آخر مستجدات الوضع وطلبات المساعدة. وفي إطار الاتصالات الخارجية للمستشفى، تشمل الاعتبارات الرئيسية الآتي:

- من شأن التبادل الدوري للمعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات بين جميع مستشفيات شبكة المنطقة المحلية أن يساعدا على تعظيم الاستفادة من موارد المستشفيات، والحيلولة دون إنهاك قدرة المرافق الأصغر حجمًا.
- إقامة روابط مع مجموعات مجتمعية معروفة من مشغلي اللاسلكي الهواة المحليين المهرة الموثوق بهم، والذين يمتلكون معدات اتصال يمكن الاعتماد عليها. ويجب مراعاة أن معظم القنوات اللاسلكية التي يستخدمها الهواة ليست آمنة، وقد يسمع هذه الرسائل متلقون غير مستهدفين، مثل وسائل الإعلام والجمهور.
- يُعد تنظيم المؤتمرات عن بُعد ومؤتمرات الفيديو من الأدوات المفيدة أيضًا.
- ينبغي الاحتفاظ بدليل للموارد يُحدَّث بانتظام بشأن الوكالات الخارجية والبائعين للتمكن من تحديد جهات الاتصال بسرعة.
- يُعد مسؤول الاتصال المُعيَّن هو المختص الرئيسي بالاتصال في المستشفى مع جميع الوكالات الخارجية، ويكون غالبًا بمثابة حلقة وصل ثنائية الاتجاه بين مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى ومركز عمليات الطوارئ المحلي والمراكز التنسيقية المحلية الأخرى في المنطقة.

وخلال المرحلة الأولى لأي حالة طوارئ، يجب على القائمين على التواصل بشأن الأزمات اتخاذ خطوات لإثبات المصداقية أمام **الجمهور**. وهذا يتيح للجمهور التعرف على دور الاستجابة للأزمات والاستقصاء بشأنها وحلها. وكذلك، فإن طريقة تعامل المتحدث الرسمي مع استفسارات الجمهور ووسائل الإعلام وما يقولونه تُثبت أيضًا مصداقية المستشفى والنظام الصحي. وكشخصٍ مسؤول ومتحكم في مجريات الأمور، من الضروري أن يلتزم مسؤول الاتصال أمام الجمهور بأنه سيواصل تقديم أي معلومات جديدة متى كانت متاحة. وعند التواصل مع الجمهور والفئات المتضررة، يؤخذ بعين الاعتبار النقاط الآتية:

- التعبير عن التعاطف والطمأنة، والحد من الاضطرابات العاطفية.
- تعيين متحدثين رسميين للأزمة أو باسم المستشفى، وتحديد القنوات الرسمية للاتصال وطرقه.
- تكوين فهم عام وموسع لظروف الأزمة وعواقبها ونتائجها المتوقعة على أساس المعلومات المتاحة.
- تكييف الرسائل ومواد الاتصال المُعدَّة مسبقًا من السلطات الصحية ومنظمة الصحة العالمية.
- الحد قدر الإمكان من عدم اليقين المتعلق بالأزمات.
- مساعدة الجمهور في فهم مسؤوليات مختلف المؤسسات المشارِكة في الاستجابة.
- تعزيز الكفاءة الذاتية (يُوضح للناس أن بإمكانهم مساعدة أنفسهم أو الوصول إلى هدف ما) من خلال أنشطة الاستجابة الشخصية، وإطلاعهم على طريقة الحصول على المزيد من المعلومات ومصادرها.

الإطار 12. نصائح وإرشادات حول التواصل بشأن الأزمات

نصائح وإرشادات حول التواصل بشأن الأزمات (24)

- **عدم الإفراط في الطمأنة:** لا يتمثل الهدف في التخفيف من جميع المخاوف، بل في تقديم تفاصيل دقيقة. ويمكن النظر في استخدام بعض العبارات، مثل: «هذه عاصفة خطيرة، ولكن يستطيع الناس اتخاذ بعض الإجراءات للحد من المخاطر. التزموا منازلكم، وابتعدوا عن الشوارع، إن أمكن، حتى تمر العاصفة وتُفتح الشوارع».
- **الاعتراف بعدم اليقين:** تقديم المعلومات المعروفة فقط: «الوضع يتطور، وليس لدينا بعد كل الحقائق. ولكن بناءً على ما نعرفه، نتوقع...»
- **التأكيد على أنه جارٍ تنفيذ إجراءات لمعرفة المزيد:** توصف هذه العملية بعبارات بسيطة: «تؤخذ عينات من كل شخص يُبلِغ عن أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا. وجارٍ اختبار هذه العينات الآن لتحديد السلالة بدقة».
- **تقديم إرشادات استباقية:** في حالة معرفة النتائج السلبية المستقبلية، يجب إخبار الناس بما يجب عليهم توقعه. فعلى سبيل المثال، يمكن استعمال العبارة الآتية للتحذير من الآثار الجانبية للمضادات الحيوية، «هذا المضاد الحيوي الواسع الطيف هو دواء فعال، لكنه يمكن أن يسبب اضطراب المعدة للبعض، ويشمل ذلك الغثيان والإسهال».
- **التعبير عن الأسف وتجنب الأسلوب الدفاعي:** يمكن قول «كنا نتمنى توفُّر جرعات أكثر من اللقاح في الوقت الحالي»، أو «نشعر بالأسى حيال ...» عند الاعتراف بالأخطاء أو الإخفاقات التنظيمية.
- **الإقرار بمخاوف الناس:** لا ينبغي إخبار الناس أنه لا ينبغي أن يخافوا. فهم خائفون، ويحق لهم أن يشعروا بالقلق. وبدلًا من ذلك، يمكن استخدام عبارات مثل «نحن نتفهم قلق الناس وخوفهم، فمن الطبيعي أن يشعر المرء بالخوف عندما يواجه واقعًا صادمًا».
- **الاعتراف بالأسى المشترك:** قد يشعر بعض الناس بقدرٍ أقل من الخوف وأكبر من الأسى، إذ ينتابهم شعور باليأس والهزيمة. لذا، ينبغي الاعتراف بالمعاناة الناجمة عن وقوع الكارثة، ثُمّ مساعدة الناس للمضي نحو المستقبل من خلال إجراءات إيجابية. ويمكن استخدام عبارات مثل: «مع وجود الكثير من الناس في الملاجئ في الوقت الحالي، من الصعب أن نعرف كيف ستعود الأمور إلى طبيعتها. لكننا نعمل جاهدين لبدء عملية إعادة الناس إلى منازلهم».
- **التعبير عن الأمنيات:** يمكن قول: «أتمنى لو كنا نعرف المزيد»، أو «أتمنى لو كانت إجاباتنا أكثر دقة».
- **الاستعداد للرد على أسئلة «ماذا لو»:** هذه هي الأسئلة التي تدور في أذهان الجميع، ويريدون إجابات الخبراء بشأنها. ومع ذلك، ليس عمليًا في أغلب الأحيان إثارة أسئلة «ماذا لو» عندما يكون قد تم بالفعل احتواء الأزمة، ومن غير المرجح أن تؤثر على أعداد كبيرة من الناس. ومن ناحية أخرى، من المعقول الإجابة عن أسئلة «ماذا لو» إذا كان من الممكن أن يحدث هذا الافتراض، ويجب أن يكون الناس مستعدين وجدانيًا له. وتُستخدم عبارات مثل: «لقد أخذنا بعين الاعتبار إمكانية أن يزداد الوضع سوءًا، وحددنا أماكن إضافية للملاجئ».
- **تكليف الناس بأشياء يفعلونها:** في حالات الطوارئ، تستهدف بعض الإجراءات الضحايا أو المعرَّضين للخطر أو الذين يُحتمل تعرُّضهم للخطر. وستمنح الإجراءات البسيطة في حالات الطوارئ الناس شعورًا بالتحكم في زمام الأمور، وستساعد على تحفيزهم على البقاء منتبهين لما يحدث. وقد يكون من المفيد أيضًا أن تُقدم للأشخاص خيارات بالإجراءات التي تتناسب مع مستوى شواغلهم. ويمكن تقديم مستويات مختلفة من الردود: الحد الأدنى من الرد، والحد الأقصى من الرد، والحد المتوسط المُوصَى به من الرد. وتُستخدم عبارات مثل «قد ترغب في طهي السبانخ جيدًا قبل تناولها. وقد ترغب في تجنُّب أكل السبانخ. أو قد ترغب في تناول السبانخ المجمدة المعبأة فقط».
- **طلب فعل المزيد من الناس:** لعل أهم دور للمتحدث الرسمي هو أن يطلب من الناس إدارة المخاطر، والعمل على إيجاد حلول لها معه، إذ يمكن أن يتحمل الناس قدرًا كبيرًا من المخاطر، وخاصة المخاطر الطوعية. فإذا تم الإقرار بشدة المخاطر وتعقيدها، والاعتراف بمخاوف الناس، يمكن بعدها أن يُطلب منهم بذل قصارى جهدهم. ويمكن للمتحدث الرسمي، وخاصة الشخص الموجود على أرض الواقع والمعرَّض لخطر شخصي، أن يقدم نموذجًا للسلوك المناسب - ليس سعادة زائفة، ولكن رغبة حقيقية في الاستمرار في الحياة قدر الإمكان، واتخاذ خيارات معقولة. وسيساعد تصميمه على مواجهة المخاطر الآخرين في البحث عن نموذج يقتدون به.

10-2 تعبئة الموارد بمرونة وفي الوقت المناسب

تُعدُّ تعبئة الموارد بمرونة وفي الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتمكين المستشفيات من الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. ويساعد تنفيذ الاستراتيجيات الموضحة أدناه المستشفيات على ضمان حصول المرضى على الأدوية والإمدادات الطبية المناسبة والرعاية اللازمة خلال حالات الطوارئ:

- **التخطيط للطوارئ قبل وقوعها:** وضع خطط تفصيلية تشمل نُظُم إدارة المخزون المصممة خصيصًا للإمدادات الطبية والأدوية؛ وتحديد استراتيجيات شراء الأدوية والإمدادات الأساسية وتخزينها وتنظيمها استنادًا إلى سيناريوهات الطوارئ المحتملة. ومن خلال الاحتفاظ بمخزونات مُحدَّثة وفهم الاحتياجات المحددة للمرضى من السكان، يمكن أن تكفل المستشفيات توافر الأدوية والإمدادات المناسبة أثناء حالات الطوارئ.
- **التخزين والمخزون المتوافر في الوقت المناسب:** الاحتفاظ بمخزونات استراتيجية من الأدوية والإمدادات الأساسية لتلبية الاحتياجات الطارئة الفورية. ويجب رصد هذه المخزونات وتجديدها بانتظام حسب الحاجة. وتُطبق تقنيات إدارة المخزون الذي يجب أن يتوافر في الوقت المناسب للحفاظ على توافر الإمدادات بسهولة دون الإفراط في التخزين، مما يساعد على تحسين استغلال المساحة، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى.
- **الشبكات التعاونية والتنسيق الإقليمي:** المشاركة في الشبكات التعاونية ونُظُم التنسيق الإقليمي لتيسير تبادل الأدوية والإمدادات الطبية أثناء حالات الطوارئ. ويمكن أن يشمل ذلك التنسيق مع الوكالات المحلية والإقليمية والوطنية المعنية بإدارة الطوارئ ومرافق الرعاية الصحية المجاورة والمنظمات المجتمعية. ومن خلال هذه الشبكات، يمكن للمستشفيات أن تطلب المساعدة وتقدمها، وأن تتقاسم الموارد الفائضة، وأن تضمن توزيعًا أكثر إنصافًا للأدوية والإمدادات في جميع أنحاء المناطق المتضررة.
- **الإدارة الفعالة لسلسلة الإمداد:** إنشاء نظم فعالة لإدارة سلسلة الإمداد من أجل تيسير شراء الأدوية والإمدادات الطبية ونقلها وتوزيعها. ويشمل ذلك إقامة علاقات مع موردين موثوقين، وتنفيذ نظم تتبع في الوقت الحقيقي، واستخدام التكنولوجيات اللوجستية المتقدمة. ومن خلال الوصول بسلسلة الإمداد إلى المستوى الأمثل، يمكن أن تكفل المستشفيات إيصال الأدوية والإمدادات في الوقت المناسب إلى الخطوط الأمامية للاستجابة للطوارئ.
- **تحديد الأولويات والتخصيص:** إعطاء الأولوية لتخصيص الأدوية والإمدادات الطبية على أساس شدة احتياجات المرضى ومدى إلحاحها. ويمكن للمستشفيات تنفيذ بروتوكولات الفرز لتحديد المرضى وتصنيفهم وفقًا لمستوى الرعاية المطلوبة. ويساعد ذلك المستشفيات على تخصيص الموارد حيثما تشتد الحاجة إليها، بما يضمن توفير الأدوية والإمدادات الحيوية للمرضى الذين يحتاجون إلى عناية فورية.
- **إعادة التوزيع المرن للموارد:** الحفاظ على المرونة في تخصيص الموارد من خلال إعادة توزيع الأدوية والإمدادات داخل أحد المرافق أو عبر مختلف الأقسام، بناءً على الطلب المتغير أثناء الطوارئ. ويشمل ذلك نقل الموارد من المناطق غير العاجلة إلى وحدات رعاية الحالات الحرجة، أو إعادة تكليف الموظفين للاستفادة من الإمدادات المتاحة بكفاءة. ويمكن أيضًا أن تتعاون المستشفيات مع الصيدليات المحلية والموردين المحليين للحصول على موارد إضافية عند الضرورة.

- **الرصد والتكييف المستمران:** يجب أن يكون هناك رصد مستمر لاستخدام الأدوية والإمدادات الطبية وتوافرها أثناء الاستجابة للطوارئ. ويمكن للمستشفيات أن تكيف استراتيجياتها لتعبئة الموارد بسرعة عن طريق تتبع مستويات المخزون وأنماط الاستخدام واحتياجات المرضى عن كثب. وقد ينطوي ذلك على تعديل خطط المشتريات، أو زيادة الإنتاج، أو تحديد موردين بديلين لمعالجة أي نقص أو فوائض.
- **الامتثال التنظيمي:** ينبغي الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية وتخزينها وتوزيعها. ويكفل الامتثال للوائح شراء الأدوية والإمدادات المناسبة من مصادر معتمدة، واستيفاء معايير الجودة والسلامة. ويساعد هذا على منع استخدام المنتجات المزيفة أو المنتجات المتدنية النوعية أثناء الطوارئ.

11-2 معايير قائمة على الاحتياجات ومعدَّلة حسب المخاطر

سيسترشد فريق إدارة الأحداث بالمستشفى بنتيجة تقييم الاحتياجات في تحديد الموارد اللازمة لدعم الاستجابة. وإذا كانت الموارد المتاحة غير كافية لتلبية الطلب، فإن دور فريق إدارة الأحداث بالمستشفى يتمثل في تحديد أولويات الموارد المتاحة وتخصيصها لتلبية الاحتياجات المفاجئة. وإجمالًا، يتطلب وضع معايير للطوارئ قائمة على الاحتياجات ومعدَّلة حسب المخاطر مزيجًا من تقييمات الاحتياجات والمخاطر، والتوحيد القياسي، وتحديد الأولويات، والتخصيص، والرصد والتقييم، والمراجعة والتحديث بانتظام. ويتمثل الهدف النهائي في ضمان توزيع الموارد توزيعًا عادلًا وفعالًا، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للسكان المتضررين.

ويجب النظر في الإجراءات الآتية لإدارة الموارد أثناء مرحلة الاستجابة:

- **تقييم الاحتياجات:** إجراء تقييم شامل لتحديد احتياجات السكان المتضررين، ومنهم الفئات المستضعفة والفئات الأكثر عُرضة للمخاطر.
- **توحيد المعايير:** وضع معايير موحدة لتقييم الاحتياجات والمخاطر، وتشمل المؤشرات والعتبات لتحديد مدى شدة حالة الطوارئ.
- **تحديد الأولويات:** تحديد أولويات الموارد على أساس شدة حالة الطوارئ، واحتياجات السكان المتضررين، ومستوى المخاطر.

- عندما تكون الموارد محدودة (كما كانت الحال مع معدات الحماية الشخصية أثناء جائحة كوفيد-19)، يمكن تعديل معايير الاستخدام، باتباع نهج تعديل المخاطر للتكيف مع النقص إلى أن يستقر توافر الموارد. ويمكن استكشاف الأدوات الحالية، مثل أداة حساب معدل استهلاك معدات الوقاية الشخصية التي طورتها الولايات المتحدة الأمريكية. وتتولى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تقدير المدة التي سيغطيها الإمداد المتبقي من معدات الحماية الشخصية، بناءً على متوسط معدل الاستهلاك. ويمكن أن تساعد هذه الأداة المرفق الصحي في وضع توقعاته بشأن الاحتياجات المستقبلية.
- يمكن لفريق إدارة الأحداث بالمستشفى تفعيل اتفاقات المساعدة المتبادلة واتفاقات البائعين حتى لا يتوقف توريد الإمدادات الحيوية للمستشفيات.

- **التخصيص:** توضع إجراءات شفافة ومنصفة لتخصيص الموارد، مثل الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية. وتُحدد أكثر وسائل الإيصال والتوزيع فعالية (مثلًا من خلال المؤسسات المحلية والشبكات المجتمعية).
  - قد ترتبط القرارات المتعلقة بنقل الموارد من المناطق غير الأساسية بالحيز المكاني والمرافق والمعدات والإمدادات والعاملين الطبيين.
  - يجب طلب موارد إضافية (إذا لزم الأمر) من خلال مراكز عمليات الطوارئ من السلطات المحلية، وإدارات الصحة العامة، وسلطات إنفاذ القانون، وما إلى ذلك.
  - ينبغي التنسيق عن كثب مع مراكز عمليات الطوارئ المحلية ومراكز القيادة الميدانية لرصد ومراقبة توزيع المرضى للحيلولة دون إنهاك قدرة أي مستشفى.
  - تُخصص المعدات والإمدادات والأدوية الشحيحة على النحو الذي ينقذ أكبر عدد من الأرواح، بدلًا من التركيز على إنقاذ الأفراد. وينبغي وضع الآتي في الاعتبار:
    - تغيير معايير مكافحة العدوى للسماح بعزل المجموعات بدلًا من وحدات عزل كل فردٍ على حدة.
    - قَصْر استخدام أجهزة التَّنفُّس الاصطناعي على الحالات الجراحية.
    - إنشاء مواقع بديلة للرعاية في المرافق التي لم تكن مُصمَّمة لتوفير الرعاية الطبية، مثل المدارس أو الكنائس أو الفنادق (تعديل حماية الخصوصية والسرية مؤقتًا).
- **المرونة** في تعديل المعايير الخاصة باستخدام الإمدادات الطبية، مثل استخدام الإمدادات والمعدات الشائعة وإعادة استخدامها (القفازات، والعباءات الطبية، والكمامات، وأسرّة المستشفيات).
- **الرصد والتقييم:** إنشاء نظام لرصد وتقييم فعالية المعايير، ويشمل ذلك تتبع تخصيص الموارد وتوزيعها وتقييم الأثر على السكان المتضررين.
- **المراجعة والتحديث بانتظام:** مراجعة المعايير وتحديثها بانتظام استنادًا إلى الاحتياجات والظروف المتغيرة، فضلًا عن التعليقات الواردة من السكان المتضررين وأصحاب المصلحة.

الموظفون

للموارد البشرية بالمستشفى دورٌ بالغ الأهمية أثناء حالات الطوارئ. فهي تساعد في إعداد وتنفيذ خطط التأهب للكوارث، وإدارة سلامة الموظفين، وتلبية احتياجات التوظيف، وضمان حصول المرضى على الرعاية دون انقطاع أثناء حالات الطوارئ، وتقديم الرعاية الكافية أثناء فترة المتابعة بعد انتهاء حالة الطوارئ.

12-2 سلامة الموظفين وأمنهم وصحتهم ورفاههم

تُعدُّ الموارد البشرية بالمستشفى أساسية لإدارة الطلب المتزايد أثناء حالة الطوارئ، والحفاظ على الخدمات الأساسية للمرضى الداخليين الحاليين. وتزداد أهميتها أثناء عمليات الاستجابة الممتدة عندما يكون تعرض الموظفين للإنهاك أمرًا شائعًا. وإذا لم تُعالج هذه المسألة بشكل مناسب، فقد تؤدي إلى زيادة الأخطاء الطبية، والعدوى المكتسبة في المستشفيات، ونقص الموظفين، وأوجه القصور العامة في المستشفيات، وتوقف العمليات. ويُوصَى باتخاذ الإجراءات الآتية لإدارة الموارد البشرية أثناء حالات الطوارئ:

- **رصد علامات وأعراض إصابة الموظفين بالإنهاك والإجهاد النفسي.**
- **توفير قسط وافٍ من الراحة ومرافق الراحة للموظفين عن طريق تنظيم جداول العمل.**
- **ينبغي لمسؤولي السلامة في فريق إدارة الأحداث بالمستشفى إطلاع الموظفين على الموارد المتاحة لهم.**
- **رصد مشكلات السلامة والأمن بانتظام لضمان تهيئة بيئة عمل آمنة.**
- **خضوع الدخول إلى المناطق الحيوية بالمستشفيات للرقابة.**
- **توفير التمنيعات للعاملين الصحيين.**
- **رصد وتوثيق إصابات الموظفين التي تعرضوا لها أثناء الحدث. وتقديم الدعم والتعويض اللازمين، حسب الاقتضاء.**
- **الحفاظ على مستويات توظيف كافية أثناء الطوارئ للحيلولة دون التعرض للإرهاق في العمل والإنهاك، وهو ما يمكن أن يضر بسلامة الموظفين وصحتهم.**
- **توفير خدمات دعم الصحة النفسية للموظفين وأسرهم، ويشمل ذلك المشورة، والتدبير العلاجي للإجهاد، ودعم الأقران.**
- **وضع خطط لدعم الأسر لضمان إطلاعها على آخر المستجدات وإعدادها ورعايتها أثناء حالات الطوارئ وإدراكها لخدمات الدعم المتاحة.**
- **إقامة شراكات مع الوكالات المحلية لإدارة الطوارئ والمؤسسات الأخرى لتبادل الموارد والخبرات والدعم أثناء حالات الطوارئ.**

13-2 أدوات الاستجابة ومواردها

- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. إطار الاستجابة للأخطار المتعددة في قطاع الصحة. واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ 2019. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3SjPX9i.
- منظمة الصحة العالمية. تقرير المشاورة التقنية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية خلال حالات الطوارئ الصحية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2022. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3u1D6AB.
- مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا. قائمة مراجعة بإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ في المستشفيات. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2011. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/49b0gmH.
- منظمة الصحة العالمية. الوقاية من العدوى ومكافحتها في سياق مرض فيروس كورونا (كوفيد-19): إرشادات قابلة للتحديث. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2023. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3Im2e8x.
- منظمة الصحة العالمية. المتطلبات الدنيا لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3SAzLSk.
- منظمة الصحة العالمية. إزالة التلوث وإعادة معالجة الأجهزة الطبية لمرافق الرعاية الصحية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2022. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3TPsjTW.
- منظمة الصحة العالمية. الاحتياطات القائمة على طريقة انتقال العدوى للوقاية من العدوى ومكافحتها: مذكرة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2022. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/49Ts5Aq.
- هيئة الخدمات الطبية الطارئة في كاليفورنيا. نظام السيطرة على الحوادث في المستشفيات: الدليل الإرشادي والتذييلات. [رانشو كوردوفا، كاليفورنيا]: هيئة الخدمات الطبية الطارئة في كاليفورنيا؛ 2014. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3vVg9Q3.
- منظمة الصحة العالمية. التواصل بشأن المخاطر في طوارئ الصحة العامة: إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات وممارسات التواصل بشأن المخاطر في حالات الطوارئ. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3HDq3rY.
- منظمة الصحة العالمية. مسؤولية الجميع: إجراءات تشمل المجتمع بأسره لإدارة المخاطر الصحية والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالات الطوارئ والكوارث: إرشادات عملية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3uagyxl.
- منظمة الصحة العالمية. إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الاستعداد للاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية والكوارث. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3UYUj8z.
- منظمة الصحة العالمية. تصنيف الفِرَق الطبية للطوارئ ومعاييرها الدنيا. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3u8cU7d.
- المحررون: هانفلينغ د.، هيك ج. ل.، ستراود س. معايير الرعاية أثناء الأزمات: مجموعة أدوات للمؤشرات والمحفزات. واشنطن العاصمة: مطبعة الأكاديميات الوطنية؛ 2013. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3SeM7yg.



محطة معالجة مياه الصرف الصحي. المستشفى العام للمنطقة (33)، المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، خليج باندیراس، نایاریت، المكسيك. مركز (MEX-35) المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية القادرة على الصمود، 2022.

3 بعد: مرحلة التعافي

يغطي هذا القسم مرحلتين: **التعافي والتعلم**. فور وقوع أزمة ما، يؤدي تنفيذ التدخلات للحالات الحرجة في الوقت المناسب إلى إنقاذ الأرواح. وتُرسي هذه الإجراءات الأساس للتعافي المستدام، والعودة السريعة إلى الحياة الطبيعية. وتشمل مرحلة التعافي تدخلات قصيرة الأجل من أجل التعافي المبكر؛ وتدخلات قصيرة إلى متوسطة الأجل تسهم في إعادة التأهيل؛ وتدخلات متوسطة إلى طويلة الأجل تهدف إلى إعادة البناء. ومن الناحية المثالية، فإن العملية الانتقالية عبر مراحل التعافي ستساعد المستشفيات على زيادة استعدادها للطوارئ اللاحقة. ويتمثل الهدف الرئيسي لمرحلة التعافي في إعادة عمليات المستشفيات إلى المستويات التي كانت عليها قبل الطوارئ، وإعادة البناء على نحو أفضل من خلال القدرات التحويلية وقدرات التعلم.

وتصبح المستشفيات أكثر قدرة على الصمود عندما تستفيد استفادة جيدة من الدروس المستفادة التي استُخلصت أثناء الاستجابة للكوارث والطوارئ الصحية السابقة والتعافي منها. ويتطلب تحسين القدرة على الصمود أن تتبنى المستشفيات عملية تعلم مستمر، وأن تُجري تغييرات لتحسين الممارسات مع مرور الوقت. ويجب تحليل التجارب والدروس المستفادة وتطبيقها كجزء لا يتجزأ من دورة التحسين المستمر، ويجب أن تكون متأصلة في الثقافة التنظيمية للمستشفى. ويتعين كذلك ترسيخها في كل من الإدارة الروتينية، وتقديم الخدمات الروتينية للمستشفيات. وسيسهم وضع برامج قوية لإدارة مخاطر الطوارئ والكوارث في تنفيذ تدخلات الوقاية من الأخطار، والتخفيف من وطأتها، وتنمية قدرات إدارة الأزمات، استنادًا إلى التقييم السياقي للمخاطر وتحديد أولوياتها. وتُعدُّ هذه التدخلات بالغة الأهمية لقدرة المستشفى على الصمود والاستعداد بوجه عام.

3-1 التعافي

المواد

3-1-1 إجراءات المستشفى للتعافي

حتى يتسنى تقليل توقف الخدمات الطبية إلى أدنى حد، تبدأ مرحلة التعافي بسرعة في المستشفيات. ولا بد من العودة إلى العمليات العادية في أقرب وقت ممكن لمواصلة تقديم الرعاية الطبية المستمرة للمرضى المقيمين في المستشفى، وتلبية الاحتياجات الطبية للمجتمع المحلي الأكبر. وتكون عمليات الاستجابة للكوارث والتعافي منها مترابطة ومتداخلة، وكثيرًا ما تُنفذ على نحوٍ متزامن. وقد يُجرى تقييم احتياجات الخدمات الصحية والاجتماعية المجتمعية وموارد التعافي لتلبية هذه الاحتياجات أثناء عمليات الاستجابة الجارية. وتشمل الأمثلة على تدخلات التعافي المبكر خلال مرحلة الاستجابة سرعة إزالة الأنقاض، وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمرفق.

ومع انتقال المستشفى إلى مرحلة التعافي، ستعود المرافق التي أعيد توظيفها على المدى القصير إلى استخدامها ووظائفها المعتادة. ومع ذلك، عندما تتعرض البنية الأساسية للمستشفيات لأضرار جسيمة، قد يكون من الضروري تكييف المرافق المؤقتة أو استخدامها لضمان استمرارية الرعاية. وفيما يلي بعض الأمثلة:

- يمكن استخدام المرافق المقامة في خيام أو غيرها من مواقع الرعاية البديلة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المستجدة العاجلة في المجتمع المتضرر. وقد تساعد الفرق الطبية في حالات الطوارئ في تجهيز هذه المرافق لتوفير خدمات للمرضى الداخليين والخارجيين.
- العيادات المتنقلة.
- إذا كانت العملية الرئيسية لإعادة بناء المرافق المتضررة تتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت لاستكمالها، فقد يلزم إنشاء مبانٍ نموذجية مؤقتة كتدبير مؤقت.

وتشمل أنشطة المستشفيات الرئيسية الأخرى التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار خلال مرحلة التعافي الآتي:

الدخول

- يجب ضمان الدخول إلى المباني والخروج منها بأمان للأشخاص وسيارات الإسعاف وتوصيل الإمدادات.

المباني

- قبل الاستخدام، يُعلن عن أن المباني أو أجزاء من المباني آمنة للاستخدام المقصود منها بواسطة الهيئات الحكومية/ التنظيمية المناسبة المسؤولة عن: مكافحة الحرائق (كود سلامة الأرواح)؛[1] والبيئة (جودة المياه والهواء)؛ والهندسة (السلامة الهيكلية والكهربائية، ونظام الغاز الطبي، وما إلى ذلك).
- توافر نظام وخدمات مكافحة الحرائق.
- توافر خطة مناسبة لمكافحة الآفات و/ أو احتوائها.
- وجود عدد كافٍ من الموظفين والموارد لصيانة المرافق (المباني ومعدات المرافق) المستخدمة حاليًّا.
- توافر نظم كافية للرقابة البيئية (إدارة النفايات، والضوضاء، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والسلامة الإشعاعية، والسلامة العامة للمباني، وجودة المياه، ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء).

نظام الكهرباء

- لوحة المفاتيح الرئيسية ومفاتيح التحويل الخاصة بالمرافق تعمل بصورة طبيعية.
- الصمامات وقواطع الدائرة تعمل بصورة طبيعية.
- جرى فحص المحولات.
- توافر مولدات الطوارئ والبطاريات الاحتياطية والوقود لوحدة الرعاية المركزة وغيرها من المناطق البالغة الأهمية. ووجود كمية كافية من الوقود في المولدات.
- جرى اختبار المعدات للتأكد من الجهد وشدة التيار (الأمبيرية).

1 كود سلامة الأرواح هو مجموعة من متطلبات الحماية من الحرائق المصممة لتوفير درجة معقولة من السلامة من الحرائق. ويغطي خصائص البناء والحماية والتشغيل المصممة لتوفير السلامة من الحرائق والدخان والذعر.

المرافق/ الشؤون الهندسية

- محطة التبريد تعمل بصورة طبيعية (وحدة التبريد/ نظام التمدد المباشر/ وحدة الامتصاص، المضخات، الصمامات وأجهزة التحكم، أبراج التبريد، وحدات لفائف المروحة).
- محطة التسخين تعمل بصورة طبيعية (نظام الغلايات؛ نظم الدعم [مضخات تغذية الماء، خزان الديزل، وما إلى ذلك]؛ نظام التسخين [المحولات، الصمامات، وما إلى ذلك]؛ البخار الصناعي المعالج [المعقمات، نظم المبنى العامة، وما إلى ذلك]؛ إعادة ملء خزان الوقود؛ توافر بائع الوقود).
- نظام التوزيع يعمل بصورة طبيعية (شبكة القنوات (مجاري الهواء)، ويشمل ذلك القدرة الوظيفية على الكشف عن الدخان/ الإنذار والمخمدات؛ والأنابيب؛ والصمامات ونظم التحكم، ويشمل ذلك الإغلاق الوظيفي للمروحة المتصلة بنظام إنذار الحريق في حالات الطوارئ، والقدرة على تطهير الدخان في حالات الطوارئ؛ وأنابيب التغذية الرأسية؛ والترشيح؛ والضغط السلبي [القدرة على الحفاظ على عمليات تبادل الهواء المتوافقة مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها]).
- توافر المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة (معالجة المياه، ومعالجة الغلايات).

نظام إدارة النفايات

- توافر نظام لمناولة النفايات (مثل، الناقلات، الضاغطات)، والإزالة (للنفايات الصلبة والسائلة).
- توافر نظام لتخزين النفايات الطبية والخطرة المُنظَّمة والتخلص منها.

نظام المياه

- تتوفر مياه صالحة للشرب لاستخدامها في الشرب والاستحمام والخدمات الغذائية وجميع خدمات المرضى المخطط لها.
- مضخات التوزيع تعمل بصورة طبيعية.
- أبراج/ خزانات المياه تعمل بصورة طبيعية.
- نُظُم المجاري تعمل بصورة طبيعية (الصرف الصحي، مياه الأمطار).
- نظام إخماد الحرائق يعمل بصورة طبيعية (مضخات الحرائق، وشبكة الأنابيب الرأسية والأفقية، والأنابيب الصاعدة (صناديق الحريق)، والقدرة على الكشف عن تدفق المياه/ الإنذار).

وإذا كان من الضروري إعادة بناء مستشفى على مدار فترة تعافٍ طويلة الأجل، فقد تغتنم المجتمعات المحلية الفرصة لإنشاء مرفق دائم صديق للبيئة يعالج مواطن الضعف السابقة. وقد حُددت نهوج للتعامل مع مواطن الضعف في المستشفى، وجعل المرفق والمجتمع المحلي أكثر استدامة وقدرة على الصمود، باستخدام مزيج من التدخلات الهيكلية وغير الهيكلية والوظيفية.

- **التقوية الهيكلية**، استخدام عناصر البناء (مثل الزجاج المقاوم للصدمات؛ وتدابير مقاومة المياه؛ وأنظمة الدعم للمرافق الحيوية مثل الكهرباء ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والسباكة) من شأنه أن يزيد من القدرة على الصمود.
- **التكيف المتنامي**، هو نهج يعالج أوجه الضعف التشغيلية التي يمكن أن تؤدي إلى خسارة الوظيفة. فعلى سبيل المثال، يمكن نقل النظم الحيوية إلى خارج القبو أو الطابق الأرضي في المناطق المعرضة للفيضانات. وفي بعض المستشفيات، تقع أقسام الطوارئ في الطابق الثاني، بينما تقع ساحة انتظار السيارات و/ أو المكاتب الإدارية في الطابق الأرضي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توفير نظم حيوية احتياطية (مثل مولدات الطاقة المتعددة في حالات الطوارئ).
- **إعادة البناء والتجديد** يوفران فرصًا لتحسين خصائص تصميم المرفق التي تؤثر على رعاية المرضى وتجاربهم (على سبيل المثال، تحديد موقع غرفة الطوارئ وغرف العمليات والأشعة بحيث تكون على مقربة من بعضها).
- **إعادة إنشاء عيادات الرعاية الأولية الأساسية**، وضمان التنسيق مع العناصر الأخرى للنظام الصحي.
- **اعتماد معايير وممارسات البناء** التي تكفل السلامة واستمرار الأداء الوظيفي في حالات الكوارث.
- **النظر في الفرص المتاحة** لتحسين استدامة مرافق الرعاية الصحية (مثل تقليل البصمة الكربونية، والحد من المياه العادمة).

الاستراتيجيات

3-1-2 استراتيجيات التعافي القصير الأمد

يكون التعافي القصير الأمد فوريًّا، ويتداخل مع الاستجابة. ويشمل التعافي القصير الأمد (بالنسبة لتقديم الخدمات الشاملة والمستمرة، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والترصد) عدة إجراءات مثل تقديم خدمات الصحة العامة والسلامة الأساسية، واستعادة خدمات المرافق والخدمات الأساسية الأخرى التي توقفت، وإعادة إنشاء طرق النقل، وتوفير الغذاء والمأوى للنازحين بسبب الحدث.

وينبغي أن يركز التعافي القصير الأمد أولًا على ضمان تلبية الاحتياجات الطبية الفورية للسكان. ويتطلب هذا في كثير من الأحيان الآتي:

- ضمان الوصول إلى مراكز الرعاية العاجلة والملاجئ، مع تقديم الدعم المناسب للأفراد المعرضين للخطر، ومنهم الفئات المستضعفة.
- توافر سلاسل إمداد فعالة لشراء الأدوية والإمدادات الطبية.
- تطبيق الاحتياطات النموذجية أثناء تقديم اللقاحات لكل من العاملين الصحيين والأفراد.
- رصد موظفي المستشفيات للكشف عن أي أعراض وأمراض، ووضع إجراءات التبليغ للمساعدة في الكشف المبكر عن الأمراض.

ومع استمرار التعافي القصير الأمد، يتحول التركيز إلى استعادة الخدمات الصحية الطارئة (للمرضى الداخليين والخارجيين)، وإعادة تقديم الرعاية الصحية الأولية. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للأشخاص المستضعفين طبيًّا، مثل أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة للأمراض المزمنة. وإذا لم تُستعد خدمات الرعاية الفورية على الفور، فقد تتفاقم القائمة الموجودة سلفًا، مما يؤدي إلى زيادة ثانوية مفاجئة في الإصابات الناجمة عن الكوارث.

3-1-3 تقييم الأضرار والخسائر

على الرغم من أن تقييم الأضرار والخسائر بعد الكوارث يتداخل بين مرحلتي الاستجابة والتعافي، فإنه ينبغي إجراء هذا التقييم على نطاق أوسع أثناء التعافي. وهو أمر بالغ الأهمية لتحديد أثر الكارثة على المستشفيات، وتوجيه جهود الاستجابة والتعافي على حد سواء. ويتضمن تقييم حجم الضرر الذي يلحق بمرافق المستشفيات والمعدات الطبية والإمدادات، فضلًا عن أثره على عمليات المستشفيات ورعاية المرضى. ويعرض تقرير التقييم هذا أيضًا تكلفة تقديرية لعمليات الإصلاح والاستبدال اللازمة لاستعادة الأداء الوظيفي للمستشفيات. وعلاوة على ذلك، فإنه يوفر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، وتخصيص الموارد، والتخطيط لاستعادة عمليات المستشفيات ورعاية المرضى.

وتشمل العملية المنهجية لإجراء تقييم للأضرار والخسائر الخطوات الآتية:

- **تحديد المناطق المتضررة:** تتمثل الخطوة الأولى في تحديد المناطق التي تضررت بالكارثة. ويشمل ذلك مرفق المستشفى، والمعدات الطبية، والإمدادات، فضلًا عن البنية الأساسية المحيطة والمجتمع المحلي.
- **التقييم السريع للاحتياجات:** يُجرى تقييم سريع للاحتياجات لتحديد الاحتياجات الفورية للمستشفى، مثل الإمدادات الطبية والمعدات والموظفين. وهذا التقييم بالغ الأهمية في تحديد الاستجابة الأولية للكارثة.
- **تقييم الأضرار:** بمجرد تلبية الاحتياجات الفورية، يُجرى تقييم مفصل للأضرار المادية التي لحقت بمرافق المستشفى (السلامة الهيكلية لمباني المستشفى)، والأداء الوظيفي للمعدات الطبية، وتوافر الإمدادات الأساسية. وتكتسي هذه المعلومات أهمية حاسمة في تحديد الموارد اللازمة للإصلاح والاستبدال.
- **تقييم الخسائر:** يساعد إجراء تقييم الخسائر في تحديد أثر الكارثة على عمليات المستشفى ورعاية المرضى والموظفين. ويتناول التقييم توقف الأداء الوظيفي بسبب الكارثة، ويشمل الأثر على عمليات المستشفى ورعاية المرضى، وعدد المرضى والموظفين المتضررين من الكارثة، فضلًا عن أثره على الشؤون المالية للمستشفى وسمعته.
- **التبليغ والتواصل:** تُبلَّغ إدارة المستشفى والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرون بنتائج التقييم. ويشمل ذلك التواصل بشأن حجم الأضرار والخسائر، وكذلك الاحتياجات الفورية والطويلة الأجل للمستشفى، مثل إصلاح البنية الأساسية، وتدريب الموظفين، وتدابير التأهب للكوارث.

4-1-3 مرافق الخَفْض التدريجي للرعاية

في أعقاب الكوارث، كثيرًا ما تمتلئ المستشفيات بالمرضى، الذين قد لا يحتاج الكثير منهم إلى مستوى متقدم من الرعاية التي يقدمها المستشفى. ويؤدي ذلك إلى حدوث اختناقات في نظام الرعاية الصحية، مما يؤخر علاج من هم في أمس الحاجة إليه. وحلًّا لهذه المسألة، يُستخدم مرفق الخفض التدريجي للرعاية لينقل إليه المرضى المستقرة حالتهم ولكنهم لا يزالون بحاجة إلى رعاية طبية خارج المستشفى والانتقال إلى بيئة أكثر راحة وأقل إجهادًا. ويؤدي ذلك إلى إخلاء أسرَّة المستشفيات، ويسمح للطاقم الطبي بالتركيز على الحالات الأكثر خطورة.

ويتطلب إنشاء مرافق الخفض التدريجي للرعاية تخطيطًا وتنسيقًا دقيقين لضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجون إليها. ومن الضروري وضع هذه المسائل في الاعتبار عند إنشاء مرفق الخفض التدريجي للرعاية:

- **الموقع:** ينبغي أن يقع المرفق في منطقة مأمونة يسهل على الموظفين والسكان المقيمين الوصول إليها - بالقرب من المستشفى أو المركز الطبي الذي يرتبط به. وهذا يساعد على ضمان إمكانية نقل المرضى بسهولة من المستشفى إلى مرفق الخفض التدريجي للرعاية.
- **التوظيف:** يجب تزويد المرفق بعددٍ كافٍ من الموظفين لكي يعمل بفعالية وكفاءة. ويشمل الموظفون: العاملين في المجال الطبي، وموظفي الأمن، والموظفين الإداريين، والمتطوعين.
- **المأوى:** يجب أن يوفر المرفق لمن يقيمون فيه مأوى آمنًا ومريحًا - سواء في شكل خيام أو مقطورات أو غيرهما من المنشآت المؤقتة المقاومة للطقس.
- **البروتوكولات والإجراءات:** يجب أن تكفل البروتوكولات والإجراءات نقل المرضى بأمان من المستشفى إلى مرفق الخفض التدريجي للرعاية. وكذلك يجب أن تكفل حصول المرضى على المستوى المناسب من الرعاية، وتقييم احتياجاتهم الطبية باستمرار.
- **الغذاء والماء:** ينبغي أن يكون لدى المرفق مصدرٌ موثوقٌ للغذاء والماء النظيف، إما من خلال شركات خدمات الأغذية أو من خلال تبرعات الشركات والمنظمات المحلية.
- **الإصحاح:** يجب أن تتوافر في المرفق مرافق ملائمة للإصحاح، وتشمل المراحيض والأدشاش وأماكن غسل اليدين. ومن شأن التنظيف والتطهير المنتظمين أن يحافظا على بيئة نظيفة وصحية.
- **الرعاية الطبية:** ينبغي أن يكون لدى المرفق ما يكفي من الإمدادات والموظفين لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية الأساسية. ويمكن أن يشمل ذلك خدمات الفرز، وتوزيع الأدوية، والإحالات إلى المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، حسب الحاجة.
- **الأمن:** تشمل التدابير الأمنية المناسبة لسلامة المرضى والموظفين ضمان أمن المرفق، وحماية المرضى من العدوى، وتوفير بيئة آمنة ومريحة.

5-1-3 خدمات إعادة التأهيل

تكتسي إعادة تأهيل المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات (ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات المستضعفة) أهميةً بالغة لعدة أسباب. فهي تساعدهم على استعادة الوظائف البدنية، والقدرة على الحركة، وتوفير التدبير العلاجي للحالات المزمنة، وتلبية احتياجات الصحة النفسية، والوقاية من المشكلات الصحية الثانوية. وتُعدُّ إعادة تأهيل المرضى عنصرًا أساسيًّا في مساعدة الأفراد على التعافي، وإعادة بناء حياتهم.

وقد تحد حالات الطوارئ والكوارث من قدرة مقدمي الرعاية وأماكن الرعاية، مثل دور الإقامة، على توفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتفاقم وضع الأطفال والمسنين ذوي الإعاقة أثناء حالات الطوارئ، عندما ينفصلون عن أسرهم وعن آليات الرعاية المجتمعية التقليدية.

وتتطلب إعادة التأهيل، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعةً من التدخلات. وينبغي تخصيص مساحة مناسبة (12 م^2 على الأقل) لخدمات إعادة التأهيل. وتشمل التدخلات الرئيسية الآتي:

- توفير أجهزة الحركة/ الأجهزة المساعدة: تمكّن معينات الحركة، مثل الكراسي المتحركة والعكازات وإطارات المشي، الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل، والمشاركة في الأنشطة اليومية.
- يُحسن العلاج الطبيعي القوة والمرونة والحركة، ويقلل الألم وعدم الراحة.
- يساعد العلاج المهني على تطوير المهارات والاستراتيجيات اللازمة لأداء الأنشطة اليومية، والمشاركة في أماكن العمل أو التعليم.
- يمكن أن توفر خدمات الأطراف الاصطناعية والتقويم أجهزة مصممة خصيصًا لاستبدال أو دعم الأطراف أو الأجزاء المفقودة أو الضعيفة من الجسم.
- تتيح البنية الأساسية المهيأة، مثل المنحدرات والمصاعد والمراحيض التي يسهل الوصول إليها واستخدامها، إمكانية دخول المباني والأماكن العامة.

ومن المرجَّح أن تواجه المجتمعات المحلية ذات الموارد المحدودة ونظم إعادة التأهيل غير المطورة بالقدر الكافي صعوبةً في تقديم هذه الخدمات في حالات الكوارث. ونتيجةً لذلك، قد تتعرض صحة الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستضعفة الأخرى ورفاههم لمزيد من الضرر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى تستمر لفترة طويلة بعد الكارثة الأولى.

النُّظم

6-1-3 إنهاء عمليات الاستجابة

لتسريع وتيرة التعافي دون ازدواجية في الجهود، ينبغي لعمليات الاستجابة للكوارث أن تعطي الأولوية للتواصل الدقيق في الوقت المناسب مع مديري الأقسام ومتخذي القرارات الرئيسيين وفرق الاستجابة للطوارئ، وأصحاب المصلحة، والبائعين والمتعاقدين، وعند الاقتضاء، مع الجمهور أيضًا. وبمجرد الانتهاء من الاستجابة، ستيسر المبادئ التوجيهية للتسريح العودة إلى ظروف التشغيل العادية بمزيد من التنظيم والتعجيل.

ويتطلب التخطيط للتسريح والتعافي بعد وقوع الحدث فهمًا مشتركًا لعناصر التعافي والعمليات المرتبطة بالاستعادة المتأنية للموقع وتعزيزه وتفعيله، إضافةً إلى البنية الأساسية المحيطة به والعمليات.

ومن شأن عملية التسريح المتمثلة في وقف موارد الاستجابة على نحو يتسم بالكفاءة وحسن التوقيت أن تحقق فوائد كبيرة من حيث التكلفة. وينبغي النظر في المسائل الآتية لبدء عملية التسريح:

- تحديد العوامل المحفزة للشروع في عملية التسريح (ستختلف من حالة طوارئ إلى أخرى). على سبيل المثال، يمكن أن تستند العوامل المحفزة إلى معلومات من السلطات المحلية (مثل أن جميع المرضى قد نُقلوا إلى المستشفى؛ أو أن جميع المرضى قد عُولجوا في وحدة الطوارئ، ونُقلوا إلى الجناح؛ أو أنهم ينتظرون إحالتهم إلى مرفق آخر).
- تحديد الموارد الفائضة والتواريخ المحتملة للإفراج عنها. وعلى قائد الحدث في المستشفى أن يوافق على الإفراج عن موارد الاستجابة أو تسريحها قبل بدء العملية.
- تحديد احتياجات سفر الموظفين، وتنسيق ترتيبات السفر، حسب الضرورة.
- تقليص العمليات في مركز عمليات الطوارئ بالمستشفى، وإيقاف عمل المرفق في نهاية المطاف، وإعادة المساحة إلى استخدامها الأصلي.
- التحقق من توفر إجراءات إزالة التلوث والموارد اللازمة.
- إذا لزم الأمر، تُوضع خطة/ يُبلغ بخطة للتخلص من المواد أو النفايات الخطرة.
- يُخطط لإصلاح المعدات، وإزالة التلوث منها، وصيانتها، ومعاينتها، حسب الاقتضاء.
- تُجمع الوثائق المرتبطة بالاستجابة (مثل خطة عمل الأحداث، وسجلات الاتصالات، وأوراق عمل الوظائف، وتقارير الحالة) استعدادًا لعملية الاستعراض اللاحق للإجراءات.
- بدء تقييمات الأثر واستعراضات ما بعد الحدث.

7-1-3 تكنولوجيا المعلومات ونُظُم معلومات المستشفيات

لا يمكن التأكيد بما يكفي على أهمية وجود نظم قوية لتكنولوجيا المعلومات والسجلات الطبية أثناء عمليات الاستجابة للكوارث والتعافي. فهي تتيح تتبع المرضى بفعالية، وتحليل البيانات، وإدارة الموارد، والتنسيق والتواصل، واستمرارية الرعاية. وخلال هذه العمليات، يجب على المستشفيات التأكد من قدرتها على استرجاع السجلات الطبية الموجودة أو إنشاء سجلات طبية جديدة. وينطبق هذا بوجه خاص على الحالات التي يكون فيها المستشفى قد تضرر أو لا يستطيع العمل. وينبغي وضع النقاط الآتية في الاعتبار:

- التأكد من أن جميع النُّظُم الداخلية والخارجية (النُّظُم الاحتياطية، والنُّظُم السريرية، ونُظُم المعلومات الطبية، ونُظُم تسجيل المرضى) تعمل، وأن هناك وسائل بديلة لتسجيل معلومات المرضى، إذا لزم الأمر.

- توافر مساحة تخزين فعلية كافية لضمان أمن وسلامة السجلات الطبية (على سبيل المثال، حماية السجلات من الحرائق والمخاطر البيئية والوصول غير المصرح به إليها)، أو توافر مساحة كافية للتخزين السحابي.
- توافر نظم لضمان إمكانية الوصول إلى السجلات الطبية، وإمكانية استرجاعها بسرعة عند الحاجة.

8-1-3 التخطيط للتعافي بعد الكوارث

إن التخطيط للتعافي بعد الكوارث لا يقل أهمية عن التخطيط للاستجابة. ومن الناحية المثالية، يمكن وضع خطط التعافي قبل وقوع الكارثة والشروع في تنفيذها، بينما لا تزال الاستجابة مستمرة. وهذا من شأنه أن يسمح للمستشفيات بمواصلة تقديم الرعاية، والحفاظ على الجدوى المالية. وقد تكون عودة المستشفى إلى العمليات اليومية تدريجية. وينبغي أن يأخذ التخطيط في الاعتبار أن النظم التي عُززت لتلبية الزيادة المفاجئة في الاحتياجات الطبية ستُفكك حسب ما تقتضيه احتياجات المرضى. وستعود المعدات والإمدادات والأدوية الزائدة عن الحاجة إلى مستويات المخزون السابقة لوقوع الحدث حالما يكون ذلك معقولًا.

وقد تأخذ المستشفيات بعين الاعتبار التوصيات الآتية لتخطيط أنشطة التعافي:

- تعيين مدير مسؤول عن التعافي من الكوارث ليكون بمثابة حلقة وصل لبرنامج التعافي من الكوارث.
- وضع خطة عمل للتعافي تتضمن الأطر الزمنية والبائعين الذين سيجري العمل معهم، مع تحديد المناطق التي تحتاج إلى إعادة بناء، وإعادة تنظيم واستعادة الأداء الوظيفي الكامل بها.
- إجراء تحليل مردودية التكاليف فيما يتعلق بالتعافي (مثل التوظيف والإمدادات والتخزين المؤقت)، ويشمل ذلك استعادة النظم التي تتوفر فيها احتياطيات. وإدراج جدول زمني تقديري لموعد الانتهاء.
- تجميع كل المعلومات بشأن الأضرار التي لحقت بالمنشأة.
- التشاور مع موظفي المستشفى بشأن خطة التعافي، واغتنام هذه الفرصة لإعادة البناء على نحو أفضل لتحسين قدرة المستشفى على الصمود.
- منح الأولوية لأهداف التعافي المرتبطة بتقديم خدمات الرعاية الصحية حسب الوظائف الأساسية.
- الحفاظ على القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وتعديلها و/أو تسريحها وفقًا لاحتياجات المنشأة.
- العمل مع إدارة الطوارئ المحلية، وسلطات الصحة العامة، ومقدمي الخدمات، والمتعاقدين لضمان إعطاء الأولوية لاستعادة وإعادة بناء النظم الحيوية بالمبنى، وقدرات النقل، ونظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتُعدُّ عملية التعافي في جوهرها شَرَاكة بين المجتمع المحلي المتضرر والحكومة ومنظمات المعونة والقطاع الخاص. وعليه، فإن التعافي الناجح يقوم على التواصل الفعال فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. ويساعد هذا بدوره على إدارة التوقعات بشأن ما يمكن للمستشفى تنفيذه وما لا يمكنه تنفيذه؛ ومَن هو المسؤول داخل منظومة المستشفى عن قيادة جهود التعافي؛ وما الذي يمكن أن تتوقعه المجتمعات المحلية من حيث المساعدة في التعافي.

الإطار 13. المشاركة المجتمعية والتواصل أثناء التعافي

المشاركة المجتمعية والتواصل أثناء التعافي

خلال فترة التعافي، كثيرًا ما تغرق المجتمعات المتضررة في كم هائل من المعلومات - في وقت تعافي فيه من الضغط، وتكون غالبًا غير قادرة على معالجة المعلومات. ويمكن للمسؤولين المحليين تحديد أولويات المعلومات الأكثر صلة بتعافي المجتمع، مثل:

- ما تطورات عملية التعافي؟
- ما الدعم المتاح؟
- كيف يمكن لأفراد المجتمع التأهل لاستحقاق هذا الدعم أو الحصول عليه؟
- ماذا يمكنهم أن يفعلوا إذا كانت لديهم أسئلة أو مخاوف أو شكاوى؟

مِن الضروري الاعتراف بأثر الكارثة على رفاه الإنسان من خلال الإقرار بتجارب الناس. وينبغي تعقب ودحض الشائعات والمعلومات الكاذبة التي قد تسبب انقسامًا وصراعًا في المجتمع. ومن المهم التركيز على توفير المعلومات التي تساعد الأفراد والمجتمعات المحلية على اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم، ودعم تعافيهم الذاتي.

المواد

خلال فترة التعافي القصير الأمد، قد لا يكون من الممكن توفير الرعاية على المستوى نفسه الذي كان متاحًا من قبل. ومع ذلك، فمن الواجب الأخلاقي والقانوني توفير مستوى ما من الرعاية. ولذلك، يجب تخصيص الموارد على النحو المناسب، ويجب على المستشفيات الحفاظ على بعض الإمدادات وتكييفها و/ أو استبدالها لضمان تقديم رعاية مكافئة وظيفيًّا أو رعاية أثناء الأزمات، حسب الوضع.

9-1-3 تحديث المخزون، وإعادة التزويد بالإمدادات، وإصلاح المُعَدَّات

ينبغي أن يؤخذ الآتي بعين الاعتبار أثناء فترة التعافي:

- يجب أن تكون الموافقة على إعادة استخدام المعدات والإمدادات الموجودة داخل المباني المتضررة، سواء كانت مغمورة تحت الماء، أو تعرضت لدرجات حرارة قصوى، أو للدخان والأبخرة وما إلى ذلك، صادرة عن وكالة حكومية مختصة. ومن الضروري الاحتفاظ بسجلات المعدات المُوافَق على استخدامها.
- يجب أن تكون المستشفيات قادرة على الاحتفاظ بالمعدات المستخدمة لرعاية المرضى.
- يجب أن تتوافر معدات وإمدادات كافية في الموقع (ويشمل ذلك الأكسجين) للخدمات المُخطَّط لها.
- إتاحة المستحضرات الصيدلانية وتوافرها، ومنها الأدوية المؤثرة على العقل؛ والمعدات الطبية الحيوية لذوي الاحتياجات الطبية الخاصة؛ والتبريد السليم لتخزين الأدوية والمستحضرات البيولوجية.
- توافر آلية معمول بها لتجديد الإمدادات.
- توافر كشافات الإضاءة والبطاريات (ومنها بطاريات أجهزة اللاسلكي وأجهزة التهوية).

10-1-3 تخفيف التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعافي

أثناء التعافي، ترتبط التكاليف المباشرة عادةً بأقسام المستشفى أو المرضى. وعلى الجانب الآخر، قد تشمل التكاليف غير المباشرة عدة مجالات مثل التكاليف العامة للمستشفيات وتكاليف المرافق والشؤون الإدارية أو النفقات المشتركة. ويمكن أن تنظر المستشفيات في التدابير الآتية للحد من التكاليف المالية أثناء التعافي:

- جمع الوثائق اللازمة لتجهيز مطالبات التأمين من أجل إعادة تأهيل أو إعادة بناء المرافق المتضررة (مثل الإيصالات، وتقارير تقييم الأضرار، ووثائق التأمين).
- التحقق من ضمانات المعدات لأغراض الدعم وخدمات ما بعد البيع للتوفير في تكلفة الإصلاحات وإعادة التأهيل.
- تزويد الموظفين بالوثائق اللازمة لتيسير مطالبات الضمان الاجتماعي أو الاستحقاقات أو القروض. والنظر، أثناء عملية التعافي، في تقديم مساعدات مالية إلى موظفي المستشفى، مثل القروض أو سُلَف المرتبات.
- تحديد وإعداد الوثائق اللازمة لدعم المساعدات المالية المُقدَّمة في مرحلة ما بعد الكوارث من الحكومة أو المنح المقدمة من المانحين والشركاء الثنائيين أو المتعددي الأطراف.
- الاحتفاظ بسجلات المرضى وتحديثها، وتكييفها مع متطلبات برنامج التعافي من الكوارث (في حالة الانطباق). ويجب أيضًا معالجة مسائل استمرارية المرتبات، وتمويل سلسلة الإمداد، والخسائر التي يغطيها التأمين وتقديم المطالبات، وأي مسائل قانونية قد تنشأ.

- العمل مع الشركاء من القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والحكومة لتحديد فرص «النقد مقابل العمل» لموظفي المستشفيات المتضررين.
- تقديم حوافز مالية مثل أجور العمل الإضافي للموظفين الذين يعملون لساعات طويلة أثناء الاستجابة/التعافي.

الموظفون

11-1-3 الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي

يمكن أن يكون للكوارث أثرٌ كبيرٌ على الصحة النفسية والرفاه النفسي الاجتماعي لموظفي المستشفيات، الذين قد يعانون من الإجهاد والقلق والإنهاك نتيجة عملهم أثناء حالة الطوارئ. ويتطلب تقديم الدعم لموظفي المستشفيات في مرحلة التعافي اتباع نهج شامل ومتكامل لتلبية احتياجاتهم الخاصة، والتعامل مع التحديات الفريدة التي يواجهونها. ويجب النظر بعين الاعتبار في التدخلات الآتية لدعم الصحة النفسية للموظفين ورفاههم، وتعزيز ثقافة القدرة على الصمود والتعافي:

- **الإسعافات الأولية النفسية** هي نهج مسترشد بالبيّنات يساعد الناس على التأقلم مع العواقب المباشرة للكوارث. ويمكن للمهنيين المدرَّبين أو غير المدرَّبين تقديم الإسعافات الأولية النفسية بهدف تقديم الدعم العملي والوجداني للمتضررين.
- **تحري حالة الصحة النفسية** يساعد في تحديد موظفي المستشفى الذين قد يعانون من مشكلات في الصحة النفسية، ويحتاجون إلى دعم إضافي وربطهم بالموارد المناسبة.
- **برامج مساعدة الموظفين** تقدم خدمات استشارية سرية لموظفي المستشفى. ويمكن أن تساعد هذه البرامج الموظفين على التأقلم مع الإجهاد والقلق ومشكلات الصحة النفسية الأخرى.
- **برامج دعم الأقران** تسمح لموظفي المستشفى بتقديم الدعم الوجداني لبعضهم. ويمكن أن يكون دعم الأقران فعالًا بوجه خاص في الحد من الوصم، وتوفير مساحة آمنة للموظفين لمناقشة تجاربهم.
- **التدريب والتعليم** بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لموظفي المستشفيات يمكن أن يشمل التدبير العلاجي للإجهاد، ومهارات التأقلم، واستراتيجيات التواصل.
- **برامج بناء القدرة على الصمود** تساعد موظفي المستشفيات على تطوير المهارات والاستراتيجيات اللازمة للتأقلم مع الإجهاد والشدائد. ويمكن أن تشمل هذه البرامج ممارسة اليقظة الذهنية والتأمل واليوغا.
- **التوازن بين العمل والحياة** هو أمر ينبغي تشجيعه لأنه يساعد موظفي المستشفى على التعامل مع الإجهاد والوقاية من الإنهاك. ويمكن أن يشمل ذلك جداول عمل مرنة، وإجازات، وإمكانية الحصول على خدمات رعاية الأطفال وغيرها من خدمات الدعم.

12-1-3 الحوافز المالية وغير المالية

يمكن للحوافز المالية وغير المالية أن تكون تقديرًا لموظفي المستشفيات ومكافأة لهم على عملهم أثناء الاستجابة للكوارث/ التعافي منها. ويمكن للحوافز أن ترفع معنويات الموظفين، وتزيد التحفيز، وتعزز ثقافة القدرة على الصمود والتعافي. وتشمل الحوافز المحتملة الآتي:

الجدول 4. الحوافز المالية مقابل الحوافز غير المالية

الحوافز المالية	الحوافز غير المالية
• تقديم **أجر إضافي** لموظفي المستشفى (أجر العمل الإضافي أو بدل المخاطر) مقابل عملهم أثناء الاستجابة/ التعافي. • تقديم **مكافآت الأداء** لموظفي المستشفى الذين يُظهرون أداءً استثنائيًا أثناء الاستجابة/ التعافي. • تقديم **مِنَح مالية أو منح دراسية** لموظفي المستشفى الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم، أو التدريب على الاستجابة للكوارث أو المجالات ذات الصلة. • **رد النفقات** التي يتكبدها موظفو المستشفى أثناء الاستجابة/ التعافي من الكوارث، مثل المواصلات أو الإقامة.	• **التقدير المعلن** لموظفي المستشفى على الجهود التي يبذلونها، من خلال النشرات الصحفية أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات المماثلة. • منح موظفي المستشفى **إجازة** إضافية بعد انتهاء الاستجابة/ التعافي. • توفير **فرص التطوير المهني** لموظفي المستشفيات، مثل المؤتمرات أو البرامج التدريبية المعنية بالكوارث والطوارئ. • تشجيع **تقدير الزملاء** من خلال جعل موظفي المستشفيات يرشحون زملاءهم لمساهماتهم أثناء الاستجابة للكوارث/ التعافي منها.

13-1-3 تسريح الموظفين والمتطوعين

عندما يتضرر مرفق صحي في أعقاب كارثة، قد يجد موظفو المستشفى أنفسهم مضطرين للنزوح مؤقتًا. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تشهد المرافق الصحية الأخرى التي تواصل عملها زيادة مفاجئة في الطلب على الرعاية الصحية بسبب انخفاض القدرات على مستوى المنطقة. وبالنظر إلى أن استبقاء القوى العاملة أمر بالغ الأهمية لضمان توافر العمال المهرة بمجرد تشغيل المرفق المتضرر مرة أخرى بكامل طاقته، فإن النقل المؤقت للموظفين الطبيين النازحين إلى المرافق التي لا تزال تعمل يمكن أن يقلل من خطر فقدان الموظفين.

وتتطلب عملية تسريح الموظفين الفعالة التأني في التخطيط المسبق والتنسيق والتواصل. ويمكن للإجراءات الآتية أن تساعد على ضمان سلامة هذه العملية وفعاليتها.

- وضع وتنفيذ خطة للتسريح تتضمن خطوات وجدولًا زمنيًا. وتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لموظفي المستشفيات والمتطوعين أثناء العملية. ويمكن أن يشمل ذلك مهام مثل تعبئة و/ أو إعادة المعدات والإمدادات أو تنظيف مرفق المستشفى.
- استخلاص المعلومات من موظفي المستشفى والمتطوعين حول تجاربهم والدروس المستفادة. ويمكن استخدام هذه المعلومات الارتجاعية في تحسين جهود الاستجابة للكوارث في المستقبل. وخلال جلسة استخلاص المعلومات، ينبغي الوقوف على العلامات والأعراض التي تتطلب الرصد، وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها إذا تعرَّض الموظفون لآثار صحية ضارة.

- المشاركة في عملية فحص العافية، ورصد الاحتياجات الصحية السلوكية للقوى العاملة الطبية.
  - ◊ يجب رصد حالات تغيب الموظفين أو استقالتهم أثناء الحدث أو بعده، نتيجة الإجهاد.
  - ◊ يجب استكمال نماذج الترصد الطبي للموظفين، والتي يمكن أن تصبح جزءًا من سجلاتهم الصحية.
- ضمان سلامة وأمن موظفي المستشفى والمتطوعين أثناء عملية التسريح من خلال توفير معدات الوقاية الشخصية، وضمان توافر إضاءة كافية في مبنى المستشفى، وتواجد أفراد الأمن في الموقع.
- تقديم الدعم الصحي النفسي إلى موظفي المستشفى والمتطوعين أثناء عملية التسريح وبعدها. ويمكن أن يشمل ذلك خدمات المشورة، ومجموعات دعم الأقران، وغيرهما من الموارد للمساعدة في معالجة الإجهاد والصدمات (انظر3-1-12).

2-3 الاستعراض اللاحق للإجراءات وعملية استخلاص الدروس المستفادة

يهدف **إعادة البناء على نحو أفضل** إلى الاستفادة من مراحل التعافي، وإعادة التأهيل، وإعادة الإعمار بعد الكوارث لزيادة قدرة المستشفيات على الصمود. ويتطلب إعادة البناء على نحو أفضل إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في إصلاح البنية الأساسية المادية والنظم، وفي إنعاش سبل العيش والاقتصادات والبيئة، مما يعزز التنمية المستدامة.

وخلال مرحلة التعافي، يُنظر في الإجراءات الآتية لتعزيز الاستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود:

- استخدام التدخلات الهندسية لإعادة بناء المرافق المتضررة وتعزيزها (مقارنة بمستواها قبل وقوع الكارثة).
- الاستفادة من فرص التعافي في إنشاء نُظُم احتياطية، لا سيما شرايين الحياة الحيوية في المستشفيات، باستخدام التكنولوجيا الخضراء.
- تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لتيسير تبادل التعلم والمعرفة.
- تحديث سياسات المستشفيات ومبادئها التوجيهية وإجراءاتها، وتشمل الممارسات المستخدمة في العمليات الروتينية، استنادًا إلى ما تم تعلمه من الكارثة (ومن التأهب السابق لحالة الطوارئ) لتعزيز الاستعداد للاستجابة في المستقبل.
- دعم التعافي النفسي الاجتماعي لتعزيز الصحة النفسية للموظفين.
- استعراض وتكييف المشاريع والاستثمارات الإنمائية لمراعاة المخاطر المحتملة، استنادًا إلى الخبرة السابقة.

استخلاص الدروس المستفادة عقب الاستجابة لأي حالة طوارئ أمرٌ ضروري لجميع إجراءات إدارة الطوارئ. وتسهم هذه التمارين في تحسين الجودة، وتعزيز نظم التأهب والاستجابة. بالإضافة إلى ذلك، يسهم التعلم المنهجي بعد الحدث في ثقافة التحسين المستمر، ويمكن أن يكون وسيلة لتبادل الحلول المبتكرة للتصدي لمخاطر الكوارث المستجدة. وهذا من شأنه أن يسهم في تعزيز التعلم التنظيمي، وإذا ما أضفي الطابع المؤسسي عليه، فإنه سيحوِّل المستشفى إلى مؤسسة تعليمية.

الاستعراض اللاحق للإجراءات هو استعراض نوعي للإجراءات المتخذة للوقوف على أفضل الممارسات والثغرات والدروس المستفادة أثناء الاستجابة لحالة الطوارئ. ويقدم الاستعراض اللاحق للإجراءات نهجًا منظمًا للأفراد والمؤسسات، ومنها المستشفيات، لتدبر تجاربها وتصوراتها حول الاستجابة. وهذا سيُمكِّن المستشفى من تحديد ما نجح، وما لم ينجح، ولماذا، بطريقة منهجية وجماعية، ومن ثم تحديد طرق تحسين الاستجابة التالية. ويمكن أن يتراوح الاستعراض اللاحق للإجراءات بين جلسات غير رسمية سريعة لاستخلاص المعلومات مع أعضاء الفريق وحلقات عمل موسعة يقودها ميسرون بمشاركة واسعة ومتعددة القطاعات. والاستعراض اللاحق للإجراءات ليس تقييمًا خارجيًا لأداء الأفراد أو الفريق. وهو لا يسعى إلى قياس الأداء على أساس معايير مرجعية أو معايير أداء حاسمة. ومع ذلك، فهو فرصة جماعية بناءة للتعلم إذ يمكن لأصحاب المصلحة المعنيين المشاركين في التأهب للطوارئ والاستجابة لها إيجاد أرضية مشتركة لتحسين القدرات.

وخلال عمليات الاستجابة الممتدة (مثل جائحة كوفيد-19)، يمكن إجراء استعراضات مرحلية للإجراءات لتعديل إدارة الطوارئ والكوارث وتحسينها. وكما هو الحال مع الاستعراضات المرحلية للإجراءات، يمكن أن تكون هذه الاستعراضات في شكل جلسات استخلاص المعلومات، وتناقش «ما الأمور التي سارت على ما يرام؟ وما الذي يحتاج إلى تحسين؟» فيما يتعلق بإدارة الحدث. ويمكن إجراء مراجعات مرحلية للإجراءات على مستوى أقسام المستشفى أو مع فريق إدارة الأحداث بالمستشفى.

وفور عودة المستشفى إلى العمليات الصحية الروتينية، وإيقاف خطة الاستجابة للطوارئ، يمكن لفريق إدارة الأحداث بالمستشفى أن يخطط لإجراء استعراض لاحق للإجراءات بشأن عمليات الاستجابة التي ينفذها المستشفى بالكامل. ويساعد هذا التمرين في وضع خطط عمل تصحيحية لتحسين النظم والخطط والترتيبات، استعدادًا للاستجابة لاحقًا للطوارئ.

1-2-3 جمع المعلومات الأساسية ذات الصلة ومراجعتها

يتولى الفريق المعني بالاستعراض اللاحق للإجراءات جمع المعلومات الأساسية، ومراجعتها لفهم إجراءات الاستجابة التي اتُّخِذَت. ويوفر ذلك إطارًا مشتركًا للمناقشة. ويمكن أن تشمل المعلومات الأساسية الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ، والخطط الاحترازية، وهيكل إدارة الأحداث. ويمكن أن تشمل أيضًا الوثائق التي يُجرى إعدادها أثناء الاستجابة، مثل خطط الاستجابة، وتقارير الحالة، والاستعراضات التشغيلية وتقييمات الاستجابة، والتقارير الإعلامية، ومذكرات استخلاص المعلومات، وما إلى ذلك.

2-2-3 وضع أسئلة مُحفزة

إن الاستعراض اللاحق للإجراءات هو «اكتشاف» للأحداث التي وقعت، من خلال عدسة الأشخاص الذين أدوا دورًا، ويُسترشَد فيه من تجاربهم. وبالتزامن مع الاستعراض اللاحق للإجراءات، تُستخدم الأسئلة المُحفزة لتوجيه المناقشات الجماعية أو الفردية، مما يدفع المجموعة إلى التفكير بطريقة مبتكرة، وتوليد أفكار جديدة. ومن شأن الأسئلة ذات النهايات المفتوحة أن تساعد على توليد المناقشات، وتأطير نطاق التحليل. وينبغي تكييف الأسئلة المُحفزة مع السياق والحصائل المتوقعة لكل وظيفة. ويجيب الاستعراض اللاحق للإجراءات عن أربعة أسئلة مهمة:

- ماذا كان من المتوقع أن يحدث؟
- ماذا حدث بالفعل؟
- ماذا سار على ما يرام؟ ولماذا؟
- ما الذي يمكن تحسينه؟ وكيف؟

وقد يعرف الموظفون المشاركون في العمليات، مجتمعين، ما حدث، ولكنهم قد لا يعرفونه بشكل فردي. فيكون الاستعراض الذي يقوده الميسر من أفضل الطرق لإعادة تشكيل ما حدث. وعلى الميسر أن يسرد أحداث اليوم، ويطرح أسئلة تحثّ الناس، وتشجعهم على إكمال الأجزاء الناقصة. وفي المواقف التي كان فيها الميسر مراقبًا رئيسيًّا للأحداث وصانعًا للقرار، عليه أن يساعد المشاركين على إكمال الأجزاء الناقصة من خلال رؤيته وخبراته. وعليه أن يضيف السياق والمنظور عند الاقتضاء لجعل الوضع أكثر وضوحًا.

3-2-3 تحديد مواطن القوة والتحديات والقدرات

أثناء الاستعراض اللاحق للإجراءات، سيحدد المشاركون أكبر عدد ممكن من مواطن القوة والتحديات التي واجهوها أثناء الاستجابة. ومن المتوقع الوصول إلى المُخرَجات الآتية في نهاية الاستعراض اللاحق للإجراءات:

- توضيح أفضل الممارسات وآثارها على الاستجابة، باستخدام تحليل الأسباب الجذرية[1] لتحديد العوامل التي مكَّنت من تطبيق أفضل الممارسات.
- توضيح التحديات التي تمت مواجهتها أثناء الاستجابة وآثارها، باستخدام تحليل الأسباب الجذرية لتحديد العوامل المقيِّدة التي أسهمت في التحديات.
- بالنظر إلى فهم أفضل الممارسات والتحديات، تحديد الإجراءات الواضحة اللازمة لإدماج أفضل الممارسات، والتصدي للتحديات، وتعزيز التأهب للاستجابات المستقبلية.
- باستخدام الإجراءات المذكورة أعلاه، يتوسع في إعداد أنشطة صريحة، ويُحدد مسؤولو التنسيق المعنيون، والموارد المطلوبة، والجداول الزمنية للتنفيذ.

1 تحليل الأسباب الجذرية هو عملية جماعية منظمة وميسرة لتحديد الأسباب الجذرية لحدث ما أدى إلى نتيجة معينة، ووضع إجراءات تصحيحية، إذا لزم الأمر.

4-2-3 التوصل إلى توافق في الآراء بين المشاركين

يتألف التوافق في الآراء من ملخص نهائي لأفضل الممارسات، والتحديات، والقدرات الجديدة التي طُورت، ومؤشرات الاستعراض اللاحق للإجراءات. ويمكن التوصل إلى توافق في الآراء من خلال جلسات عامة أو مناقشات جماعية. وينبغي أن تؤيد هذه المناقشات صحة النتائج، وأن تخلق شعورًا بالملكية لضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية. وقبل الختام، تُعقد جلسة ختامية للفريق العامل لإدراج أي إضافات أو تعليقات.

5-2-3 استخلاص المعلومات من فريق الاستعراض اللاحق للإجراءات

يهدف استخلاص المعلومات من فريق الاستعراض اللاحق للإجراءات إلى النظر في التخطيط العام للاستعراض اللاحق للإجراءات وإعداده وتنفيذه. ويمكن أن يحدد استخلاص المعلومات أيضًا الأدوار والمسؤوليات والجداول الزمنية لاستكمال تقارير الاستعراض اللاحق للإجراءات وغيرها من المنجزات المستهدفة. وينبغي أن يحدث ذلك في غضون أسبوع واحد من استكمال الاستعراض اللاحق للإجراءات.

ويمكن لاستخلاص المعلومات من فريق الاستعراض اللاحق للإجراءات أن يؤطر مناقشة حول كيفية تحسين عملية الاستعراض للحدث التالي، مع الأخذ في الاعتبار أن المرونة في تنفيذ هذا الاستعراض تسمح للقائمين على التخطيط بالتعديل، وإيجاد أفضل نموذج للثقافة والنظام قيد الاستعراض. وهذه فرصة أيضًا لفريق الاستعراض لمناقشة الملخص التنفيذي الذي يُرفع إلى الإدارة العليا، ووضعه في صيغته النهائية.

6-2-3 استخلاص المعلومات من إدارة المستشفيات

ينبغي إحاطة الإدارة العُليا بنتائج الاستعراض اللاحق للإجراءات، وتشمل أفضل الممارسات والتحديات المحددة وإجراءات المتابعة المتفق عليها. ويتمثل أحد أهداف عملية استخلاص المعلومات في الحصول على الدعم لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ الإجراءات المحددة. كما أن تأييد الإدارة العليا لنتائج الاستعراض اللاحق للإجراءات يزيد من احتمال التعلم وأثره على مستوى مؤسسي أوسع، ويسهم في ثقافة التحسين المستمر والتحليل النقدي. وقد تأذن الإدارة العليا أيضًا بتعميم النتائج العامة على نطاق أوسع.

7-2-3 كتابة تقرير الاستعراض اللاحق للإجراءات

تكون مُخرَجات الاستعراض اللاحق للإجراءات في صورة تقرير مكتوب يقدم توصيات استنادًا إلى المعلومات التي جُمعت أثناء الحدث. وينبغي أن يُتاح لمؤلف (مؤلفي) التقرير الاطلاع على جميع الملاحظات المدوَّنة من أجل إدماج النتائج في التقرير النهائي. وعلى التقرير أن يتضمن خطط العمل التصحيحية، التي تحددت أثناء الاستعراض اللاحق للإجراءات، من أجل اتخاذ إجراءات المتابعة.

ومن المهم ملاحظة أن التوصيات الناتجة عن حدث واحد ليست بالضرورة مناسبة لجميع الحالات. ولذلك، يجب النظر بعناية في أي توصية صادرة عن أحد الأحداث قبل تنفيذ تلك التوصية نفسها في سيناريو لاحق. وتتيح متابعة ما بعد الاستعراض اللاحق للإجراءات فرصة للاطلاع على كيفية تحسين تنفيذ خطط العمل التصحيحية المنبثقة عن الاستعراض لقدرات إدارة الطوارئ وعمليات الاستجابة في المستقبل وتوثيق هذه الطريقة.

8-2-3 عملية استخلاص الدروس

سيكون هناك عدد، إن لم يكن الكثير، من التوصيات بشأن الإجراءات و/ أو التحسين في المستقبل. وقد يُطلِق البعض على هذه التوصيات اسم الدروس المستفادة. ومع ذلك، إذا استمرت هذه التوصيات نفسها في الظهور في تمارين لاحقة أو في الاستجابات الفعلية لحالات الطوارئ، فستكون الدروس ببساطة قد حُددت بدلًا من أن تكون قد استُخلصت. وهناك حاجة إلى عملية أكثر شمولًا لاستخلاص الدروس، وإدماجها في التغيير التنظيمي.

ويكون التقييم هو حصيلة عملية الاستعراض. ويشمل تحديد الأهداف، والمراقبة، والمراجعة الفورية اللاحقة،[1] وإعداد التقارير اللاحقة للإجراءات، وبرنامج الإجراءات التصحيحية، والتحقق من صحة البيانات. ويُطلق على هذه العملية عادةً «الدروس المستفادة».

وينبغي أن تنظر المستشفيات في إنشاء مستودع يضم التحديات الحرجة، وأفضل الممارسات، والتوصيات الناتجة عن الاستعراضات اللاحقة للإجراءات، ويمكن الوصول إليه بسهولة أثناء التأهُّب لحالات الطوارئ والاستجابة لها. ويمثل هذا المستودع ذاكرة مؤسسية للدروس المستفادة، ويوفر موردًا لأصحاب المصلحة المعنيين بالتأهب للطوارئ والاستجابة لها. ويتمثل هدفه في تيسير التعلم وتبادله بين حالات الطوارئ وتطبيق النتائج على سياقات وأحداث أخرى. ويساعد تسجيل الدروس المستفادة في موقع مركزي على ضمان عدم تكرار الأخطاء نفسها.

1 المراجعة الفورية اللاحقة هي عملية استخلاص معلومات تُجرى مباشرة بعد التمرين مع الموظفين والمشاركين.



نظام كهربائي احتياطي. المستشفى العام للمنطقة (1)، المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي، تاباتشولا، تشياباس، المكسيك. مركز (MEX-35) المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن الخدمات الصحية القادرة على الصمود، 2023.

3-3 أدوات التعافي وموارده

- منظمة الصحة العالمية. إرشادات بشأن الاستعراض اللاحق للإجراءات. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3HGTWaP.
- منظمة الصحة العالمية. منصة الاستعراض اللاحق للإجراءات: الإرشادات والدورات التدريبية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2024 [تاريخ الاستشهاد: 19 آذار/ مارس 2024]. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/48YB57a.
- منظمة الصحة العالمية. منصة الاستعراض المرحلي للإجراءات: الإرشادات والدورات التدريبية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2024 [تاريخ الاستشهاد: 19 آذار/ مارس 2024]. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3SlwbtT.
- مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط. دليل تنفيذي بشأن تعافي النُّظُم الصحية في حالات الطوارئ: تحويل التحديات إلى فرص. القاهرة: المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ 2020. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3w6PKi2.
- منظمة الصحة العالمية. مجموعة أدوات التعافي: دعم البلدان من أجل صمود الخدمات الصحية. مجموعة من الأدوات والموارد المتاحة خلال فترة التعافي من حالة طوارئ صحية عامة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016. متاحة عبر الرباط الآتي: https://bit.ly/48ZI6EU.
- منظمة الصحة العالمية، المنظمة الدولية للمعوقين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، البعثة المسيحية للمكفوفين. فرق الطوارئ الطبية: المعايير التقنية الدنيا والتوصيات بشأن إعادة التأهيل. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/49hTaNl.
- منظمة الصحة العالمية، مؤسسة إصابات الحروب، المنظمة الدولية للرؤية العالمية. الإسعافات الأولية النفسية: دليل للعاملين الميدانيين. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2011. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3Ory6w6.
- منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. Herramienta de evaluación posdesastre de hospitales [تقييم حالة المستشفيات بعد وقوع الكوارث] [متاح حاليًا باللغة الإسبانية، وسيصدر قريبًا باللغة الإنجليزية]. واشنطن العاصمة: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ 2023. متاح عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/49wxxt3.
- منظمة الصحة العالمية، والبعثة المسيحية للمكفوفين (CBM)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. مذكرة إرشادية بشأن الإعاقة وإدارة المخاطر الصحية في حالات الطوارئ. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013. متاحة عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/42WonDY.

المراجع

1. Ravaghi H, Khalil M, Abrahams J, Sakr H, Samhouri D, Mataria A, et al. Strengthening hospital resilience in the Eastern Mediterranean Region. East Mediterr Health J. 2023;29(4):229–231. Available from: https://bit.ly/49rsBpf.
2. World Health Organization. Comprehensive Safe Hospital Framework. Geneva: WHO; 2015. Available from: https://bit.ly/4csMEWw.
3. Khalil M, Ravaghi H, Samhouri D, Abu J, Ali A, Sakr H, et al. What is "hospital resilience"? A scoping review on conceptualization, operationalization, and evaluation. Front Public Health. 2022 (10:1009400) Available from: https://bit.ly/3vpqovU.
4. World Health Organization. Summary report on the expert consultation on hospital resilience in the Eastern Mediterranean Region. East Mediterr Health J. 2023;29(1):73–74. Available from: https://bit.ly/3HAfSob.
5. Pan American Health Organization. Hospital Safety Index. Guide for Evaluators. Second edition. Washington, D.C.: PAHO; 2019. Available from: https://bit.ly/3HVdvwa.
6. Pan American Health Organization. PAHO makes progress in 13 countries with its "Hospitals Resilient to Health Emergencies and Disasters" initiative. Washington, D.C.: PAHO; 2023 [cited 19 March 2024]. Available from: https://bit.ly/49bcgF2.
7. Mansour W, Arjyal A, Hughes C, Gbaoh ET, Fouad FM, Wurie H, et al. Health systems resilience in fragile and shock-prone settings through the prism of gender equity and justice: implications for research, policy and practice. Confl Health. 2022;16(1):7. Available from: https://bit.ly/3INOtQa.
8. Pan American Health Organization. STAR-H: Strategic Toolkit for Assessing Risks in Health Facilities. Washington, D.C.: PAHO; 2023. Available from: https://bit.ly/4bjK0Su.
9. World Health Organization. Glossary of Health Emergency and Disaster Risk Management Terminology. Geneva: WHO; 2020. Available from: https://bit.ly/3IRcJRy.
10. Pan American Health Organization. Smart Hospitals Toolkit. Washington, D.C.: PAHO; 2017. Available from: https://bit.ly/3x1ophO.
11. Asian Disaster Preparedness Center. Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE) course syllabus. Bangkok: ADPC; [date unknown]. Available from: https://bit.ly/3Sjrhhf.
12. Pan American Health Organization. Principles of disaster mitigation in health facilities. Washington, D.C.: PAHO; 2000. Available from: https://bit.ly/4bbWqf0.
13. World Health Organization, World Bank. World Report on Disability 2011. Geneva: WHO; 2011. Available from: https://bit.ly/43uqbEm.

14. Pan American Health Organization. Disability Inclusion in Hospital Disaster Risk Management. Washington, D.C.: PAHO; 2018. Available from: https://bit.ly/49buxS5.

15. Pan American Health Organization. Smart Hospitals - Baseline Assessment Tool Workbook. Washington, D.C.: PAHO; 2020. Available from: https://bit.ly/47QRCcc.

16. World Health Organization. WHO guidance for climate-resilient and environmentally sustainable health care facilities. Geneva: WHO; 2020. Available from: https://bit.ly/4av5zOJ.

17. The Joint Commission. R3 Report: New and revised standards in emergency management. Oakbrook Terrace, IL: The Joint Commission; 2022. Available from: https://bit.ly/3vUtacF.

18. World Health Organization. WHO guidance for business continuity planning. Geneva: WHO; 2018. Available from: https://bit.ly/3TNRfLv.

19. World Health Organization. Health service continuity planning for public health emergencies: a handbook for health facilities. Geneva: WHO; 2021. Available from: https://bit.ly/3VqyvmF.

20. Pan American Health Organization, CARICOM, HRH Action Task Force. Policy Brief - Strengthening Human Resources for Health (HRH) to Respond to COVID-19 and Other Emerging Pandemics in the Caribbean. 27 November 2021. Washington, D.C.: PAHO; 2021. Available from: https://bit.ly/3vSFr1b.

21. World Health Organization. Minimum requirements for infection prevention and control programmes. Geneva: WHO; 2019. Available from: https://bit.ly/4arykM1.

22. Hanfling D, Hick JL, Stroud C, editors. Crisis Standards of Care: A Toolkit for Indicators and Triggers. Washington, D.C.: National Academies Press; 2013. Available from: https://bit.ly/3SeM7yg.

23. California Emergency Medical Services Authority. Hospital Incident Command System: Guidebook and appendices. [Rancho Cordova, CA]: California EMSA; 2014 . Available from: https://bit.ly/3vVg9Q3.

24. World Health Organization. Communicating risk in public health emergencies: a WHO guideline for emergency risk communication (ERC) policy and practice. Geneva: WHO; 2017. Available from: https://bit.ly/3x6s9ij.

الملحق 1

مسرد مصطلحات إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث

استُخلصت التعاريف الآتية للمصطلحات المرتبطة بإدارة مخاطر الكوارث من المنشور المعنون: منظمة الصحة العالمية. مسرد مصطلحات إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020.

الاستعراض اللاحق للإجراءات

هو عملية تبدأ بعد الانتهاء من التفعيل أو التشغيل أو التمرين، وتنطوي على مناقشة منظَّمة وميسَّرة لاستعراض ما كان ينبغي أن يحدث، وما حدث بالفعل، وأسباب حدوثه (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

نهج التصدي لكل الأخطار

هو نهج لإدارة الطيف الكامل للمخاطر والأحداث الطارئة، بناءً على إدراك أن هناك عناصر مشتركة وقدرات مشتركة لازمة لإدارة هذه المخاطر، ويشمل ذلك الاستجابات لجميع حالات الطوارئ تقريبًا.

ويجب العمل على تنمية قدرات مشتركة أو عامة يمكن تطبيقها على جميع المخاطر. وتُكمّل هذه القدرات العامة تدابيرُ محددة للخصائص الفريدة لكل خطر أو حدث. ومن خلال توحيد نظام الإدارة للتعامل مع العناصر المشتركة، تتولد قدرات أكبر إلى جانب التدابير المحددة للتعامل مع الخصائص الفريدة لكل حدث (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

إعادة البناء على نحو أفضل

استخدام مراحل التعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد وقوع الكارثة لزيادة قدرة البلدان والمجتمعات المحلية على الصمود من خلال دمج تدابير الحد من مخاطر الكوارث في إصلاح البنية الأساسية المادية والنظم المجتمعية، وفي إنعاش سبل العيش والاقتصادات والبيئة (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

خطة استمرارية تصريف الأعمال

وثيقة توضح كيف ستتمكن مؤسسة ما من الحفاظ على الوظائف والخدمات التشغيلية الحيوية واستعادتها إلى مستوى مقبول مُحدد مسبقًا في حالة وقوع حدث يعطل قدراتها التشغيلية (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

القدرة

الجمع بين جميع مواطن القوة والسمات والموارد المتاحة داخل مؤسسة أو مجتمع محلي أو مجتمع لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها، وتعزيز القدرة على الصمود.

تقييم القدرات

العملية التي تُستعرض من خلالها قدرات مجموعة أو مؤسسة أو مجتمع ما في ضوء الأهداف المرجوة، إذ تُحدّد القدرات الحالية للحفاظ عليها أو تعزيزها، وتُحدد الثغرات في القدرات لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

تنمية القدرات

العملية التي يقوم من خلالها الأشخاص والمؤسسات والمجتمع بتحفيز وتطوير قدراتهم بشكل منهجي بمرور الوقت لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تحسين المعرفة والمهارات والنظم والمؤسسات.

تغيُّر المناخ

تغير في حالة المناخ يمكن تحديده (على سبيل المثال باستخدام الاختبارات الإحصائية) من خلال التغيرات في متوسط خصائصه و/ أو تباينها، ويستمر لفترة طويلة تمتد عادة لعقود أو أطول (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2012).[3]

جلسة غير فورية لاستخلاص المعلومات

جلسة لاستخلاص المعلومات تُعقد بعد مرور فترة من الوقت عقب تمرين أو حدث لمناقشة أي ملاحظات وقضايا قد تكون قد أُغفلت أثناء المراجعة الفورية بعد الحدث، وذلك بالاستفادة من مفهوم الإدراك المؤخر (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1] ويُشار إليها أيضًا باسم «المراجعة غير الفورية».

القيادة

فعل الإدارة أو التوجيه أو الأمر أو السيطرة على الأمور بموجب سلطة صريحة قانونية أو تنظيمية أو مُفوَّضة. ويشمل المسمى المختصر الشائع «قيادة الأحداث»، اتخاذ القرارات، وتنفيذ الخطط لإدارة الحدث، والسيطرة على آثاره (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

التنسيق

العمليات الإدارية لضمان تكامل (وحدة) الجهود. ويتعلق التنسيق في المقام الأول بالموارد، ويعمل عموديًّا (داخل المؤسسة) بوصفه وظيفة تخضع لسلطة القيادة، وأفقيًّا (على مستوى المؤسسات) بوصفه وظيفة تخضع لسلطة الرقابة (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

النُّظم الحيوية (المستشفيات)

في المستشفى، تشمل النظم الحيوية: نظم الكهرباء، والاتصالات، وإمدادات المياه، والحماية من الحرائق، وإدارة النفايات، وتخزين الوقود والغازات الطبية، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ويمكن أن يؤدي تعطل النظم الحيوية أو توقفها إلى وقف عمل المستشفيات أو عرقلته (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

إزالة التلوث

إجراء تُتخَذ بموجبه تدابير صحية للقضاء على عامل مُعْد أو سام أو مادة مُعْدية أو سامة على سطح جسم إنسان أو حيوان، أو في أو على منتج مُعَدّ للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك وسائل النقل، مما قد يشكل خطرًا محدقًا بالصحة العامة (منظمة الصحة العالمية، 2010 «أ»).[4]

الإعاقة

قيد في مجال وظيفي ينشأ عن التفاعل بين القدرة الداخلية للشخص والعوامل البيئية والشخصية (منظمة الصحة العالمية 2011).[5]

الكارثة

اضطراب خطير في الأداء الوظيفي للمجتمع المحلي أو المجتمع كله على أي نطاق، بسبب أحداث خَطِرة تتفاعل مع ظروف التعرُّض والضعف والقدرة، مما يؤدي إلى واحد أو أكثر مما يأتي: خسائر وآثار بشرية ومادية واقتصادية وبيئية.

ملاحظة: قد يكون تأثير الكارثة فوريًّا وموضعيًّا، ولكنه غالبًا ما يكون واسع الانتشار، ويمكن أن يستمر لفترة طويلة من الزمن. وقد يختبر هذا التأثير أو يتجاوز قدرة المجتمع المحلي أو المجتمع على التأقلم باستخدام موارده الخاصة، وبالتالي قد يتطلب مساعدة من مصادر خارجية، والتي قد تشمل الاختصاصات المجاورة، أو تلك المتوافرة على المستويات الوطنية أو الدولية (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

إدارة الكوارث

تنظيم وتخطيط وتطبيق تدابير التأهب للكوارث، والاستجابة لها، والتعافي منها.

ملاحظة: قد لا تتفادى إدارة الكوارث التهديدات أو تقضي عليها تمامًا؛ فهي تركز على وضع وتنفيذ خطط التأهب وغيرها من الخطط للحد من أثر الكوارث و«إعادة البناء على نحو أفضل». وقد يؤدي الإخفاق في وضع خطة وتطبيقها إلى إلحاق الضرر بالأرواح والأصول وخسارة الإيرادات (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

الاستجابة للكوارث

الإجراءات التي تُتخذ مباشرةً قبل وقوع الكارثة أو أثناءها أو بعدها من أجل إنقاذ الأرواح والحد من الآثار الصحية وضمان السلامة العامة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمعيشة للأشخاص المتضررين (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

مخاطر الكوارث

الخسائر المحتمَلة في الأرواح أو الإصابات أو الأصول المدمَّرة أو المتضررة، التي يمكن أن تصيب نظامًا أو مجتمعًا محليًّا أو المجتمع كله، في فترة زمنية محددة، تُحدَّد احتماليًّا بوصفها دالةً للأخطار والتعرُّض والضعف والقدرة.

ملاحظة: يعكس تعريف مخاطر الكوارث مفهوم الأحداث والكوارث الخطرة بوصفها نتيجة لظروف خطر قائمة باستمرار. وتشمل مخاطر الكوارث أنواعًا مختلفة من الخسائر المحتملة التي يصعب في كثير من الأحيان قياسها كميًّا. ومع ذلك، فبمعرفة الأخطار السائدة وأنماط السكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يمكن تقييم مخاطر الكوارث ورسم خرائط لها، بوجه عام على الأقل. ومن المهم مراعاة السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث فيها مخاطر الكوارث، وأن الناس لا يشتركون بالضرورة في التصورات نفسها عن المخاطر وعوامل الخطر الأساسية (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2] ويمكن أن ينطبق هذا التعريف على «المخاطر» المرتبطة بالأحداث والطوارئ والكوارث الخطرة.

تقييم مخاطر الكوارث

نهج نوعي أو كمي لتحديد طبيعة مخاطر الكوارث ومداها عن طريق تحليل الأخطار المحتملة، وتقييم ظروف التعرض والضعف الحالية [والقدرات] التي يمكن لها، مجتمعة، أن تُلحِق الضرر بالناس والممتلكات والخدمات وسبل العيش والبيئة التي يعتمدون عليها.

ملاحظة: تشمل تقييمات مخاطر الكوارث الآتي: تحديد الأخطار؛ واستعراض الخصائص التقنية للأخطار مثل موقعها وشدتها وتواترها واحتماليتها؛ وتحليل التعرض والضعف، ويشمل ذلك الأبعاد المادية والاجتماعية والصحية والبيئية والاقتصادية؛ وتقييم فعالية القدرات السائدة والبديلة للتأقلم فيما يتعلق بسيناريوهات المخاطر المحتملة (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

إدارة مخاطر الكوارث

تطبيق سياسات واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث لمنع ظهور مخاطر جديدة للكوارث، والحد من مخاطر الكوارث الحالية، وإدارة المخاطر المتبقية، مما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود والحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

الحد من مخاطر الكوارث

أنشطة تهدف إلى منع مخاطر الكوارث الجديدة، والحد من المخاطر القائمة وإدارة المخاطر المتبقية، وجميعها تسهم في تعزيز القدرة على التكيف، وبالتالي في تحقيق التنمية المستدامة.

ملاحظة: الحد من مخاطر الكوارث هو أحد أهداف السياسات المعنية بإدارة مخاطر الكوارث، وتُحدَّد أغراضه وأهدافه في استراتيجيات وخطط الحد من مخاطر الكوارث (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

نظام الإنذار المبكر

نظام متكامل لرصد الأخطار والتنبؤ بها وتوقعها، وتقييم مخاطر الكوارث، ونظم وعمليات أنشطة التواصل والتأهب التي تُمكِّن الأفراد والمجتمعات المحلية والحكومات والأعمال التجارية وغيرها من اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب للحد من مخاطر الكوارث قبل وقوع الأحداث الخطرة.

الطوارئ

نوع من الحدث أو التهديد الوشيك ينجم عنه أو يُحتمل أن ينتج عنه مجموعة من العواقب، ويتطلب اتخاذ إجراءات منسقة، والتي عادة ما تكون عاجلة وغير روتينية في كثير من الأحيان.

الفريق الطبي في حالات الطوارئ

مجموعات من المهنيين الصحيين (الأطباء، والممرضين، والمساعدين الطبيين، وغيرهم) الذين يعالجون المرضى المتضررين من حالة طوارئ أو كارثة.

مركز عمليات الطوارئ

المرفق الذي تنسق منه السلطة أو الوكالة استجابتها للطوارئ/ الكوارث الرئيسية (منظمة الصحة العالمية 2015 «ب»).[6]

خطة الاستجابة للطوارئ

وثيقة تصف كيف ستدير وكالة أو مؤسسة استجاباتها لحالات الطوارئ بأنواعها المختلفة.

ملاحظة: تقدم الخطة وصفًا للأهداف والسياسة ومفهوم العمليات للاستجابة لحالة طوارئ؛ وهيكل وسلطات ومسؤوليات الاستجابة المنهجية والمنسقة والفعالة. وفي هذا السياق، فإن خطط الطوارئ تكون خاصة بكل وكالة أو سلطة، وتوضح بالتفصيل الموارد والقدرات والإمكانات التي ستوظفها هذه السلطة أو الوكالة أو المؤسسة في استجابتها (منظمة الصحة العالمية 2017 «أ»).[7]

الإجلاء

نقل الأشخاص والأصول مؤقتًا إلى أماكن أكثر أمانًا قبل وقوع حدث خطر أو أثناءه أو بعده من أجل حمايتهم/ حمايتها.

ملاحظة: تشير خطط الإجلاء إلى الترتيبات المُقررة سلفًا لتمكين انتقال الأشخاص والأصول مؤقتًا إلى أماكن أكثر أمانًا قبل وقوع حدث خطر أو أثناءه أو بعده. وقد تتضمن خطط الإجلاء خططًا لعودة الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم وخيارات لتوفير المأوى (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

التمرين

التمرين هو شكل من أشكال الممارسة أو التدريب أو الرصد أو التقييم للقدرات، وينطوي على وصف لحالة طوارئ أو محاكاة لها، والتي يُقدَّم وصف أو محاكاة لطريقة الاستجابة لها (منظمة الصحة العالمية 2017 «ج»).[8]

ملاحظة: تساعد التمارين على تحديد مؤشر صحيح لأداء النظام في المستقبل في ظل ظروف معينة، وتحديد التحسينات المحتملة للنظام (منظمة الصحة العالمية، 2015 «ب»).[6]

التمرين الواسع النطاق

تمرين يحاكي حدثًا حقيقيًا بأكبر قدرٍ ممكن من الواقعية، وهو مُصمَّم لتقييم القدرة التشغيلية لنُظُم إدارة الطوارئ في بيئة صعبة للغاية، ومحاكاة ظروف الاستجابة الفعلية، وتشمل حشد ونقل الموظفين المعنيين بحالة الطوارئ والمعدات والموارد اللازمة لإدارتها.

ملاحظة: الغرض من التمرين الواسع النطاق هو اختبار/ تقييم معظم وظائف خطة الطوارئ بأكبر قدرٍ ممكنٍ من الواقعية. ومن الناحية المثالية، يعمل التمرين الواسع النطاق على اختبار وتقييم معظم وظائف خطة إدارة حالات الطوارئ أو الخطة التشغيلية. ويختلف التمرين الواسع النطاق عن التمرين الوظيفي، إذ ينطوي الأول عادةً على إشراك وكالات متعددة ومشاركين منتشرين فعليًا في موقع ميداني (منظمة الصحة العالمية، 2017 «ج»).[8]

التمرين الوظيفي

تمرين محاكاة تفاعلي كامل يختبر قدرة المؤسسة على الاستجابة لحدث تُجرى محاكاته. ويختبر هذا التمرين وظائف متعددة من تلك الواردة في الخطة التشغيلية للمؤسسة.

ملاحظة: يتمثل الغرض من التمرين الوظيفي في اختبار قدرة الاستجابة الخاصة بوظائف أو أقسام محددة في مؤسسة ما على مواجهة حالة ما في موقف واقعي مضغوط زمنيًا أو التحقق من هذه القدرة. ويركز التمرين الوظيفي على التنسيق والتكامل والتفاعل بين سياسات المؤسسة وإجراءاتها وأدوارها ومسؤولياتها قبل الحدث الجاري محاكاته أو أثناءه أو بعده (منظمة الصحة العالمية، 2017 «ج»).[8]

الخطر

عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري قد يُسبِّب خسائرَ في الأرواح، أو إصاباتٍ، أو آثارًا صحية أخرى، أو إضرارًا بالممتلكات، أو اضطرابات اجتماعية واقتصادية، أو تدهورًا بيئيًا. وهو مصدر للضرر المحتمل (أيزو 22300:2018).[9]

ملاحظة: قد يشمل هذا الخاصية الكامنة أو القدرة المتأصلة لأحد العوامل أو المواد مما يؤدي إلى إحداث آثار ضارة للناس أو البيئة في ظل ظروف التعرض (الجمعية العامة للأمم المتحدة 2016، منظمة الصحة العالمية، 2009).[2، 10]

النظام الصحي

تنظيم الأشخاص والمؤسسات والموارد معًا طبقًا لسياسات معتمدة من أجل تحسين صحة السكان المستفيدين من الخدمات المقدمة، مع الاستجابة في الوقت نفسه لتوقعات الناس المشروعة وحمايتهم من تكاليف اعتلال الصحة عن طريق مجموعة شتى من الأنشطة تهدف أساسًا إلى تحسين الصحة (منظمة الصحة العالمية، 2011).[5]

جلسة فورية لاستخلاص المعلومات

جلسة لاستخلاص المعلومات تُعقد بعد التمرين أو الحدث مباشرةً لتحديد نقاط القوة والضعف في الخطط والسياسات والإجراءات.

ملاحظة: في الجلسة الفورية لاستخلاص المعلومات، يقدم المشاركون وفريق إدارة التمرين ملاحظات فورية أو يعرضون حدثًا تُستخلص منه المعلومات. ويتبادل الأفراد وجهات النظر حول نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين، التي أُدرجت في تقرير التمرين (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»، منظمة الصحة العالمية، 2017 «ج»).[1،8] ويُشار إليها في بعض الأحيان باسم «المراجعة الفورية».

الحدث

إجراء أو حادث أو ظاهرة قد ينجم عنه أو عنها خسائر في الأرواح، أو إصابات، أو إضرار بالممتلكات، أو اضطرابات اجتماعية واقتصادية، و/ أو تدهور بيئي (منظمة الصحة العالمية، 2015 «ب»).[6]

خطة عمل الأحداث

هي بيان المقصد الخاص بحدث معين. وتتضمن الخطة تفاصيل استراتيجيات الاستجابة وأهدافها، بالإضافة إلى الموارد التي يتعين توظيفها، والإجراءات التكتيكية الواجب اتخاذها (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

نظام إدارة الأحداث

نظام يُحدد أدوار العاملين ومسؤولياتهم، وإجراءات التشغيل التي يتعيَّن استخدامها في إدارة الأحداث (أيزو 22300:2018).[9]

الوقاية من العدوى ومكافحتها

مجموعة عملية ومجربة من النُّهُج والتدابير التنظيمية والتقنية لمنع انتشار حالات العدوى التي يمكن توقيها ومقاومة مضادات الميكروبات داخل المجتمع المحلي ومواقع الرعاية الصحية على حد سواء (منظمة الصحة العالمية، 2019 «ج»).[11]

الدروس المستفادة

المشاكل المُحددة التي يمكن اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها من أجل تحسين الأداء (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

اللوجستيات

أحد جوانب إدارة الطوارئ (المخاطر) المعنية بتدبير الموارد المادية والبشرية وتوزيعها والحفاظ عليها واستبدالها وإعادتها، ويشمل ذلك توفير البنْية الأساسية والخدمات الداعمة للموظفين العاملين في مجال الاستجابة (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

أحداث الإصابات الجماعية

حدث ينجم عنه عددٌ من المرضى في وقت واحد أكبر مما يمكن أن تستوعبه الموارد المتاحة محليًّا باستخدام الإجراءات الروتينية.

ملاحظة: يتطلب هذا النوع من الأحداث ترتيبات طارئة استثنائية ومساعدة إضافية أو استثنائية (منظمة الصحة العالمية، 2007).[12]

الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي

أي نوع من أنواع الدعم المحلي أو الخارجي الذي يهدف إلى حماية العافية النفسية الاجتماعية أو تعزيزها و/ أو الوقاية من الاضطرابات النفسية أو علاجها.

ملاحظة: جرت العادة على استخدام الرعاية الصحية النفسية من قِبَل المهنيين الصحيين لوصف التدخلات المتخصصة لعلاج الأفراد الذين شُخِّصوا بحالات صحية نفسية. والدعم النفسي الاجتماعي والتدخلات النفسية الاجتماعية مصطلحان يستخدمهما نطاق أوسع من العاملين في مجال الاستجابة للطوارئ للإشارة إلى الأنشطة التي تدعم الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات ككل بدلًا من التركيز بوجهٍ خاص على علاج حالات الصحة النفسية (اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، 2007).[13]

التخفيف

تقليل الآثار الضارة للأخطار والكوارث ذات الصلة أو الحد منها.

ملاحظة: في كثير من الأحيان، لا يمكن منع الآثار الضارة للأخطار، ولا سيما الأخطار الطبيعية، منعًا كاملًا، ولكن يمكن التقليل إلى حدٍّ كبيرٍ من حجمها أو وخامتها باستراتيجيات وإجراءات مختلفة. وتشمل تدابير التخفيف التقنيات الهندسية والأبنية المقاومة للأخطار، فضلًا عن تحسين السياسات البيئية والاجتماعية والوعي العام. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار سياسة تغير المناخ، يُعرَّف «التخفيف» بشكل مختلف، وهو المصطلح المستخدم للإشارة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تُعدُّ مصدر تغير المناخ (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

اتفاقات المساعدة المتبادلة

اتفاق تفاهم مُرتَّب مسبقًا بين كيانين أو أكثر لتقديم المساعدة بعضهما لبعض (أيزو 22300:2018).[9]

الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث

الوكالة الحكومية الوطنية المسؤولة عن تنسيق سياسات وممارسات إدارة الكوارث أو الطوارئ.

ملاحظة: لا يوجد تعريف مشترك لهذه الوكالة أو المؤسسة، نظرًا لاختلاف مسميات المهام ونطاقها من بلد إلى آخر، وعادةً ما تعرفها التشريعات أو السياسات الوطنية. المرادفات: المؤسسة الوطنية لإدارة الكوارث، والوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ.

الأخطار الطبيعية

الأخطار التي تقترن غالبًا بالعمليات والظواهر الطبيعية (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

معدات الوقاية الشخصية

الملابس الواقية (العباءات، والقفازات، والأحذية الطويلة الساق، وما إلى ذلك) والمعدات (الكمامات، والواقيات، وأقنعة التنفس، وسدادات الأذن، وما إلى ذلك) اللازمة لحماية الشخص أو عزله عن التعرض البيولوجي والكيميائي والفيزيائي والصوتي والحراري (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

الأشخاص ذوو الإعاقة

كل مَن يعانون من عاهات طويلة الأجل؛ بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين (الأمم المتحدة، 2006).[14]

التأهب

المعرفة والقدرات التي تطورها الحكومات ومؤسسات الاستجابة والتعافي والمجتمعات المحلية والأفراد، بهدف توقُّع آثار الكوارث المُرجَّحة أو الوشيكة أو الحالية والاستجابة لها والتعافي منها بفاعلية.

ملاحظة: تُنفَّذ إجراءات التأهب في سياق إدارة مخاطر الكوارث، وتهدف إلى بناء القدرات اللازمة لإدارة جميع أنواع الطوارئ بكفاءة وتنفيذ انتقالات منظمة من الاستجابة إلى التعافي المستدام. ويستند التأهب إلى تحليل سليم لمخاطر الكوارث وروابط جيدة مع نظم الإنذار المبكر، ويشمل أنشطة من قبيل التخطيط الاحترازي، وتخزين المعدات والإمدادات، وإعداد ترتيبات للتنسيق والإجلاء والإعلام، وما يرتبط بذلك من تدريب وتمارين ميدانية. ويجب أن يكون هذا مدعومًا بقدرات رسمية مؤسسية وقانونية ومتعلقة بالميزانية.

الوقاية

الأنشطة والتدابير الرامية إلى تجنب مخاطر الكوارث القائمة والجديدة.

ملاحظة: تعبر الوقاية (أي الوقاية من الكوارث) عن مفهوم ومقصد تجنب الآثار الضارة المحتملة للأحداث الخطرة تجنبًا تامًّا. وفي حين أنه لا يمكن القضاء على بعض مخاطر الكوارث، فإن الوقاية تهدف إلى الحد من الضعف والتعرض في السياقات التي يُزال فيها خطر الكوارث نتيجة لذلك. ومن الأمثلة على هذا السدود أو السدود الترابية التي تقضي على مخاطر الفيضانات، ولوائح استخدام الأراضي التي لا تسمح بأي استيطان في المناطق الشديدة الخطورة، والتصميمات الهندسية المقاومة للزلازل التي تكفل مقاومة المباني الحيوية واستمرار عملها أثناء أي زلزال محتمل، والتحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ويمكن كذلك اتخاذ تدابير وقائية أثناء أو بعد وقوع حدث خطر أو كارثة لمنع الأخطار الثانوية أو عواقبها، مثل تدابير منع تلوث المياه (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

الاستعداد

القدرة على الاستجابة السريعة والمناسبة عند الحاجة (الجمعية العامة للأمم المتحدة 2016).[2]

إعادة البناء

إعادة البناء على المديين المتوسط والطويل والاستعادة المستدامة للبنى الأساسية والخدمات والإسكان والمرافق وسبل العيش الحيوية القادرة على الصمود واللازمة لتأدية وظائف المجتمع المحلي أو المجتمع المتضرر من كارثة على أكمل وجه، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة والبناء و«إعادة البناء على نحو أفضل»، لتجنب مخاطر الكوارث في المستقبل أو الحد منها (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

التعافي

استعادة أو تحسين سبل العيش والصحة، وكذلك الأصول والنظم والأنشطة الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمجتمع المحلي أو المجتمع المتضرر من الكوارث، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة و«إعادة البناء على نحو أفضل» لتجنب مخاطر الكوارث في المستقبل أو الحد منها (الجمعية العامة للأمم المتحدة 2016).[2]

إعادة التأهيل

استعادة الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لعمل المجتمع المحلي أو المجتمع المتضرر من كارثة (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

وكذلك استعادة الأداء الطبيعي للأشخاص والمجتمعات المحلية (منظمة الصحة العالمية، 2009).[10]

القدرة على الصمود

قدرة النظام أو المجتمع المحلي أو المجتمع المُعرض للأخطار على مقاومة آثار الأخطار التي قد يتعرَّض لها واستيعابها والتأقلم والتكيف معها وتحويلها والتعافي منها في الوقت المناسب وعلى نحو يتسم بالكفاءة، بوسائل منها الحفاظ على هياكله ووظائفه الأساسية الضرورية، وإعادتها إلى ما كانت عليه من خلال إدارة المخاطر (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

الاستجابة

توفير خدمات الطوارئ والمساعدة العامة أثناء وقوع الكارثة أو بعدها مباشرة من أجل إنقاذ الأرواح، والحد من الآثار الصحية وضمان السلامة العامة، وتلبية احتياجات المعيشة الأساسية للأشخاص المتضررين.

ملاحظة: تركز الاستجابة للكوارث في الغالب على الاحتياجات الفورية والقصيرة الأجل، وتسمى أحيانًا الإغاثة في حالات الكوارث. وتعتمد الاستجابة الفعالة والمتسمة بالكفاءة وحُسن التوقيت على تدابير التأهب المسترشدة بمخاطر الكوارث، وتشمل تنمية قدرات الاستجابة لدى الأفراد والمجتمعات المحلية والمؤسسات والبلدان والمجتمع الدولي. وكثيرًا ما تشمل العناصر المؤسسية للاستجابة توفير خدمات الطوارئ والمساعدة العامة من جانب القطاعين العام والخاص والقطاعات المجتمعية، فضلًا عن مشاركة المجتمع المحلي والمتطوعين. و«خدمات الطوارئ» هي مجموعة بالغة الأهمية من الوكالات المتخصصة التي تضطلع بمسؤوليات محددة في خدمة وحماية الأشخاص والممتلكات في حالات الطوارئ والكوارث. وتشمل سلطات الحماية المدنية والشرطة وخدمات الإطفاء، من بين جهات أخرى كثيرة. ولا يوجد خط فاصل واضح بين مرحلة الاستجابة ومرحلة التعافي اللاحقة. وقد تمتد بعض إجراءات الاستجابة، مثل توفير السكن المؤقت وإمدادات المياه، إلى مرحلة التعافي لفترة طويلة نوعًا ما (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

خطة الاستجابة

توثيق عملية جمع الإجراءات والمعلومات التي يجري وضعها وتجميعها والحفاظ على جاهزيتها للاستخدام في حالة وقوع أي حادث (أيزو 22300:2018).[9]

التحديث

تعزيز أو تحديث الهياكل القائمة لتصبح أكثر مقاومة وقدرة على الصمود أمام الآثار الضارة للأخطار.

ملاحظة: يتطلب التحديث النظر في تصميم الهيكل ووظيفته، والضغوط التي قد يتعرض لها الهيكل جراء أخطار أو سيناريوهات أخطار معينة، وإمكانية تنفيذ مختلف خيارات التحديث من الناحية العملية وتكلفتها. ومن أمثلة التحديث: إضافة دعامات لتقوية الجدران، وتعزيز الأعمدة، وإضافة روابط فولاذية بين الجدران والأسقف، وتركيب مصاريع على النوافذ، وتحسين حماية المرافق والمعدات المهمة (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

المخاطر

الخسائر المحتمَلة في الأرواح أو الإصابات أو الأصول المدمَّرة أو المتضررة، التي يمكن أن تصيب نظامًا أو مجتمعًا محليًّا أو المجتمع كله، في فترة زمنية محددة، تُحدَّد احتماليًّا بوصفها دالةً للأخطار والتعرُّض والضعف والقدرة. (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

تحليل المخاطر

عملية فهم طبيعة المخاطر وتحديد مستواها (أيزو 22300:2018).[9]

تقدير المخاطر

عملية تحديد المخاطر التي يجب أن توضع على رأس أولويات إدارة المخاطر من خلال الجمع بين عمليات تحديد المخاطر، وتحليل المخاطر، وتقييم مستوى المخاطر في ضوء معايير محددة سلفًا أو أهداف أو مخاطر أو معايير أخرى.

ملاحظة: تشمل تقديرات المخاطر استعراض الخصائص التقنية للأخطار؛ وتحليل أوجه التعرض والضعف، وتقييم فعالية قدرات التأقلم السائدة فيما يتعلق بسيناريوهات المخاطر المحتملة (منظمة الصحة العالمية، 2015 «ب»).[6]

التواصل بشأن المخاطر

التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء بشأن الأخطار والمخاطر والعوامل المرتبطة بالمخاطر (منظمة الصحة العالمية، 2015 "ب").[6] ويلزم توافر قدرات الاتصال المطلوبة خلال مراحل الوقاية من أحداث الصحة العامة الخطيرة والتأهب والاستجابة لها والتعافي منها لتشجيع اتخاذ قرارات مستنيرة، وإحداث تغيير إيجابي في السلوك، والحفاظ على الثقة (منظمة الصحة العالمية، 2018 "أ").[15]

ملاحظة: ينبغي أن يكون التواصل بشأن المخاطر عملية تفاعلية ثنائية الاتجاه، يتبادل خلالها الخبراء وغير الخبراء المفاهيم المتعلقة بكل من القيم والتفضيلات العلمية والمجتمعية ويتفاوضون بشأنها (منظمة الصحة العالمية، 2009).[10]

المستشفى الآمن

مرفق تظل خدماته متاحة، ويعمل بأقصى طاقته، وضمن البنية الأساسية نفسها قبل ظهور أثر حالات الطوارئ والكوارث وخلالها وبعدها مباشرةً (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

الإلمام بالوضع

الإلمام بما يحدث في بيئة معينة في وقت معين والانتباه إليه، مع التركيز بشكل خاص على تأثير التغييرات في البيئة؛ أي معرفة كيفية تطور حادث أو حدث ما (منظمة الصحة العالمية، 2015 «أ»).[1]

الزيادة المفاجئة

الطلب المفاجئ على الخدمات الصحية في حوادث الإصابات الجماعية التي تتطلب قدرات إضافية (من حيث عدد الأفراد أو المعدات أو الإمدادات) و/ أو القدرات (من حيث الخبرة المتخصصة) (منظمة الصحة العالمية، 2007).[12]

القدرة على تلبية الاحتياجات المفاجئة

قدرة المؤسسات مثل العيادات أو المستشفيات أو مختبرات الصحة العامة على الاستجابة لتزايد الطلب على خدماتها خلال حالات طوارئ الصحة العامة (منظمة الصحة العالمية، 2015 «ب»).[6]

الترصُّد

الجمع المنهجي والمستمر للبيانات ومقارنتها وتحليلها لأغراض الصحة العامة ونشر معلومات الصحة العامة في الوقت المناسب بهدف التقييم وتنفيذ الاستجابة في مجال الصحة العامة، حسب الاقتضاء (منظمة الصحة العالمية، 2010 «أ»، منظمة الصحة العالمية، 2016).[4، 16]

التنمية المستدامة

التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المُقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة (منظمة الصحة العالمية، 1998).[17]

تمرين المحاكاة النظري

مناقشة ميسّرة تستخدم سيناريو محاكاة تدريجي، جنبًا إلى جنب مع سلسلة من الإدخالات المعلوماتية، لجعل المشاركين ينظرون في تأثير حالة طوارئ محتملة على الخطط والإجراءات القائمة والقدرات الحالية.

ملاحظة: يحاكي تمرين المحاكاة النظري حالة طوارئ في بيئة غير رسمية خالية من الضغوط. فتمرين المحاكاة النظري هو مناقشة حول سيناريو أو سردية التمرين يوجهها مُيسِّر حالة الطوارئ، وهو مُصمم بحيث يؤدي إلى إثارة نقاش بناء بين المشاركين؛ وتحديد المشاكل وحلها وتحسين الخطط التنفيذية القائمة؛ (منظمة الصحة العالمية، 2017 «أ»، منظمة الصحة العالمية، 2017 «ج»).[7، 8]

أوجه الضعف

الظروف التي تحددها عوامل مادية واجتماعية واقتصادية وبيئية أو العمليات التي تزيد من استعداد الفرد أو المجتمع المحلي أو الأصول أو النظم للتأثر بتداعيات الأخطار (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2016).[2]

الفئات المستضعفة

الأفراد الذين يشتركون في سمة واحدة أو عدة سمات تُشكل أساس التمييز أو الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الصحية السلبية التي تتسبب في افتقارهم إلى الوسائل اللازمة لنيل حقوقهم أو التمتع بفرص متساوية (أيزو 22300:2018).[9]

مراجع الملحق 1

1 World Health Organization. Framework for a Public Health Emergency Operations Centre. Geneva: WHO; 2015. Available from: https://bit.ly/4aaY2ET.

2 United Nations General Assembly. Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction. Note by the Secretary-General. (A/71/644). New York: United Nations; 2016. Available from: https://bit.ly/4arHnwI.

3 Intergovernmental Panel on Climate Change. Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. A special report of working groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field CB, Barros V, Stocker TF, Qin D, Dokken DJ, Ebi KL, et al., editors]. Cambridge: Cambridge University Press; 2012. Available from: https://bit.ly/4a4xcOR.

4 World Health Organization. Protocol for assessing national surveillance and response capacities for the International Health Regulations (2005). Geneva: WHO; 2010 [cited 29 April 2019].

5 World Health Organization. Health systems strengthening: glossary. Geneva: WHO; 2011. Available from: https://bit.ly/4cqbdTT.

6 World Health Organization. Public health for mass gatherings: Key considerations. Geneva: WHO; 2015. Available from: https://bit.ly/497CAzs.

7 World Health Organization. Emergency response framework (ERF). Geneva: WHO; 2017. Available from: https://bit.ly/3TxA6Er.

8 World Health Organization. WHO simulation exercise manual: a practical guide and tool for planning, conducting and evaluating simulation exercises for outbreaks and public health emergency preparedness and response. Geneva: WHO; 2017.
Available from: https://bit.ly/4ctuS5q.

9 International Organization for Standardization. ISO 22300:2018. Security and resilience: vocabulary. Geneva: ISO; 2018. Available from: https://bit.ly/3vrlSgt.

10 World Health Organization. The public health management of chemical incidents. Geneva: WHO; 2009. Available from: https://bit.ly/3VCXvaa.

11 World Health Organization. Infection prevention and control. Geneva: WHO; 2019 [cited 29 April 2019]. Available from: https://bit.ly/49bDISm.

12 World Health Organization. Mass casualty management systems: strategies and guidelines for building health sector capacity. Geneva: WHO; 2007.
Available from: https://bit.ly/3TLS2fY.

13 Inter-Agency Standing Committee. IASC guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings. Geneva: IASC; 2007.
Available from: https://bit.ly/43sUH1v.

14 United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York: United Nations; 2006 [accessed 29 April 2019]. Available from: https://bit.ly/3Tufm0s.

15 World Health Organization. Joint external evaluation tool: International Health Regulations (2005). Second edition. Geneva: WHO; 2018.
Available from: https://bit.ly/3IOVHTV.

16 World Health Organization. International Health Regulations 2005. Third edition. Geneva: WHO; 2016. Available from: https://bit.ly/4a3s8dt.

17 World Health Organization. Health promotion glossary. Geneva: WHO; 1998.
Available from: https://bit.ly/3x5MRPc.

تؤكد الإرشادات الواردة في هذا المنشور على كيفية دمج الإجراءات الرئيسية في النظم التشغيلية الروتينية للمستشفى ووظائفه وخدماته على نحو يعزز كيفية تأهب المرفق لطائفة من الأخطار والاستجابة لها والتعافي منها، ومنها الأوبئة والجوائح، مع إعادة البناء على نحو أفضل. وقد قُدمت هذه المعلومات ليستخدمها مديرو المستشفيات، ورؤساء الأقسام فيها، وأعضاء لجان إدارة الطوارئ بها، ويشمل ذلك خدمات الدعم والإدارة، والسلطات المالية والصحية المسؤولة عن تخطيط وتنسيق إدارة مخاطر الطوارئ الصحية والكوارث في المرافق الصحية.

PAHO
Pan American Health Organization
World Health Organization
Americas Region

منظمة الصحة العالمية
إقليم شرق المتوسط

9 789292 747732